Especialidad: Cirugía

Tema: Fx de brazo (Patología de Extremidad Superior)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Masculino de 28 años ingresa a urgencias tras sufrir una caída de su propia altura con apoyo sobre la mano derecha extendida. A la exploración física, presenta dolor intenso, deformidad evidente y aumento de volumen en el tercio medio del brazo derecho. A la evaluación neurológica, el paciente es incapaz de extender la muñeca derecha y presenta pérdida de sensibilidad en el dorso de la mano.

Pregunta 1

¿Qué estructura nerviosa se encuentra con mayor probabilidad lesionada debido a la localización de la fractura?

A) Nervio cubital

B) Nervio radial *

C) Nervio mediano

D) Nervio musculocutáneo

Pregunta 2

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que explica la "mano péndula" (incapacidad para extender la muñeca) en este paciente?

A) Lesión del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo.

B) Lesión del nervio radial a nivel del canal de torsión del húmero. *

C) Atrapamiento del nervio cubital en la epitróclea.

D) Ruptura del tendón del músculo bíceps braquial.

Retroalimentación:

La fractura de la diáfisis humeral (tercio medio) se asocia frecuentemente con la lesión del nervio radial, ya que este nervio discurre íntimamente pegado al hueso a través del canal espiral (canal de torsión). El nervio radial inerva los músculos extensores del antebrazo y la mano, por lo que su lesión produce la clásica "mano caída" o péndula, además de alteraciones sensitivas en el dorso de la mano.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Esquizofrenia (Psiquiatría)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 22 años es llevado a consulta por sus familiares, quienes refieren que desde hace 8 meses el paciente se ha aislado socialmente, ha dejado la universidad y presenta un aplanamiento afectivo importante. En las últimas 6 semanas, el paciente afirma escuchar voces que comentan sus acciones y está convencido de que una agencia gubernamental lo vigila a través del televisor.

Pregunta 1

De acuerdo con la sintomatología descrita, ¿cuáles de los siguientes representan los síntomas "positivos" de su enfermedad?

A) Aplanamiento afectivo y aislamiento social.

B) Alucinaciones auditivas y delirios de persecución. *

C) Abandono escolar y falta de motivación (abulia).

D) Pobreza en el lenguaje (alogia) y anhedonia.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea recomendado para el manejo de la fase aguda de esta patología?

A) Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS).

B) Antipsicóticos atípicos (ej. Risperidona, Olanzapina). *

C) Benzodiacepinas de acción prolongada.

D) Estabilizadores del estado de ánimo (ej. Litio).

Retroalimentación:

La esquizofrenia se diagnostica cuando los síntomas persisten por más de 6 meses (incluyendo la fase prodrómica, activa y residual). Los síntomas positivos (que se "añaden" a la psique normal) incluyen delirios y alucinaciones, mientras que los negativos (lo que se "pierde") incluyen abulia, alogia y aplanamiento afectivo. Los antipsicóticos atípicos son de primera elección por su menor perfil de efectos secundarios extrapiramidales en comparación con los típicos.

Especialidad: Pediatría

Tema: Reflujo vesicoureteral (Uropedia)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Niña de 3 años de edad es evaluada en la consulta externa por presentar su tercer episodio de infección de vías urinarias (IVU) febril documentada con urocultivo positivo a E. coli. El ultrasonido renal reporta dilatación del sistema pielocalicial derecho (hidronefrosis leve) sin evidencia de litiasis o masas.

Pregunta 1

Ante la sospecha de una alteración anatómica predisponente, ¿cuál es el estudio de imagen de elección (estándar de oro) para confirmar y clasificar el reflujo vesicoureteral?

A) Gammagrama renal con DMSA.

B) Cistouretrografía miccional seriada (CUMS). *

C) Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis.

D) Resonancia magnética de vías urinarias.

Pregunta 2

Si el estudio confirma un reflujo grado II (el contraste alcanza el sistema pielocalicial pero sin causar dilatación), ¿cuál es el manejo inicial más adecuado según las guías clínicas actuales?

A) Reimplantación ureteral quirúrgica de urgencia.

B) Observación, profilaxis antibiótica nocturna y seguimiento. *

C) Inyección endoscópica de agentes formadores de volumen de forma inmediata.

D) Nefrectomía parcial.

Retroalimentación:

Las IVU febriles de repetición en niños obligan a descartar alteraciones anatómicas, siendo el reflujo vesicoureteral (RVU) la más común. La cistouretrografía miccional seriada (CUMS) es el único estudio que permite ver el reflujo en tiempo real y clasificarlo del grado I al V. Los grados leves a moderados (I a III) suelen resolverse espontáneamente con el crecimiento, por lo que el manejo inicial es médico (profilaxis) para prevenir cicatrices renales.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Parkinson (Trastornos del Movimiento / Enf. Neurodegenerativas)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 65 años es traído a consulta por presentar lentitud progresiva para realizar sus actividades diarias, dificultad para levantarse de la silla y una marcha a pasos cortos sin braceo. A la exploración física, se observa temblor de reposo en la mano derecha ("cuenta monedas"), rigidez muscular en rueda dentada y una facies inexpresiva (hipomimia).

Pregunta 1

¿Cuál es la alteración neuropatológica principal que caracteriza a esta enfermedad?

A) Pérdida de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra pars compacta. *

B) Degeneración de las motoneuronas superiores e inferiores.

C) Desmielinización de la sustancia blanca periventricular.

D) Atrofia severa del núcleo caudado.

Pregunta 2

¿Cuál es el fármaco de elección que actúa como precursor dopaminérgico y es considerado el más eficaz para el tratamiento de los síntomas motores en esta etapa?

A) Pramipexol.

B) Levodopa asociada a Carbidopa. *

C) Biperideno.

D) Selegilina.

Retroalimentación:

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la tétrada clásica: temblor de reposo, bradicinesia, rigidez y alteraciones de los reflejos

posturales. La base fisiopatológica es la deficiencia de dopamina en los ganglios basales. La Levodopa (precursor de la dopamina) cruzando la barrera hematoencefálica, combinada con Carbidopa (inhibidor de la descarboxilasa periférica que evita la degradación temprana del fármaco), sigue siendo el estándar de oro del tratamiento sintomático.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Consultas prenatales (Control Prenatal)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 25 años, primigesta, acude a su primera consulta de control prenatal cursando un embarazo de 8 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Es una paciente sana, sin antecedentes médicos de importancia, con un índice de masa corporal (IMC) de 22. Refiere náuseas matutinas ocasionales.

Pregunta 1

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana y la Guía de Práctica Clínica, ¿cuál es la dosis profiláctica de ácido fólico recomendada para esta paciente con riesgo bajo de defectos del tubo neural?

A) 0.4 mg (400 mcg) diarios. *

B) 4 mg diarios.

C) 5 mg diarios.

D) 10 mg semanales.

Pregunta 2

¿Qué batería de estudios de laboratorio rutinarios debe solicitarse de forma obligatoria en esta primera visita prenatal del primer trimestre?

A) Biometría hemática, química sanguínea de 6 elementos y perfil tiroideo completo.

B) Grupo y Rh, biometría hemática, glucosa en ayuno, VDRL, prueba rápida de VIH y examen general de orina. *

C) Curva de tolerancia a la glucosa de 75 g, urocultivo y exudado vaginal.

D) Papanicolaou, colposcopia y marcadores tumorales ováricos.

Retroalimentación:

El control prenatal adecuado exige iniciar la suplementación de ácido fólico de preferencia desde 3 meses antes del embarazo; la dosis para mujeres sin factores de riesgo (como antecedente de hijo con defecto del tubo neural o uso de anticonvulsivantes) es de 0.4 mg/día. Los laboratorios de primera vez buscan descartar anemia, diabetes pregestacional, infecciones asintomáticas de vías urinarias (principal causa de parto pretérmino) y enfermedades de transmisión vertical (sífilis y VIH).

Especialidad: Cirugía

Tema: Quemaduras (Quemaduras / Golpe de Calor / Hipotermia)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 35 años y 70 kg de peso ingresa a urgencias tras sufrir quemaduras térmicas por flama en un incendio domiciliario. A la exploración física se observan quemaduras de segundo grado superficial y profundo que abarcan la totalidad del tronco anterior (pecho y abdomen) y la totalidad del miembro superior derecho. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable pero con dolor intenso.

Pregunta 1

De acuerdo con la regla de los 9 de Wallace, ¿cuál es el porcentaje de Superficie Corporal Quemada (SCQ) en este paciente?

A) 18%

B) 27% *

C) 36%

D) 45%

Pregunta 2

Utilizando la fórmula de Parkland convencional (4 ml/kg/% SCQ) con solución Ringer Lactato, ¿qué volumen de líquidos debe administrarse exclusivamente durante las primeras 8 horas desde el momento de la quemadura?

A) 7,560 ml

B) 3,780 ml *

C) 1,890 ml

D) 5,000 ml

Retroalimentación:

La regla de los 9 de Wallace en adultos asigna 18% al tronco anterior completo y 9% a cada extremidad superior completa. Sumando ambos obtenemos 27% de SCQ. La fórmula de Parkland calcula el total para 24 horas: 4 ml x 70 kg x 27% = 7,560 ml. La mitad de este volumen (3,780 ml) debe administrarse en las primeras 8 horas, y la otra mitad en las siguientes 16 horas.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: EPOC (EPOC/CA de Pulmón)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 68 años de edad con un índice tabáquico de 40 paquetes-año. Acude a consulta por tos crónica productiva de predominio matutino y disnea de medianos esfuerzos que ha progresado en los últimos 2 años. A la auscultación pulmonar presenta sibilancias espiratorias bilaterales y una fase espiratoria prolongada. Se realiza una espirometría para confirmar el diagnóstico.

Pregunta 1

¿Cuál es el criterio espirométrico posbroncodilatador indispensable para confirmar el diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)?

A) Relación VEF1/CVF < 0.70 *

B) Capacidad Vital Forzada (CVF) < 80% del predicho.

C) Aumento del VEF1 > 12% y 200 ml tras el broncodilatador.

D) Volumen Residual > 120% del predicho.

Pregunta 2

Si el paciente es clasificado en el Grupo A de la iniciativa GOLD (pocos síntomas, bajo riesgo de exacerbaciones), ¿cuál es el tratamiento farmacológico de mantenimiento inicial recomendado?

A) Corticosteroides inhalados a dosis altas.

B) Un broncodilatador de acción corta (SABA) o de acción prolongada (LABA o LAMA). *

C) Antibióticos macrólidos profilácticos (Azitromicina).

D) Oxígeno suplementario domiciliario continuo.

Retroalimentación:

El diagnóstico de EPOC requiere demostrar una obstrucción al flujo aéreo que no es completamente reversible, lo cual se define espirométricamente por una relación VEF1/CVF menor a 0.70 posbroncodilatador. A diferencia del asma, la respuesta al broncodilatador no normaliza la función pulmonar. Para el grupo A, la guía GOLD

recomienda iniciar con un broncodilatador (puede ser de acción corta o prolongada según la preferencia y respuesta del paciente).

Especialidad: Pediatría

Tema: Incompatibilidad sanguínea (Ictericia Neonatal)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido de 14 horas de vida, producto de una segunda gestación de madre con grupo sanguíneo O negativo (O-) y padre A positivo (A+). La madre no llevó control prenatal adecuado y no recibió profilaxis inmunológica. El neonato es grupo A positivo (A+). Inicia con tinte ictérico progresivo que abarca hasta el abdomen (Kramer III) y palidez tegumentaria.

Pregunta 1

¿Cuál es la fisiopatología principal que explica el cuadro clínico de este neonato?

A) Hemólisis por isoinmunización materna contra el antígeno D (Rh) de los eritrocitos fetales. *

B) Deficiencia de la enzima glucuroniltransferasa hepática (Ictericia fisiológica).

C) Obstrucción congénita de las vías biliares extrahepáticas.

D) Destrucción de eritrocitos por esferocitosis hereditaria.

Pregunta 2

¿Qué prueba de laboratorio es fundamental en el neonato para confirmar que los eritrocitos están recubiertos por anticuerpos maternos y qué resultado se esperaría?

A) Prueba de Coombs indirecta; Positiva.

B) Prueba de Coombs directa; Positiva. *

C) Frotis de sangre periférica; Presencia de esquistocitos.

D) Reticulocitos; Disminuidos.

Retroalimentación:

La ictericia que aparece antes de las primeras 24 horas de vida siempre es patológica y generalmente de origen hemolítico. La incompatibilidad Rh ocurre cuando una madre Rh negativa, previamente sensibilizada, produce anticuerpos IgG anti-D que cruzan la placenta y destruyen los eritrocitos del feto Rh positivo. La prueba de Coombs directa detecta estos anticuerpos fijados a la superficie de los glóbulos rojos del recién nacido.

Especialidad: Cirugía

Tema: Trauma abdominal (ATLS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Varón de 28 años es traído a urgencias tras sufrir una caída de 4 metros de altura en una construcción. Al ingreso se encuentra pálido, diaforético, con TA 85/50 mmHg y FC 125 lpm. Presenta dolor abdominal difuso y equimosis en el cuadrante superior izquierdo. Se inicia reanimación con 1 litro de cristaloides sin mejoría en las cifras tensionales.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial de elección en este paciente inestable para detectar líquido libre intraperitoneal?

A) Tomografía Axial Computarizada (TAC) con doble contraste.

B) Ultrasonido FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). *

C) Lavado Peritoneal Diagnóstico (LPD).

D) Radiografía simple de abdomen de pie y decúbito.

Pregunta 2

Si el estudio inicial reporta abundantes ruidos hidroaéreos en tórax izquierdo y el FAST muestra líquido en espacio esplenorrenal, ¿cuál es el órgano sólido que se lesiona con mayor frecuencia en el trauma abdominal cerrado?

A) Hígado.

B) Bazo. *

C) Páncreas.

D) Riñón.

Retroalimentación:

En un paciente con trauma cerrado e inestabilidad hemodinámica, el FAST es el estándar inicial por su rapidez y portabilidad. El bazo es el órgano más frecuentemente afectado en traumatismos contusos. Si el FAST es positivo y el paciente no responde a volumen, la indicación es laparotomía exploradora inmediata para control de daños.

Especialidad: Pediatría

Tema: Enterocolitis necrotizante (Patología Neonatal Infecciosa)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido pretérmino de 30 semanas de gestación, actualmente en su décimo día de vida en la UCIN. Inició alimentación enteral hace 48 horas. Presenta de forma súbita distensión abdominal, intolerancia a la vía oral con residuos gástricos biliosos y evacuaciones con sangre macroscópica. A la exploración se observa eritema en la pared abdominal.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo radiológico patognomónico que confirma el diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante (ECN)?

A) Imagen en "doble burbuja".

B) Neumatosis intestinal (gas en la pared del intestino). *

C) Niveles hidroaéreos generalizados.

D) Signo del "grano de café".

Pregunta 2

Según la clasificación de Bell, ¿cuál es el hallazgo que indica un estadio IIIb (avanzado) y requiere intervención quirúrgica urgente?

A) Presencia de gas en la vena porta.

B) Neumoperitoneo (aire libre subdiafragmático). *

C) Sangre oculta en heces positiva.

D) Dilatación de asas intestinales.

Retroalimentación:

La ECN es la urgencia gastrointestinal más común en el prematuro. La neumatosis intestinal confirma el diagnóstico. El neumoperitoneo indica perforación intestinal, lo cual clasifica al paciente en el estadio quirúrgico de Bell. El manejo inicial incluye ayuno, descompresión gástrica y antibióticos de amplio espectro.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Litiasis renal (Urologia)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 38 años acude por dolor súbito, paroxístico, de intensidad 10/10 en el flanco derecho, que se irradia hacia la región inguinal y el testículo ipsilateral. El paciente se muestra inquieto y no encuentra posición que alivie el dolor. Presenta náuseas y un episodio de vómito. El examen general de orina reporta hematuria microscópica sin datos de infección.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen con mayor sensibilidad y especificidad ("estándar de oro") para el diagnóstico de litiasis urinaria en la fase aguda?

A) Radiografía simple de abdomen (CUB).

B) Ultrasonido renal y vesical.

C) Tomografía computarizada helicoidal no contrastada (Urotac). *

D) Urografía excretora.

Pregunta 2

¿Cuál es la composición química más frecuente de los cálculos renales a nivel mundial?

A) Fosfato amónico magnésico (estruvita).

B) Oxalato de calcio. *

C) Ácido úrico.

D) Cistina.

Retroalimentación:

El cólico renoureteral se caracteriza por dolor lumbar irradiado a genitales y hematuria. La Urotac permite identificar el tamaño, localización y densidad del lito. Los cálculos de oxalato de calcio representan el 75-80% de los casos. Litos menores

a 5 mm suelen tener una alta probabilidad de expulsión espontánea con manejo médico.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Miomatosis (Sangrados Uterinos Anormales: Origen Anatómico No Maligno)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 42 años acude por menorragia (sangrado abundante y prolongado) de 6 meses de evolución, que le ha condicionado anemia microcítica hipocrómica. A la exploración bimanual se palpa útero aumentado de tamaño, de forma irregular y consistencia firme. El ultrasonido pélvico reporta la presencia de tres lesiones sólidas intramurales, la mayor de 5 cm.

Pregunta 1

¿Cuál es la degeneración más frecuente que sufren estos tumores benignos durante el embarazo debido al rápido crecimiento?

A) Degeneración hialina.

B) Degeneración roja (por infarto hemorrágico). *

C) Degeneración quística.

D) Degeneración sarcomatosa (maligna).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para una paciente con paridad satisfecha y sintomatología persistente que no desea conservar el útero?

A) Miomectomía laparoscópica.

B) Histerectomía. *

C) Embolización de arterias uterinas.

D) Ablación endometrial.

Retroalimentación:

Los miomas son los tumores pélvicos más frecuentes en la mujer. Se clasifican según su localización (submucosos, intramurales, subserosos). La degeneración hialina es la más común en general, pero la "roja" es característica del embarazo. La histerectomía es el tratamiento definitivo en pacientes con síntomas severos y paridad satisfecha.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Virus de la Inmunodeficiencia Humana

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 32 años con diagnóstico reciente de VIH, quien acude a consulta por presentar cefalea intensa, fiebre de 38.2°C y confusión de 5 días de evolución. A la exploración física se detectan signos meníngeos positivos. Se realiza una punción lumbar que reporta pleocitosis linfocítica, hiperproteinorraquia y consumo de glucosa. La tinción con tinta china muestra estructuras levaduriformes encapsuladas.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más probable y cuál es el recuento de linfocitos CD4 esperado para el desarrollo de esta infección oportunista?

A) Mycobacterium tuberculosis; CD4 < 200 cel/mm^3.

B) Cryptococcus neoformans; CD4 < 100 cel/mm^3. *

C) Toxoplasma gondii; CD4 < 50 cel/mm^3.

D) Citomegalovirus; CD4 < 50 cel/mm^3.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de inducción de elección para esta meningitis según las guías internacionales y la GPC?

A) Anfotericina B deoxicolato asociada a Flucitosina por 2 semanas. *

B) Fluconazol a dosis altas por 8 semanas.

C) Ceftriaxona y Vancomicina.

D) Pirimetamina y Sulfadiazina.

Retroalimentación:

La meningitis criptocócica es la infección fúngica del sistema nervioso central más común en pacientes con SIDA, ocurriendo típicamente con CD4 < 100. La tinción con tinta china es una prueba rápida y clásica. El tratamiento se divide en fases: inducción (Anfotericina B + Flucitosina), consolidación y mantenimiento (Fluconazol).

Especialidad: Medicina Interna

Tema: EVC Isquémico y Hemorrágico (EVC Isquémico y Hemorrágico) [cite: 119]

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 72 años con antecedente de hipertensión arterial mal controlada. Es traída a urgencias tras presentar cefalea súbita "la peor de su vida", seguida de pérdida del estado de alerta y vómito en proyectil. A su llegada, presenta una escala de coma de Glasgow de 9 puntos y rigidez de nuca. La TA es de 190/110 mmHg.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el estudio de imagen inicial para confirmar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo?

A) EVC isquémico embólico; Resonancia Magnética.

B) Hemorragia subaracnoidea espontánea; TAC simple de cráneo. *

C) Hematoma subdural crónico; Ultrasonido transcraneal.

D) Encefalopatía hipertensiva; Angio-resonancia.

Pregunta 2

¿Cuál es la causa no traumática más frecuente de este tipo de hemorragia y qué escala se utiliza para clasificar la gravedad clínica inicial?

A) Malformación arteriovenosa; Escala de Cincinnati.

B) Ruptura de aneurisma sacular; Escala de Hunt y Hess. *

C) Angiopatía amiloide; Escala de NIHSS.

D) Disección carotídea; Escala de Rankin.

Retroalimentación:

La hemorragia subaracnoidea (HSA) se caracteriza por la cefalea súbita y signos meníngeos. La TAC simple tiene una alta sensibilidad en las primeras 24 horas. La escala de Hunt y Hess predice la mortalidad basada en el estado neurológico al ingreso. La complicación tardía más importante a vigilar es el vasoespasmo cerebral.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Incompatibilidad grupo Rh (Control Prenatal) [cite: 13]

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 24 años, segundigesta (G2, P1), acude a su control prenatal de 28 semanas. Ella es del grupo sanguíneo O Rh negativo (O-). Su primer hijo fue A Rh positivo (A+) y no recibió inmunoglobulina anti-D posparto. El padre del actual embarazo es Rh positivo. El rastreo de anticuerpos (Coombs indirecto) resulta positivo con un título de 1:16.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico de la paciente y qué indica el título de anticuerpos reportado?

A) Paciente no sensibilizada; Riesgo bajo.

B) Isommunización materna al antígeno D; Título crítico que requiere vigilancia estrecha. *

C) Incompatibilidad ABO; Manejo expectante.

D) Hidropesía fetal inminente; Interrupción del embarazo.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio no invasivo de elección para evaluar la presencia de anemia fetal en este embarazo?

A) Amniocentesis para determinar bilirrubina (escala de Liley).

B) Velocidad máxima del flujo sistólico de la arteria cerebral media por Doppler. *

C) Cordocentesis diagnóstica.

D) Registro cardiotocográfico en reposo.

Retroalimentación:

Una paciente Rh negativa con Coombs indirecto positivo está sensibilizada. Un título de 1:16 se considera generalmente el umbral crítico para riesgo de enfermedad hemolítica fetal. El Doppler de la arteria cerebral media es el método estándar para predecir anemia fetal, evitando procedimientos invasivos iniciales.

Especialidad: Pediatría

Tema: Sifilis (Patología Neonatal Congénita Infecciosa) [cite: 28]

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido de término, hijo de madre con control prenatal deficiente y antecedente de lesiones cutáneas ulcerosas no tratadas durante el segundo trimestre. El neonato presenta al nacimiento bajo peso, rinitis hemorrágica, hepatosplenomegalia y descamación palmoplantar. En las radiografías de huesos largos se observa periostitis y bandas metafisarias.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico y cuál es el tratamiento de elección para este neonato?

A) Citomegalovirus congénito; Ganciclovir.

B) Sífilis congénita temprana; Penicilina G sódica cristalina. *

C) Rubéola congénita; Soporte clínico.

D) Toxoplasmosis; Pirimetamina y Sulfadiazina.

Pregunta 2

¿Cuál es la tríada de Hutchinson, característica de la presentación tardía (después de los 2 años) de esta enfermedad?

A) Sordera nerviosa, queratitis intersticial y dientes de Hutchinson (incisivos muescados). *

B) Microcefalia, cataratas y persistencia del conducto arterioso.

C) Coriorretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales.

D) Cardiopatía, ictericia y bajo peso.

Retroalimentación:

La sífilis congénita es una infección prevenible con un adecuado control prenatal. La penicilina sigue siendo el estándar de oro ya que el *Treponema pallidum* no ha desarrollado resistencia. Los hallazgos óseos y la rinitis son datos muy sugerentes en el periodo neonatal.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Anemia ferropénica (Anemias Introducción y Anemias Carenciales)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 28 años con antecedente de hipermenorrea acude por astenia, adinamia y deseo compulsivo de masticar hielo (pica) de 3 meses de evolución. A la exploración física se observa palidez de mucosas, glositis y coiloniquia (uñas en cuchara). La biometría hemática reporta: Hemoglobina 8.5 g/dL, VCM 70 fL, HCM 22 pg.

Pregunta 1

¿Cuál es el patrón esperado en el perfil de hierro (cinética de hierro) para confirmar el diagnóstico de esta paciente?

A) Ferritina baja, hierro sérico bajo, capacidad total de fijación de hierro (CTFH) elevada. *

B) Ferritina elevada, hierro sérico bajo, CTFH baja.

C) Ferritina normal, hierro sérico normal, transferrina elevada.

D) Ferritina baja, hierro sérico elevado, CTFH normal.

Retroalimentación Pregunta 1:

La anemia ferropénica se caracteriza por ser microcítica e hipocrómica. El primer parámetro en alterarse (y el más sensible) es la caída de la ferritina (las reservas). Al disminuir el hierro circulante, el hígado produce más transferrina de forma compensatoria, lo que se refleja en una elevación de la Capacidad Total de Fijación de Hierro (CTFH).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea y por cuánto tiempo debe mantenerse después de que se normalizan los niveles de hemoglobina?

A) Hierro intravenoso hasta alcanzar hemoglobina normal.

B) Sulfato ferroso vía oral, manteniéndolo el mismo tiempo que tomó normalizar la hemoglobina para reponer las reservas. *

C) Transfusión de concentrados eritrocitarios y ácido fólico de por vida.

D) Eritropoyetina subcutánea y hierro oral por 6 meses.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento de elección es el hierro oral (sulfato ferroso). La regla general es que el tratamiento debe continuar por un periodo igual al que tomó corregir la anemia (usualmente varios meses adicionales) para asegurar que los depósitos de hierro (ferritina) se llenen por completo.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cetoacidosis (Complicaciones Diabetes)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 22 años con diabetes mellitus tipo 1 acude a urgencias por dolor abdominal, náuseas, vómitos y alteración del estado de alerta (somnolencia). Se documenta respiración rápida y profunda (Kussmaul) y aliento con olor a "manzanas". Laboratorios: Glucosa 450 mg/dL, pH 7.15, Bicarbonato 12 mEq/L, pCO2 25 mmHg, cetonas en orina +++.

Pregunta 1

De acuerdo con los resultados, ¿cuál es el trastorno ácido-base primario y cómo se encuentra la brecha aniónica (Anion Gap)?

A) Alcalosis respiratoria compensada; Brecha aniónica normal.

B) Acidosis metabólica con brecha aniónica elevada (normoclorémica). *

C) Acidosis metabólica con brecha aniónica normal (hiperclorémica).

D) Acidosis respiratoria descompensada; Brecha aniónica baja.

Retroalimentación Pregunta 1:

La cetoacidosis diabética se caracteriza por la producción excesiva de cuerpos cetónicos (ácidos no medibles), los cuales consumen el bicarbonato. Esto genera una acidosis metabólica (pH < 7.30 y HCO3 < 18) con Anion Gap elevado (>12). La respiración de Kussmaul es el intento respiratorio compensatorio para barrer CO2.

Pregunta 2

¿Cuál es el paso más importante y prioritario en el manejo inicial de este paciente durante la primera hora?

A) Administrar bolo de insulina regular intravenosa a 0.1 U/kg.

B) Administrar bicarbonato de sodio intravenoso de inmediato.

C) Reposición intensiva de volumen con solución salina isotónica al 0.9%. *

D) Iniciar infusión de potasio independientemente de sus niveles séricos.

Retroalimentación Pregunta 2:

El pilar y la prioridad absoluta en la primera hora de tratamiento de una cetoacidosis diabética es la rehidratación agresiva con cristaloides (solución salina al 0.9%) para corregir la deshidratación severa, restaurar la perfusión renal y diluir la glucosa, incluso antes de iniciar la infusión de insulina.

Especialidad: Pediatría

Tema: Displasia de cadera (Especialidades Pedia)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Lactante femenino de 2 meses de edad, producto de embarazo a término con presentación pélvica, antecedente materno de oligohidramnios. A la exploración física en la consulta de niño sano, el pediatra detecta asimetría de los pliegues glúteos y muslos. Al realizar la maniobra de abducción de las caderas, se percibe un "clic" o resalto palpable en la cadera izquierda.

Pregunta 1

¿Cómo se denominan las maniobras clínicas utilizadas y cuál de ellas es la que "reduce" una cadera previamente luxada?

A) Maniobra de Trendelenburg; reduce la cadera.

B) Maniobra de Barlow; reduce la cadera luxada.

C) Maniobra de Ortolani; reduce la cadera luxada (resalto de entrada). *

D) Maniobra de Galeazzi; luxa la cadera inestable.

Retroalimentación Pregunta 1:

En la exploración neonatal, la maniobra de Barlow es de provocación (luxa una cadera inestable empujando hacia atrás), mientras que la maniobra de Ortolani es de reducción (regresa la cabeza femoral al acetábulo mediante abducción y tracción anterior, generando el "clic" característico de entrada).

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de imagen de elección ("estándar de oro") para confirmar el diagnóstico en este paciente de 2 meses de edad?

A) Radiografía anteroposterior de pelvis (líneas de Shenton y Perkins).

B) Tomografía axial computarizada de caderas.

C) Ultrasonido de caderas. *

D) Resonancia magnética pélvica.

Retroalimentación Pregunta 2:

En lactantes menores de 4 a 6 meses, las cabezas femorales y el acetábulo son predominantemente cartilaginosos y no se visualizan bien en la radiografía simple. El ultrasonido es el método de elección (midiendo los ángulos alfa y beta de Graf) para el diagnóstico temprano de la displasia del desarrollo de la cadera.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: SOP (Sangrados Uterinos Anormales: Origen No Anatómico)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 24 años, con índice de masa corporal de 32 (obesidad). Acude por presentar ciclos menstruales de 45 a 60 días (oligomenorrea), aparición de vello grueso en el mentón y tórax (hirsutismo), y acné severo. El ultrasonido pélvico reporta ovarios con presencia de 15 folículos de 5-8 mm de diámetro dispuestos en la periferia.

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Rotterdam, ¿cuáles son los tres elementos diagnósticos y cuántos se necesitan para confirmar el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)?

A) Oligo/anovulación, hiperandrogenismo (clínico o bioquímico) y ovarios poliquísticos por USG; se requieren al menos 2 de los 3. *

B) Obesidad, resistencia a la insulina e hirsutismo; se requieren los 3.

C) Aumento de LH, disminución de FSH y quistes ováricos; se requieren 2 de 3.

D) Infertilidad, amenorrea primaria y galactorrea; se requieren al menos 2.

Retroalimentación Pregunta 1:

Los Criterios de Rotterdam son el estándar para el diagnóstico de SOP. Se exige la presencia de al menos 2 de los 3 criterios principales: 1) Oligoovulación o anovulación, 2) Datos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, y 3) Morfología de ovarios poliquísticos por ecografía, excluyendo siempre otras patologías (como hiperplasia suprarrenal congénita o tumores).

Pregunta 2

Si la paciente no tiene deseos de fertilidad en este momento, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea para regularizar sus ciclos menstruales y mejorar el hirsutismo?

A) Citrato de clomifeno.

B) Anticonceptivos orales combinados (estrógeno + progestina). *

C) Metformina en monoterapia.

D) Análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).

Retroalimentación Pregunta 2:

Los anticonceptivos orales combinados son el pilar del tratamiento en pacientes con SOP que no buscan embarazo. Regulan los ciclos al inducir sangrados por deprivación (protegiendo el endometrio) y disminuyen la producción ovárica de andrógenos, además de aumentar la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), lo que reduce la testosterona libre y mejora el hirsutismo y acné.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Sx nefrótico (Nefrología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 45 años sin antecedentes crónicos conocidos. Acude a consulta por presentar edema progresivo de miembros inferiores que ha llegado hasta la pared abdominal (anasarca) y notar que su orina es muy espumosa. En los laboratorios destaca: Albúmina sérica de 2.1 g/dL y Colesterol total de 320 mg/dL. El examen general de orina muestra proteínas +++ y cilindros grasos. La recolección de orina de 24 horas reporta proteinuria de 4.5 gramos.

Pregunta 1

De acuerdo con los datos clínicos y de laboratorio, ¿qué síndrome integra este paciente y cuál es la tríada clásica que lo define?

A) Síndrome nefrítico; Hematuria, hipertensión y azoemia.

B) Síndrome nefrótico; Proteinuria >3.5 g/24h, hipoalbuminemia <3 g/dL y edema. *

C) Insuficiencia renal aguda; Oliguria, elevación de creatinina y acidosis.

D) Glomerulonefritis rápidamente progresiva; Proteinuria subnefrótica, hematuria y falla renal acelerada.

Retroalimentación Pregunta 1:

El síndrome nefrótico se caracteriza por un aumento masivo en la permeabilidad glomerular. La tríada diagnóstica fundamental es la proteinuria en rangos nefróticos (mayor a 3.5 gramos en 24 horas en adultos), la consecuente hipoalbuminemia (menor a 3 g/dL) y el edema. La hiperlipidemia y la lipiduria (cilindros grasos) son hallazgos secundarios muy comunes.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación más grave y frecuente asociada a la pérdida urinaria de proteínas como la antitrombina III en este síndrome?

A) Infarto agudo al miocardio.

B) Trombosis venosa (especialmente trombosis de la vena renal) y tromboembolia pulmonar. *

C) Infecciones de vías urinarias recurrentes.

D) Hemorragia alveolar difusa.

Retroalimentación Pregunta 2:

El estado de hipercoagulabilidad en el síndrome nefrótico se debe a la pérdida urinaria de factores anticoagulantes naturales (como la antitrombina III y las proteínas C y S) y al aumento de la síntesis hepática de factores procoagulantes. La trombosis de la vena renal es una de las complicaciones clásicas y potencialmente letales que siempre debe vigilarse.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Endometriosis (Sangrados Uterinos Anormales: Origen No Anatómico)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 28 años, nuligesta, acude a consulta por presentar dolor pélvico crónico e incapacitante que coincide con su menstruación (dismenorrea severa) y dolor profundo durante las relaciones sexuales (dispareunia). Refiere intentar embarazarse desde hace 18 meses sin éxito. A la exploración bimanual, se detecta un útero fijo, doloroso a la movilización y un nódulo palpable en el ligamento uterosacro.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el estándar de oro para su confirmación?

A) Enfermedad pélvica inflamatoria; Cultivo de secreción cervical.

B) Miomatosis uterina; Ultrasonido pélvico.

C) Síndrome de congestión pélvica; Tomografía contrastada.

D) Endometriosis; Laparoscopia diagnóstica con toma de biopsia. *

Retroalimentación Pregunta 1:

La endometriosis clásica se presenta con la tríada de dismenorrea, dispareunia e infertilidad. La presencia de nódulos en los ligamentos uterosacros y un útero fijo son muy sugestivos de adherencias endometriósicas. Aunque el ultrasonido ayuda a ver endometriomas (quistes de chocolate), el estándar de oro definitivo es la visualización directa por laparoscopia y la confirmación histopatológica.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea recomendado para el control del dolor en esta paciente si no deseara embarazo en este momento?

A) Danazol a dosis altas.

B) Anticonceptivos orales combinados (AOC) o progestágenos continuos, junto con AINEs. *

C) Agonistas de la GnRH de forma indefinida.

D) Clomifeno para inducir ovulación.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento médico inicial para el dolor asociado a endometriosis se basa en analgésicos (AINEs) y la supresión ovárica mediante anticonceptivos orales combinados o progestágenos. Esto induce atrofia del tejido endometrial ectópico. Los agonistas de GnRH se reservan como segunda línea debido a sus efectos secundarios hipoestrogénicos (pérdida de masa ósea).

Especialidad: Cirugía

Tema: Fx de cadera (Patología de Extremidad Inferior)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 78 años con antecedente de osteoporosis. Es llevada a urgencias tras sufrir una caída de su propia altura en el baño. A la exploración física, la paciente se encuentra con imposibilidad para la bipedestación y dolor intenso en la región inguinal derecha. La extremidad inferior derecha se observa acortada, en rotación externa evidente y abducción.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y qué hallazgo radiológico esperaría encontrar en una proyección anteroposterior de pelvis?

A) Luxación posterior de cadera; Cabeza femoral fuera del acetábulo hacia superior y posterior.

B) Fractura de diáfisis femoral; Trazo de fractura en el tercio medio.

C) Fractura del cuello femoral o intertrocantérica; Trazo de fractura que interrumpe la línea de Shenton. *

D) Esguince de cadera; Estructuras óseas íntegras.

Retroalimentación Pregunta 1:

La presentación clásica de una fractura de cadera en el adulto mayor es el acortamiento y la rotación externa de la extremidad afectada tras un traumatismo de baja energía. En la radiografía, la interrupción de la línea cervico-obturatriz (línea de Shenton) es un signo clave de pérdida de la anatomía normal del cuello femoral.

Pregunta 2

Si la radiografía confirma una fractura intracapsular (cuello femoral) desplazada, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección recomendado para permitir una movilización temprana y evitar la necrosis avascular?

A) Tracción esquelética continua por 6 semanas.

B) Fijación in situ con tornillos canulados.

C) Artroplastia parcial o total de cadera (prótesis). *

D) Osteosíntesis con clavo centromedular.

Retroalimentación Pregunta 2:

Las fracturas intracapsulares (cuello del fémur) interrumpen la vascularización de la cabeza femoral, teniendo un riesgo elevadísimo de necrosis avascular y pseudoartrosis. En pacientes mayores, el tratamiento de elección es sustituir la articulación con una prótesis (artroplastia) para permitir que el paciente camine y se movilice inmediatamente, reduciendo complicaciones por postración.

Especialidad: Pediatría

Tema: Dermatitis atópica (Especialidades Pedia)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante de 18 meses de edad es traído a consulta por presentar lesiones en la piel muy pruriginosas que no le permiten dormir. La madre tiene antecedente de asma bronquial. A la exploración física se observan placas eritematosas, descamativas, con algunas excoriaciones por rascado, localizadas predominantemente en las mejillas, superficies de extensión de las extremidades y pliegues de flexión (fosas antecubitales).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable de acuerdo con el cuadro clínico y los antecedentes familiares?

A) Dermatitis de contacto.

B) Dermatitis seborreica.

C) Escabiosis.

D) Dermatitis atópica. *

Retroalimentación Pregunta 1:

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. El prurito intenso es el síntoma cardinal. En lactantes, las lesiones suelen afectar la cara (respetando el triángulo nasolabial) y las superficies de extensión, mientras que en niños mayores se localizan en los pliegues de flexión. El antecedente familiar de asma o rinitis (marcha atópica) es altamente sugestivo.

Pregunta 2

¿Cuál es el pilar fundamental del tratamiento de mantenimiento diario para restaurar la función de barrera de la piel en este paciente?

A) Antibióticos tópicos profilácticos.

B) Uso abundante y constante de emolientes e hidratantes. *

C) Corticosteroides tópicos de alta potencia de uso continuo.

D) Antihistamínicos tópicos.

Retroalimentación Pregunta 2:

El defecto principal en la dermatitis atópica es la alteración de la barrera cutánea. El pilar del tratamiento a largo plazo es la lubricación constante con emolientes para mantener la humedad de la piel. Los corticosteroides tópicos se utilizan únicamente en ciclos cortos para controlar las exacerbaciones o brotes inflamatorios, nunca como mantenimiento diario por el riesgo de atrofia cutánea.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Paludismo/Malaria (Enfermedades Transmitidas por Vector)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 35 años de edad acude a consulta por presentar cuadros paroxísticos de fiebre de hasta 40°C, acompañados de escalofríos intensos y diaforesis profusa. Refiere que estos episodios ocurren exactamente cada 48 horas. Como antecedente de importancia, relata un viaje reciente a una zona selvática en Chiapas hace 2 semanas. A la exploración física destaca palidez de tegumentos y esplenomegalia palpable. La biometría hemática muestra anemia normocítica y trombocitopenia.

Pregunta 1

De acuerdo con el cuadro clínico, ¿cuál es el diagnóstico más probable y el método diagnóstico de elección (estándar de oro) para confirmarlo?

A) Dengue clásico; Prueba de torniquete.

B) Fiebre tifoidea; Reacciones febriles (Widal).

C) Paludismo (Malaria); Gota gruesa y frotis de sangre periférica. *

D) Enfermedad de Chagas; Serología para Trypanosoma cruzi.

Retroalimentación Pregunta 1:

El cuadro clínico clásico del paludismo (malaria) se caracteriza por paroxismos febriles acompañados de escalofríos y diaforesis ("tercianas" si ocurren cada 48 horas, típicamente por P. vivax o P. falciparum). El antecedente de viaje a zona endémica es clave. El diagnóstico estándar de oro sigue siendo la visualización directa del parásito intracelular mediante el frotis y la gota gruesa.

Pregunta 2

¿Cuál es el vector responsable de la transmisión de esta enfermedad?

A) Mosquito Aedes aegypti.

B) Mosquito Anopheles (hembra). *

C) Chinche besucona (Triatoma).

D) Garrapata Ixodes.

Retroalimentación Pregunta 2:

El parásito del género Plasmodium es transmitido a los humanos a través de la picadura de la hembra infectada del mosquito Anopheles, a diferencia del Dengue, Zika y Chikungunya que son transmitidos por el género Aedes.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Menopausia (Patologia Menopausia y Climaterio)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 51 años acude a su clínica de primer nivel refiriendo ausencia de menstruación desde hace 14 meses. En el último semestre ha padecido episodios repentinos de calor en cara y tórax superior (bochornos) acompañados de sudoración, los cuales interfieren con su calidad de sueño. También refiere sequedad vaginal y dispareunia leve. Cuenta con útero intacto y no tiene antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama.

Pregunta 1

Según la definición clínica, la paciente cursa con menopausia. ¿Cuál es el perfil hormonal característico que confirma fisiológicamente este estado de falla ovárica?

A) Estradiol elevado y Hormona Foliculoestimulante (FSH) suprimida.

B) Disminución drástica de Prolactina y elevación de LH.

C) Estradiol disminuido (<20 pg/ml) y Hormona Foliculoestimulante (FSH) elevada (>40 mUI/ml). *

D) Progesterona elevada y Testosterona baja.

Retroalimentación Pregunta 1:

La menopausia se define clínicamente por 12 meses consecutivos de amenorrea. Fisiológicamente, el agotamiento folicular ovárico provoca una caída en la producción de inhibina y estradiol, lo que elimina la retroalimentación negativa hacia la hipófisis, resultando en una elevación compensatoria marcada de la FSH (típicamente mayor a 40 mUI/ml).

Pregunta 2

Para el manejo de los síntomas vasomotores severos en esta paciente (sin contraindicaciones absolutas), ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea recomendado?

A) Terapia Hormonal de Reemplazo combinada (Estrógenos + Progestágenos). *

B) Terapia con Estrógenos simples de manera exclusiva.

C) Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS).

D) Moduladores selectivos del receptor de estrógenos (Raloxifeno).

Retroalimentación Pregunta 2:

La Terapia Hormonal (TH) es el estándar de oro para el alivio de los bochornos. Al tener la paciente el útero intacto, es estrictamente obligatorio administrar una terapia combinada (estrógenos acompañados de un progestágeno) para proteger el endometrio y evitar el riesgo de hiperplasia o cáncer endometrial. Los estrógenos simples solo se dan en pacientes histerectomizadas.

Especialidad: Cirugía

Tema: Obstrucción intestinal (Patología Intestinal Qx)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 62 años, con antecedente de apendicectomía abierta complicada hace 10 años, ingresa al servicio de urgencias por dolor abdominal de tipo cólico generalizado, de 24 horas de evolución. Presenta distensión abdominal progresiva, náuseas, vómitos de características fecaloideas y ausencia total de canalización de gases y evacuaciones. A la exploración física el abdomen es timpánico y los ruidos peristálticos se escuchan de tono metálico (de lucha).

Pregunta 1

De acuerdo con los antecedentes del paciente, ¿cuál es la etiología más frecuente de este cuadro obstructivo a nivel de intestino delgado?

A) Vólvulo de sigmoides.

B) Hernia inguinal encarcelada.

C) Adherencias postquirúrgicas (bridas). *

D) Neoplasia de colon derecho.

Retroalimentación Pregunta 1:

En adultos, la causa número uno de obstrucción mecánica del intestino delgado son las adherencias o bridas postquirúrgicas, responsables de hasta el 70% de los casos. El antecedente de una cirugía abdominal previa (especialmente abierta o complicada) es el principal factor de riesgo.

Pregunta 2

¿Cuál es el hallazgo radiológico clásico que se esperaría encontrar en una radiografía simple de abdomen en bipedestación en este paciente?

A) Signo del grano de café o neumático.

B) Niveles hidroaéreos escalonados y dilatación de asas con visualización de válvulas conniventes (signo en "pila de monedas"). *

C) Neumoperitoneo (aire subdiafragmático).

D) Presencia de gas en el sistema portal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La radiografía de abdomen de pie y decúbito es el abordaje inicial. En la obstrucción de intestino delgado se observa dilatación de las asas centrales (>3 cm), disposición de los pliegues circulares que cruzan toda la luz del asa (pila de monedas) y la formación de niveles hidroaéreos por la estasis de líquido y gas distal a la obstrucción.

Especialidad: Pediatría

Tema: TTRN (Patología Respiratoria del Pediátrico)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido de 38 semanas de gestación, obtenido mediante cesárea electiva sin trabajo de parto previo. Al nacimiento, presenta de forma casi inmediata polipnea con frecuencia respiratoria de 85 rpm, aleteo nasal y retracción xifoidea leve (Silverman-Andersen de 3). A la auscultación, los campos pulmonares se encuentran bien ventilados, sin estertores. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación, aumento de la trama vascular perihiliar (corazón "peludo") y líquido en las cisuras interlobares.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que condiciona la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN)?

A) Deficiencia cuantitativa y cualitativa de factor surfactante pulmonar.

B) Aspiración intrauterina de líquido teñido con meconio.

C) Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal debido a la falta de estímulo adrenérgico del trabajo de parto. *

D) Hipoplasia pulmonar secundaria a oligohidramnios severo.

Retroalimentación Pregunta 1:

La TTRN (o síndrome de pulmón húmedo) es causada por una falla en la eliminación del líquido alveolar al momento de nacer. Normalmente, el estrés del trabajo de parto libera catecolaminas que detienen la secreción de líquido e inician su reabsorción linfática. Los nacidos por cesárea electiva (sin trabajo de parto) no tienen este estímulo, reteniendo el líquido, lo que da los clásicos hallazgos radiológicos de cisuritis y atrapamiento aéreo.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial de elección para este neonato mientras se resuelve el cuadro?

A) Administrar dosis de surfactante endotraqueal de inmediato.

B) Ayuno transitorio (por FR >80 rpm) y administración de oxígeno suplementario mediante casco cefálico o CPAP para mantener saturación adecuada. *

C) Inicio de esquema antibiótico profiláctico con Ampicilina y Amikacina.

D) Toracocentesis para drenar el líquido pleural.

Retroalimentación Pregunta 2:

La TTRN es un proceso benigno y autolimitado (usualmente dura de 24 a 72 horas). El tratamiento es de soporte: asistencia ventilatoria no invasiva (oxígeno) y suspender temporalmente la vía oral cuando la frecuencia respiratoria supera las 80

respiraciones por minuto para evitar el riesgo de broncoaspiración, utilizando soluciones intravenosas en el ínterin.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Paludismo/Malaria (Enfermedades Transmitidas por Vector)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 35 años de edad acude a consulta por presentar cuadros paroxísticos de fiebre de hasta 40°C, acompañados de escalofríos intensos y diaforesis profusa. Refiere que estos episodios ocurren exactamente cada 48 horas. Como antecedente de importancia, relata un viaje reciente a una zona selvática en Chiapas hace 2 semanas. A la exploración física destaca palidez de tegumentos y esplenomegalia palpable. La biometría hemática muestra anemia normocítica y trombocitopenia.

Pregunta 1

De acuerdo con el cuadro clínico, ¿cuál es el diagnóstico más probable y el método diagnóstico de elección (estándar de oro) para confirmarlo?

A) Dengue clásico; Prueba de torniquete.

B) Fiebre tifoidea; Reacciones febriles (Widal).

C) Paludismo (Malaria); Gota gruesa y frotis de sangre periférica. *

D) Enfermedad de Chagas; Serología para Trypanosoma cruzi.

Retroalimentación Pregunta 1:

El cuadro clínico clásico del paludismo (malaria) se caracteriza por paroxismos febriles acompañados de escalofríos y diaforesis ("tercianas" si ocurren cada 48 horas, típicamente por P. vivax o P. falciparum). El antecedente de viaje a zona endémica es clave. El diagnóstico estándar de oro sigue siendo la visualización directa del parásito intracelular mediante el frotis y la gota gruesa.

Pregunta 2

¿Cuál es el vector responsable de la transmisión de esta enfermedad?

A) Mosquito Aedes aegypti.

B) Mosquito Anopheles (hembra). *

C) Chinche besucona (Triatoma).

D) Garrapata Ixodes.

Retroalimentación Pregunta 2:

El parásito del género Plasmodium es transmitido a los humanos a través de la picadura de la hembra infectada del mosquito Anopheles, a diferencia del Dengue, Zika y Chikungunya que son transmitidos por el género Aedes.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Menopausia (Patologia Menopausia y Climaterio)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 51 años acude a su clínica de primer nivel refiriendo ausencia de menstruación desde hace 14 meses. En el último semestre ha padecido episodios repentinos de calor en cara y tórax superior (bochornos) acompañados de sudoración, los cuales interfieren con su calidad de sueño. También refiere sequedad vaginal y dispareunia leve. Cuenta con útero intacto y no tiene antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama.

Pregunta 1

Según la definición clínica, la paciente cursa con menopausia. ¿Cuál es el perfil hormonal característico que confirma fisiológicamente este estado de falla ovárica?

A) Estradiol elevado y Hormona Foliculoestimulante (FSH) suprimida.

B) Disminución drástica de Prolactina y elevación de LH.

C) Estradiol disminuido (<20 pg/ml) y Hormona Foliculoestimulante (FSH) elevada (>40 mUI/ml). *

D) Progesterona elevada y Testosterona baja.

Retroalimentación Pregunta 1:

La menopausia se define clínicamente por 12 meses consecutivos de amenorrea. Fisiológicamente, el agotamiento folicular ovárico provoca una caída en la producción de inhibina y estradiol, lo que elimina la retroalimentación negativa hacia la hipófisis, resultando en una elevación compensatoria marcada de la FSH (típicamente mayor a 40 mUI/ml).

Pregunta 2

Para el manejo de los síntomas vasomotores severos en esta paciente (sin contraindicaciones absolutas), ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea recomendado?

A) Terapia Hormonal de Reemplazo combinada (Estrógenos + Progestágenos). *

B) Terapia con Estrógenos simples de manera exclusiva.

C) Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS).

D) Moduladores selectivos del receptor de estrógenos (Raloxifeno).

Retroalimentación Pregunta 2:

La Terapia Hormonal (TH) es el estándar de oro para el alivio de los bochornos. Al tener la paciente el útero intacto, es estrictamente obligatorio administrar una terapia combinada (estrógenos acompañados de un progestágeno) para proteger el endometrio y evitar el riesgo de hiperplasia o cáncer endometrial. Los estrógenos simples solo se dan en pacientes histerectomizadas.

Especialidad: Cirugía

Tema: Obstrucción intestinal (Patología Intestinal Qx)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 62 años, con antecedente de apendicectomía abierta complicada hace 10 años, ingresa al servicio de urgencias por dolor abdominal de tipo cólico generalizado, de 24 horas de evolución. Presenta distensión abdominal progresiva, náuseas, vómitos de características fecaloideas y ausencia total de canalización de gases y evacuaciones. A la exploración física el abdomen es timpánico y los ruidos peristálticos se escuchan de tono metálico (de lucha).

Pregunta 1

De acuerdo con los antecedentes del paciente, ¿cuál es la etiología más frecuente de este cuadro obstructivo a nivel de intestino delgado?

A) Vólvulo de sigmoides.

B) Hernia inguinal encarcelada.

C) Adherencias postquirúrgicas (bridas). *

D) Neoplasia de colon derecho.

Retroalimentación Pregunta 1:

En adultos, la causa número uno de obstrucción mecánica del intestino delgado son las adherencias o bridas postquirúrgicas, responsables de hasta el 70% de los casos. El antecedente de una cirugía abdominal previa (especialmente abierta o complicada) es el principal factor de riesgo.

Pregunta 2

¿Cuál es el hallazgo radiológico clásico que se esperaría encontrar en una radiografía simple de abdomen en bipedestación en este paciente?

A) Signo del grano de café o neumático.

B) Niveles hidroaéreos escalonados y dilatación de asas con visualización de válvulas conniventes (signo en "pila de monedas"). *

C) Neumoperitoneo (aire subdiafragmático).

D) Presencia de gas en el sistema portal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La radiografía de abdomen de pie y decúbito es el abordaje inicial. En la obstrucción de intestino delgado se observa dilatación de las asas centrales (>3 cm), disposición de los pliegues circulares que cruzan toda la luz del asa (pila de monedas) y la formación de niveles hidroaéreos por la estasis de líquido y gas distal a la obstrucción.

Especialidad: Pediatría

Tema: TTRN (Patología Respiratoria del Pediátrico)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido de 38 semanas de gestación, obtenido mediante cesárea electiva sin trabajo de parto previo. Al nacimiento, presenta de forma casi inmediata polipnea con frecuencia respiratoria de 85 rpm, aleteo nasal y retracción xifoidea leve (Silverman-Andersen de 3). A la auscultación, los campos pulmonares se encuentran bien ventilados, sin estertores. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación, aumento de la trama vascular perihiliar (corazón "peludo") y líquido en las cisuras interlobares.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que condiciona la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN)?

A) Deficiencia cuantitativa y cualitativa de factor surfactante pulmonar.

B) Aspiración intrauterina de líquido teñido con meconio.

C) Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal debido a la falta de estímulo adrenérgico del trabajo de parto. *

D) Hipoplasia pulmonar secundaria a oligohidramnios severo.

Retroalimentación Pregunta 1:

La TTRN (o síndrome de pulmón húmedo) es causada por una falla en la eliminación del líquido alveolar al momento de nacer. Normalmente, el estrés del trabajo de parto libera catecolaminas que detienen la secreción de líquido e inician su reabsorción linfática. Los nacidos por cesárea electiva (sin trabajo de parto) no tienen este estímulo, reteniendo el líquido, lo que da los clásicos hallazgos radiológicos de cisuritis y atrapamiento aéreo.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial de elección para este neonato mientras se resuelve el cuadro?

A) Administrar dosis de surfactante endotraqueal de inmediato.

B) Ayuno transitorio (por FR >80 rpm) y administración de oxígeno suplementario mediante casco cefálico o CPAP para mantener saturación adecuada. *

C) Inicio de esquema antibiótico profiláctico con Ampicilina y Amikacina.

D) Toracocentesis para drenar el líquido pleural.

Retroalimentación Pregunta 2:

La TTRN es un proceso benigno y autolimitado (usualmente dura de 24 a 72 horas). El tratamiento es de soporte: asistencia ventilatoria no invasiva (oxígeno) y suspender

temporalmente la vía oral cuando la frecuencia respiratoria supera las 80 respiraciones por minuto para evitar el riesgo de broncoaspiración, utilizando soluciones intravenosas en el ínterin.

Especialidad: Cirugía

Tema: Chalazión (Introducción Oftalmología)

Dificultad: Baja

Caso Clínico

Hombre de 34 años acude a consulta por presentar una "bolita" en el párpado superior derecho de 4 semanas de evolución. Refiere que al inicio presentó una ligera molestia, pero actualmente es completamente indolora. A la exploración oftalmológica, se observa y palpa un nódulo subdérmico bien definido de 5 mm de diámetro, de consistencia firme, sin hiperemia ni calor local. La agudeza visual está conservada.

Pregunta 1

De acuerdo con la evolución y la ausencia de dolor agudo, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Orzuelo interno.

B) Dacriocistitis.

C) Chalazión. *

D) Blefaritis anterior.

Retroalimentación Pregunta 1:

El chalazión es una inflamación granulomatosa crónica y estéril de una glándula de Meibomio debido a la retención de sus secreciones sebáceas. Se distingue clínicamente del orzuelo porque el chalazión es de evolución subaguda/crónica y, clásicamente, es un nódulo indoloro y sin signos inflamatorios agudos manifiestos.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección si esta lesión no resuelve tras varias semanas de manejo conservador con compresas calientes e higiene?

A) Antibióticos tópicos (tobramicina) por 14 días.

B) Incisión quirúrgica y curetaje. *

C) Corticosteroides sistémicos a dosis de reducción.

D) Crioterapia palpebral.

Retroalimentación Pregunta 2:

El manejo inicial del chalazión es conservador (compresas calientes y masaje). Sin embargo, cuando la lesión se vuelve crónica, se encapsula y no responde a medidas higiénicas después de un tiempo razonable, el tratamiento de elección es la incisión vertical (por la conjuntiva tarsal) y el curetaje de la glándula afectada.

Especialidad: Cirugía

Tema: Esguince de tobillo (Patología de Extremidad Inferior)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 22 años acude a urgencias tras sufrir una torcedura del tobillo derecho al pisar el borde de una acera mientras corría. Refiere que el pie se fue "hacia adentro" (inversión forzada). A la exploración, presenta edema moderado y equimosis en la región maleolar externa. El dolor es intenso a la palpación del ligamento lateral, pero la paciente es capaz de dar 5 pasos por sí misma cojeando.

Pregunta 1

Dado el mecanismo de lesión por inversión forzada, ¿cuál es el ligamento del tobillo que se lesiona con mayor frecuencia?

A) Ligamento deltoideo.

B) Ligamento peroneo calcáneo.

C) Ligamento peroneo astragalino anterior. *

D) Ligamento tibioperoneo anteroinferior.

Retroalimentación Pregunta 1:

El esguince lateral de tobillo es la lesión musculoesquelética aguda más común. El mecanismo clásico es la inversión y flexión plantar del pie. El complejo ligamentario lateral es el más afectado, siendo el ligamento peroneo astragalino anterior (LPAA) el primero y más frecuentemente lesionado debido a su disposición anatómica.

Pregunta 2

De acuerdo con las Reglas de Ottawa, ¿cuál es el criterio clínico que descartaría la necesidad inmediata de solicitar radiografías en esta paciente?

A) La presencia de equimosis extensa.

B) La capacidad de dar al menos 4 pasos (soportar su propio peso) de forma independiente en urgencias. *

C) El dolor a la palpación sobre el maléolo medial.

D) La edad menor de 55 años.

Retroalimentación Pregunta 2:

Las Reglas de Ottawa para el tobillo tienen una altísima sensibilidad para descartar fracturas. Indican radiografía solo si hay dolor en la zona maleolar acompañado de: incapacidad para soportar el propio peso (dar 4 pasos) inmediatamente después del trauma y en urgencias, o dolor a la palpación en los 6 cm distales del borde posterior de ambos maléolos. Como la paciente puede caminar, la probabilidad de fractura es muy baja.

Especialidad: Pediatría

Tema: Sx de Down (Alteraciones Cromosómicas y Perlas)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido a término, producto de una madre de 41 años. A la exploración física al nacimiento, el neonato presenta hipotonía generalizada, perfil facial plano, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, pliegue palmar único (simiesco) bilateral y un espacio amplio entre el primer y segundo ortejo del pie (signo de la sandalia). Se ausculta un soplo holosistólico en el precordio.

Pregunta 1

Considerando el diagnóstico clínico de Síndrome de Down (Trisomía 21), ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuentemente asociada a esta alteración cromosómica a nivel mundial?

A) Tetralogía de Fallot.

B) Defecto del canal auriculoventricular (canal AV) completo. *

C) Transposición de grandes vasos.

D) Coartación de la aorta.

Retroalimentación Pregunta 1:

Aproximadamente el 40-50% de los niños con Síndrome de Down nacen con una cardiopatía congénita. El defecto de la tabicación auriculoventricular (canal AV completo) es la malformación cardiaca más clásica y específica de esta trisomía, originada por una falla en el desarrollo de los cojinetes endocárdicos.

Pregunta 2

Si a las 24 horas de vida el neonato presenta vómitos de características biliares y el abdomen se observa excavado, ¿qué hallazgo radiológico esperaría encontrar en una radiografía simple de abdomen sugerente de atresia duodenal?

A) Signo del grano de café.

B) Neumoperitoneo masivo.

C) Signo de la "doble burbuja". *

D) Dilatación generalizada de asas con niveles hidroaéreos múltiples.

Retroalimentación Pregunta 2:

La atresia duodenal es la malformación gastrointestinal más frecuente en pacientes con Síndrome de Down. Se manifiesta tempranamente con vómitos biliosos (porque la obstrucción suele ser distal a la ampolla de Vater). La radiografía simple muestra el clásico signo de la "doble burbuja", que corresponde al aire en el estómago y en la porción proximal del duodeno dilatado, sin gas distal.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Osteoporosis (Patologia Menopausia y Climaterio)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 68 años de edad, postmenopáusica desde hace 18 años, de complexión delgada y con antecedente de tabaquismo positivo. Acude a consulta externa para una revisión de rutina. Se encuentra asintomática y niega haber sufrido fracturas previas. Se le realiza un estudio de absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA) como escrutinio. El reporte muestra un T-score de -2.8 desviaciones estándar en la columna lumbar y -1.5 en el cuello femoral.

Pregunta 1

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿cómo se clasifica el diagnóstico de esta paciente con base en los resultados densitométricos?

A) Osteopenia.

B) Osteoporosis severa (establecida).

C) Osteoporosis. *

D) Masa ósea normal.

Retroalimentación Pregunta 1:

La OMS clasifica la densidad mineral ósea basada en el T-score (comparación con adultos jóvenes sanos): Normal es -1.0; Osteopenia es entre -1.0 y -2.5; Osteoporosis es $\le$ -2.5. Cuando hay osteoporosis (2.5) acompañada de una fractura por fragilidad previa, se denomina osteoporosis severa o establecida. En este caso, el -2.8 en columna lumbar confirma la osteoporosis.

Pregunta 2

Dado su diagnóstico y la ausencia de contraindicaciones, ¿cuál es el grupo farmacológico de primera línea (antirresortivo) indicado para prevenir fracturas por fragilidad en esta paciente?

A) Estrógenos conjugados.

B) Teriparatida (PTH recombinante).

C) Bisfosfonatos (ej. Alendronato). *

D) Calcitonina intranasal.

Retroalimentación Pregunta 2:

Los bisfosfonatos orales (como el alendronato o risedronato) son el tratamiento de primera línea para la osteoporosis postmenopáusica. Actúan inhibiendo la actividad

de los osteoclastos y promoviendo su apoptosis, reduciendo así la resorción ósea y disminuyendo significativamente el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: AMENORREA SECUNDARIA (SÍNDROME DE ASHERMAN)
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 29 años con antecedente de legrado uterino instrumentado hace 8 meses por aborto retenido. Desde entonces presenta amenorrea secundaria y dolor tipo cólico cíclico cada mes. Niega galactorrea, bochornos o pérdida de peso. Prueba de embarazo negativa.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Síndrome de Asherman *
B) Síndrome de ovario poliquístico.
C) Insuficiencia ovárica primaria.
D) Embarazo ectópico crónico.

Pregunta 2
¿Cuál es el estudio diagnóstico más útil para confirmar el padecimiento?
A) Histeroscopia *
B) Mastografía.
C) Tomografía de pelvis.
D) Perfil tiroideo.

Retroalimentación:
El síndrome de Asherman consiste en sinequias intrauterinas, generalmente secundarias a legrados o infecciones uterinas. Debe sospecharse ante amenorrea posterior a instrumentación uterina con dolor cíclico. La histeroscopia confirma el diagnóstico y además permite tratamiento.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: HEMORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE (EMBARAZO ECTÓPICO)
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 27 años, con retraso menstrual de 7 semanas, dolor en fosa iliaca derecha y sangrado transvaginal escaso. A la exploración presenta dolor a la

movilización cervical. La BHCG es positiva y el ultrasonido transvaginal no muestra saco gestacional intrauterino, pero sí masa anexial derecha.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Embarazo ectópico tubario *
B) Aborto incompleto.
C) Embarazo molar.
D) Amenaza de aborto.

Pregunta 2
¿Cuál es el sitio más frecuente de implantación ectópica?
A) Ampolla de la trompa de Falopio *
B) Cuerno uterino.
C) Ovario.
D) Cérvix.

Retroalimentación:
La tríada clásica es amenorrea, dolor abdominal y sangrado transvaginal. El hallazgo de BHCG positiva sin embarazo intrauterino visible y con masa anexial orienta fuertemente a embarazo ectópico. La localización más frecuente es la porción ampular de la trompa.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO (PREECLAMPSIA CON DATOS DE SEVERIDAD)
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Primigesta de 34 semanas acude por cefalea intensa, fosfenos y edema en extremidades inferiores. TA 168/112 mmHg. EGO con proteinuria 3+. Plaquetas de 95,000/mm^3. FCF normal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Preeclampsia con datos de severidad *
B) Hipertensión gestacional.
C) Preeclampsia sin datos de severidad.
D) Eclampsia.

Pregunta 2
¿Cuál es el medicamento indicado para prevenir convulsiones en esta paciente?
A) Sulfato de magnesio *
B) Fenitoína.
C) Diazepam.
D) Carbamazepina.

Retroalimentación:
La presencia de hipertensión después de la semana 20, proteinuria y datos de daño a órgano blanco como trombocitopenia, cefalea o alteraciones visuales define preeclampsia con datos de severidad. El sulfato de magnesio se utiliza para profilaxis anticonvulsiva.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: HEMORRAGIA DEL TERCER TRIMESTRE (PLACENTA PREVIA)
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 32 semanas de gestación, G3P2, con antecedente de cesárea previa. Acude por sangrado transvaginal rojo brillante, abundante, súbito e indoloro. El útero está relajado y no presenta dolor abdominal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Placenta previa *
B) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.
C) Ruptura uterina.
D) Vasa previa rota.

Pregunta 2
¿Qué procedimiento está contraindicado mientras no se descarte este diagnóstico?
A) Tacto vaginal digital *
B) Ultrasonido obstétrico.
C) Biometría hemática.
D) Monitoreo fetal.

Retroalimentación:
La placenta previa se manifiesta típicamente con hemorragia roja brillante, indolora y sin hipertonía uterina. El tacto vaginal digital puede desencadenar hemorragia

masiva, por lo que debe evitarse hasta conocer la localización placentaria por ultrasonido.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: ICTERICIA NEONATAL (ATRESIA DE VÍAS BILIARES)
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Lactante de 5 semanas presenta ictericia persistente desde el nacimiento. La madre refiere evacuaciones hipocólicas y orina oscura. A la exploración se encuentra hepatomegalia. Bilirrubina total elevada a expensas de la fracción directa.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Atresia de vías biliares *
B) Ictericia fisiológica prolongada.
C) Enfermedad hemolítica del recién nacido.
D) Síndrome de Gilbert.

Pregunta 2
¿Cuál es el dato clínico que más orienta a colestasis neonatal?
A) Evacuaciones hipocólicas o acólicas *
B) Llanto fuerte.
C) Reflejo de Moro disminuido.
D) Fontanela normotensa.

Retroalimentación:
La ictericia persistente con hiperbilirrubinemia directa, coluria y heces hipocólicas o acólicas obliga a descartar atresia de vías biliares. El diagnóstico oportuno es fundamental porque el pronóstico empeora si se retrasa el tratamiento quirúrgico.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Lactante masculino de 5 semanas, previamente sano, inicia con vómitos progresivos posprandiales, no biliosos y en proyectil. Después de vomitar, vuelve a tener hambre. A la exploración presenta datos de deshidratación leve y pérdida de peso.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Estenosis hipertrófica del píloro *
B) Atresia duodenal.
C) Reflujo gastroesofágico fisiológico.
D) Invaginación intestinal.

Pregunta 2
¿Cuál es la alteración metabólica clásica en esta entidad?
A) Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalémica *
B) Acidosis metabólica con hiperkalemia.
C) Acidosis respiratoria.
D) Hipernatremia aislada.

Retroalimentación:
La estenosis hipertrófica del píloro produce obstrucción de la salida gástrica, con vómitos no biliosos en proyectil y hambre posterior. La pérdida crónica de ácido clorhídrico genera alcalosis metabólica hipoclorémica.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: BRONQUIOLITIS
Dificultad: Media

Caso Clínico
Lactante de 7 meses con rinorrea y tos de 3 días de evolución, que progresa a dificultad respiratoria. A la exploración presenta sibilancias difusas, tiraje intercostal y taquipnea. Saturación de oxígeno de 92% al aire ambiente.

Pregunta 1
¿Cuál es el agente etiológico más frecuente?
A) Virus sincitial respiratorio *
B) Streptococcus pneumoniae.
C) Haemophilus influenzae.
D) Mycoplasma pneumoniae.

Pregunta 2
¿Cuál es la base del tratamiento en la mayoría de los casos?
A) Manejo de soporte con oxígeno e hidratación *
B) Ceftriaxona intravenosa.

C) Prednisona oral obligatoria en todos los casos.
D) Salbutamol como tratamiento definitivo universal.

Retroalimentación:
La bronquiolitis afecta principalmente a lactantes menores de 2 años y suele ser causada por VSR. El manejo es fundamentalmente de soporte; los broncodilatadores no tienen beneficio constante en todos los pacientes.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: ENFERMEDAD DE KAWASAKI
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Niño de 4 años con fiebre de 6 días de evolución, conjuntivitis bilateral no purulenta, labios fisurados, lengua en fresa, exantema polimorfo y edema de manos y pies. Presenta adenopatía cervical unilateral de 2 cm.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Enfermedad de Kawasaki *
B) Sarampión.
C) Escarlatina.
D) Mononucleosis infecciosa.

Pregunta 2
¿Cuál es la complicación cardiovascular más temida?
A) Aneurismas de arterias coronarias *
B) Miocardiopatía hipertrófica.
C) Comunicación interventricular.
D) Coartación aórtica.

Retroalimentación:
La enfermedad de Kawasaki debe sospecharse ante fiebre prolongada y datos mucocutáneos característicos. La principal complicación son los aneurismas coronarios, por lo que el tratamiento oportuno con inmunoglobulina IV y ácido acetilsalicílico cambia el pronóstico.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: URGENCIAS PEDIÁTRICAS (INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL)
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Escolar de 8 años es llevado a urgencias 4 horas después de ingerir múltiples tabletas de paracetamol de forma accidental. Se encuentra consciente, con náusea y vómito. No tiene alteraciones neurológicas.

Pregunta 1
¿Cuál es el antídoto específico en esta intoxicación?
A) N-acetilcisteína *
B) Flumazenil.
C) Naloxona.
D) Atropina.

Pregunta 2
¿Cuál es el principal órgano blanco de toxicidad?
A) Hígado *
B) Riñón.
C) Pulmón.
D) Cerebelo.

Retroalimentación:
La intoxicación por paracetamol puede ser inicialmente paucisintomática, pero evolucionar a necrosis hepática fulminante. La N-acetilcisteína repone glutatión y es más efectiva cuando se administra tempranamente.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: UROPEDIA (TORSIÓN TESTICULAR)
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Adolescente de 14 años presenta dolor súbito e intenso en testículo izquierdo, acompañado de náusea y vómito. A la exploración se observa testículo elevado, horizontalizado y con reflejo cremastérico ausente.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Torsión testicular *

B) Epididimitis aguda.
C) Hidrocele.
D) Hernia inguinal reducible.

Pregunta 2
¿Cuál es la conducta más adecuada?
A) Exploración quirúrgica urgente *
B) Reposo y antiinflamatorios por 48 horas.
C) Antibiótico oral y cita abierta.
D) Solicitar espermatobioscopía.

Retroalimentación:
La torsión testicular es una urgencia quirúrgica tiempo-dependiente. El reflejo cremastérico ausente y el inicio súbito del dolor orientan fuertemente al diagnóstico. No debe retrasarse la cirugía por estudios innecesarios si la sospecha clínica es alta.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: ABDOMEN AGUDO (APENDICITIS AGUDA)
Dificultad: Media

Caso Clínico
Masculino de 22 años con dolor abdominal de 18 horas de evolución, inicialmente periumbilical y posteriormente localizado en fosa iliaca derecha. Presenta náusea, anorexia y febrícula. A la exploración hay dolor en punto de McBurney y signo de rebote positivo.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Apendicitis aguda *
B) Colecistitis aguda.
C) Pancreatitis aguda.
D) Diverticulitis sigmoidea.

Pregunta 2
¿Cuál es el tratamiento definitivo?
A) Apendicectomía *
B) Dieta blanda y observación.
C) Lavado gástrico.
D) Únicamente antiespasmódicos.

Retroalimentación:
La migración del dolor de región periumbilical a fosa iliaca derecha es clásica de apendicitis aguda. Aunque los laboratorios y estudios de imagen ayudan, el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico en muchos casos.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: PATOLOGÍA ANORRECTAL (HEMORROIDES EXTERNAS TROMBOSADAS)
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Paciente de 38 años consulta por dolor anal intenso de inicio súbito después de evacuar. A la inspección se observa tumoración azulada, tensa y muy dolorosa en el margen anal. No refiere fiebre.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hemorroide externa trombosada *
B) Fisura anal crónica.
C) Absceso perianal.
D) Fístula anorrectal.

Pregunta 2
¿Qué dato clínico orienta más hacia este diagnóstico y no a un absceso?
A) Lesión azulada bien delimitada sin datos sistémicos de infección *
B) Fiebre persistente.
C) Secreción purulenta.
D) Dolor abdominal difuso.

Retroalimentación:
La hemorroide externa trombosada suele presentarse como una masa dolorosa violácea o azulada en el margen anal. El absceso perianal se asocia más con fluctuación, eritema, calor y, en ocasiones, fiebre.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: CETOACIDOSIS DIABÉTICA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 19 años con antecedente de DM1 acude por poliuria, polidipsia, náusea,

vómito y dolor abdominal. A la exploración presenta deshidratación, taquipnea profunda y aliento cetónico. Glucosa 420 mg/dL.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Cetoacidosis diabética *
B) Estado hiperosmolar hiperglucémico.
C) Hipoglucemia severa.
D) Pancreatitis aguda aislada.

Pregunta 2
¿Cuál es el pilar inicial del tratamiento junto con insulina?
A) Reposición intensiva de líquidos intravenosos *
B) Restricción hídrica.
C) Bicarbonato en todos los casos.
D) Sulfonilureas orales.

Retroalimentación:
La triada de hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica caracteriza a la cetoacidosis diabética. La reposición de volumen es esencial desde el inicio, seguida de corrección de electrolitos e insulina.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: EPOC AGUDIZADO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Hombre de 68 años, fumador crónico, con diagnóstico de EPOC. Acude por aumento de la disnea, incremento del volumen de esputo y cambio a expectoración purulenta. Saturación de oxígeno de 86% al aire ambiente.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Exacerbación aguda de EPOC *
B) Crisis asmática aislada.
C) Tromboembolia pulmonar masiva.
D) Derrame pleural por cirrosis.

Pregunta 2
¿Cuál es una indicación clásica para añadir antibióticos en este contexto?

A) Aumento de disnea, volumen y purulencia del esputo *
B) Tos seca ocasional.
C) Saturación normal al aire ambiente.
D) Dolor torácico musculoesquelético.

Retroalimentación:
Los criterios clínicos de Anthonisen ayudan a identificar exacerbaciones bacterianas de EPOC. La combinación de mayor disnea, aumento del esputo y esputo purulento apoya el uso de antibióticos junto con broncodilatadores y, con frecuencia, esteroides sistémicos.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: SÍNDROME NEFRÓTICO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 46 años consulta por edema progresivo en párpados y extremidades inferiores. En laboratorios presenta albúmina sérica baja, proteinuria de 4.5 g en 24 horas e hiperlipidemia.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico sindromático?
A) Síndrome nefrótico *
B) Síndrome nefrítico.
C) Lesión renal aguda prerrenal.
D) Infección urinaria complicada.

Pregunta 2
¿Cuál es un hallazgo característico de este síndrome?
A) Proteinuria masiva mayor de 3.5 g al día *
B) Cilindros hemáticos en todos los casos.
C) Hipocomplementemia obligatoria.
D) Oliguria severa como dato inicial universal.

Retroalimentación:
El síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. La pérdida urinaria de proteínas altera la presión oncótica y favorece edema generalizado.

Especialidad: Pediatría

Tema: OMA (Patología Infecciosa / Rinología y Faringe)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante masculino de 2 años de edad es traído a consulta por irritabilidad, llanto constante y fiebre de 38.5°C de 24 horas de evolución. La madre refiere que el niño se lleva constantemente la mano a la oreja derecha y que hace 3 días cursó con un cuadro de rinofaringitis (escurrimiento nasal y tos). A la exploración otoscópica del oído derecho, se observa la membrana timpánica abombada, eritematosa, opaca y con pérdida del triángulo luminoso.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente bacteriano aislado con mayor frecuencia en esta patología a nivel mundial?

A) Haemophilus influenzae no tipificable.

B) Moraxella catarrhalis.

C) Streptococcus pneumoniae. *

D) Staphylococcus aureus.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Otitis Media Aguda (OMA) es una complicación frecuente de las infecciones virales de vías respiratorias superiores que causan disfunción de la trompa de Eustaquio. El *Streptococcus pneumoniae* es la bacteria más común (seguido de *H. influenzae* y *M. catarrhalis*), siendo responsable de los cuadros clínicos con mayor fiebre y otalgia severa.

Pregunta 2

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica, ¿cuál es el tratamiento antibiótico empírico de primera elección para este paciente?

A) Amoxicilina a dosis altas (80-90 mg/kg/día). *

B) Azitromicina por 3 días.

C) Ceftriaxona intramuscular dosis única.

D) Trimetoprima con Sulfametoxazol.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento de primera línea para la OMA es la amoxicilina a dosis altas (para vencer la resistencia de los neumococos con alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina). Se reserva el uso de amoxicilina con ácido clavulánico para casos de fracaso terapéutico a las 72 horas, antecedente de conjuntivitis purulenta simultánea o uso reciente de antibióticos.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Asma en el Adulto y Pediátrico

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 22 años de edad acude a consulta por presentar cuadros recurrentes de tos seca, opresión torácica y sibilancias audibles a distancia, los cuales predominan por la noche y al realizar ejercicio aeróbico. Sus síntomas empeoran durante la primavera. Se realiza una espirometría basal que muestra un patrón obstructivo (VEF1/CVF < 0.70).

Pregunta 1

¿Qué hallazgo espirométrico posbroncodilatador confirmaría el diagnóstico de asma en esta paciente?

A) Aumento del VEF1 del 5% y 100 ml respecto al basal.

B) Incremento del VEF1 o de la CVF > 12% y > 200 ml tras la inhalación de un beta-2 agonista de acción corta. *

C) Disminución del Volumen Residual por debajo del 80% del predicho.

D) Normalización del flujo espiratorio pico sin cambios en el VEF1.

Retroalimentación Pregunta 1:

A diferencia de la EPOC, la obstrucción del flujo aéreo en el asma es característicamente reversible. La reversibilidad se define en la espirometría como un aumento significativo del Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEF1) o de la Capacidad Vital Forzada (CVF) de más del 12% y más de 200 ml absolutos después de administrar un broncodilatador.

Pregunta 2

Si la paciente es diagnosticada con asma leve y presenta síntomas más de dos veces por mes, ¿cuál es el tratamiento controlador de mantenimiento recomendado como piedra angular?

A) Broncodilatadores de acción corta (SABA) en monoterapia a demanda.

B) Corticosteroides inhalados a dosis bajas (ej. Budesonida o Fluticasona) diarios o a demanda combinados con formoterol. *

C) Antileucotrienos (Montelukast) de forma exclusiva.

D) Teofilina oral de liberación prolongada.

Retroalimentación Pregunta 2:

La inflamación crónica de la vía aérea es la base fisiopatológica del asma. Las guías actuales (como GINA) recomiendan fuertemente el uso de corticosteroides inhalados (CSI) como tratamiento controlador para prevenir exacerbaciones, incluso en asma leve. La monoterapia exclusiva con SABA (salbutamol) a demanda ya no se recomienda sin un CSI asociado.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Enfermedad pélvica inflamatoria (Patología Infecciosa Cervical)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 24 años, con múltiples parejas sexuales y sin uso de método de barrera. Acude al servicio de urgencias por dolor abdominal bajo progresivo de 3 días de evolución, asociado a fiebre no cuantificada y dispareunia profunda. A la exploración física, presenta temperatura de 38.3°C, y a la exploración pélvica bimanual se desencadena dolor intenso a la movilización del cérvix (signo de Chandeiler o del candelabro positivo) y dolor a la palpación en ambos anexos.

Pregunta 1

¿Cuáles son los agentes etiológicos clásicos más frecuentemente asociados al desarrollo de esta patología?

A) Gardnerella vaginalis y Trichomonas vaginalis.

B) Treponema pallidum y Haemophilus ducreyi.

C) Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. *

D) Virus del Papiloma Humano y Herpes Simple tipo 2.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) es una infección ascendente del tracto genital superior femenino. Aunque suele ser polimicrobiana (incluyendo flora vaginal), *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis* son los agentes de transmisión sexual iniciadores más importantes y responsables de la mayoría de los casos agudos en mujeres jóvenes.

Pregunta 2

Considerando que la paciente tolera la vía oral y no tiene datos de irritación peritoneal severa ni absceso tubo-ovárico, ¿cuál es el esquema de tratamiento antibiótico empírico ambulatorio de primera línea?

A) Fluconazol oral y crema vaginal de Clindamicina.

B) Ceftriaxona IM (dosis única) + Doxiciclina oral por 14 días (con o sin Metronidazol). *

C) Ciprofloxacino en monoterapia por 7 días.

D) Penicilina G Benzatínica intramuscular dosis única.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento empírico de la EPI debe cubrir a los principales patógenos. Las guías recomiendan una cefalosporina de tercera generación (Ceftriaxona para cubrir el gonococo) combinada con una tetraciclina (Doxiciclina durante 14 días para cubrir Chlamydia). Se suele añadir Metronidazol para cubrir anaerobios de la flora vaginal implicados en la infección polimicrobiana.

Especialidad: Cirugía

Tema: Fx de antebrazo y mano (Patología de Extremidad Superior)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 65 años de edad acude a urgencias tras sufrir una caída en la calle. Refiere haberse apoyado sobre la mano derecha en extensión (dorsiflexión) al momento del impacto. A la exploración física, presenta intenso dolor, edema y una deformidad evidente en la muñeca descrita clásicamente como "en dorso de tenedor". Los pulsos distales están presentes y el llenado capilar es normal.

Pregunta 1

Con base en el mecanismo de lesión y la deformidad clínica, ¿cuál es el diagnóstico y nombre propio (epónimo) de esta fractura?

A) Fractura de Smith.

B) Fractura de Colles. *

C) Fractura de Barton.

D) Fractura de Monteggia.

Retroalimentación Pregunta 1:

La fractura de Colles es la fractura distal del radio más común. Se produce típicamente por una caída con la mano en extensión y se caracteriza por el desplazamiento dorsal (hacia atrás) y radial del fragmento distal, lo que produce la clásica deformidad en "dorso de tenedor". La fractura de Smith es la deformidad inversa (en "pala de jardinero") por caída con la muñeca en flexión.

Pregunta 2

¿Qué estructura nerviosa se encuentra con mayor riesgo de compresión aguda debido al edema y al desplazamiento óseo en este tipo de fractura?

A) Nervio cubital en el canal de Guyon.

B) Nervio radial en la tabaquera anatómica.

C) Nervio mediano a nivel del túnel del carpo. *

D) Nervio musculocutáneo.

Retroalimentación Pregunta 2:

El nervio mediano discurre junto con los tendones flexores a través del túnel del carpo, justo palmar a la articulación radiocarpiana. El edema severo, el hematoma y el desplazamiento de la fractura de Colles pueden comprimir este nervio, produciendo síntomas de un síndrome del túnel del carpo agudo (parestesias en los primeros tres dedos de la mano).

Especialidad: Pediatría

Tema: Sepsis (Patología Neonatal Infecciosa)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido de 14 horas de vida, producto de madre adolescente con control prenatal irregular y antecedente de ruptura prematura de membranas de 22 horas de evolución sin profilaxis antibiótica. El neonato inicia con rechazo al alimento, letargo, inestabilidad térmica (hipotermia de 35.8°C) y dificultad respiratoria leve. A la exploración física se observa pálido, hiporreactivo y con llenado capilar de 4 segundos.

Pregunta 1

Dado el antecedente materno y el inicio de los síntomas en las primeras 72 horas de vida (sepsis de inicio temprano), ¿cuál es el agente etiológico bacteriano más frecuentemente asociado a esta patología?

A) Staphylococcus epidermidis.

B) Listeria monocytogenes.

C) Streptococcus agalactiae (Estreptococo del grupo B). *

D) Pseudomonas aeruginosa.

Retroalimentación Pregunta 1:

La sepsis neonatal temprana (primeras 72 horas) generalmente se adquiere por transmisión vertical (vía ascendente o durante el paso por el canal de parto). Los dos microorganismos más comunes a nivel mundial son el *Streptococcus agalactiae* (EGB) y la *Escherichia coli*. La profilaxis intraparto busca prevenir específicamente la infección por EGB.

Pregunta 2

Tras la toma de hemocultivo y punción lumbar (si las condiciones del paciente lo permiten), ¿cuál es el esquema de antibioticoterapia empírica inicial de primera elección?

A) Vancomicina + Cefotaxima.

B) Ampicilina + Aminoglucósido (ej. Gentamicina o Amikacina). *

C) Ceftriaxona en monoterapia.

D) Dicloxacilina + Cefepime.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento empírico para la sepsis temprana debe cubrir EGB, *E. coli* y *Listeria monocytogenes*. La ampicilina cubre excelentemente al EGB y a la Listeria, mientras que el aminoglucósido tiene un efecto sinérgico y cubre a los bacilos gramnegativos entéricos como *E. coli*. Las cefalosporinas de tercera generación (como cefotaxima) se reservan si hay sospecha de meningitis, pero no cubren Listeria.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Delirium tremens (Psiquiatría)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 48 años de edad es ingresado para una apendicectomía no complicada. A las 72 horas de su hospitalización, comienza a presentar agitación psicomotriz severa, desorientación temporoespacial, sudoración profusa (diaforesis), taquicardia de 130 lpm y temblor generalizado. El paciente grita asustado afirmando que ve "arañas gigantes y ratas" caminando por las paredes de su habitación. La familia refiere que el paciente consume grandes cantidades de alcohol diariamente desde hace 10 años.

Pregunta 1

De acuerdo con la cronología clínica, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia de inicio tardío.

B) Encefalopatía de Wernicke.

C) Síndrome neuroléptico maligno.

D) Delirium tremens. *

Retroalimentación Pregunta 1:

El Delirium tremens es la manifestación más grave del síndrome de abstinencia al alcohol. Típicamente se presenta entre 48 y 96 horas después del último consumo (en este caso, al estar hospitalizado). Se caracteriza por alteración del estado de alerta, hiperactividad autonómica grave (taquicardia, diaforesis, hipertensión) y alucinaciones visuales o táctiles (zoopsias).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea para controlar los síntomas agudos, prevenir convulsiones y reducir la mortalidad en este paciente?

A) Antipsicóticos típicos (Haloperidol) en altas dosis.

B) Benzodiacepinas de acción prolongada o intermedia (ej. Diazepam o Lorazepam). *

C) Barbitúricos (Fenobarbital) como primera opción.

D) Bloqueadores beta-adrenérgicos (Propranolol).

Retroalimentación Pregunta 2:

Las benzodiacepinas son el estándar de oro para el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica y el Delirium tremens. Actúan estimulando los receptores GABA (mismo sitio de acción del alcohol), controlando la agitación, revirtiendo la hiperactividad autonómica y previniendo la progresión a crisis convulsivas.

Especialidad: Cirugía

Tema: Choque (ATLS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Varón de 30 años es traído por paramédicos tras sufrir un accidente en motocicleta a alta velocidad. Al ingreso se encuentra confuso y combativo. A la exploración física presenta palidez de tegumentos, piel fría y diaforética. Sus signos vitales son: Tensión Arterial 80/50 mmHg, Frecuencia Cardiaca 135 lpm, Frecuencia Respiratoria 30 rpm y llenado capilar retardado. A la inspección secundaria se detecta inestabilidad del anillo pélvico.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos (ATLS), ¿en qué clase de choque hemorrágico se encuentra este paciente?

A) Clase I (Pérdida < 15%).

B) Clase II (Pérdida 15-30%).

C) Clase III (Pérdida 31-40%). *

D) Clase IV (Pérdida > 40%).

Retroalimentación Pregunta 1:

El paciente se encuentra en un choque Clase III. Los datos clave que marcan la diferencia entre la Clase II y la Clase III son la caída de la tensión arterial (hipotensión) y la alteración del estado mental (confusión). La frecuencia cardiaca entre 120 y 140 lpm también es característica de una pérdida sanguínea estimada del 31% al 40% del volumen circulante.

Pregunta 2

Según los lineamientos más recientes del ATLS (10a edición), ¿cuál es la estrategia inicial de reanimación con líquidos recomendada para este paciente mientras se prepara la transfusión de hemoderivados?

A) Infusión rápida de 3 a 4 litros de solución salina al 0.9%.

B) Bolo inicial estricto de 1 litro de solución cristaloide isotónica y cálida. *

C) Administración de albúmina humana al 5% a dosis de 20 ml/kg.

D) Uso de soluciones hipertónicas exclusivamente.

Retroalimentación Pregunta 2:

El paradigma de la reanimación ha cambiado. El ATLS actualmente recomienda una reanimación restrictiva o balanceada: iniciar con un bolo máximo de 1 litro de cristaloide (Ringer Lactato o Solución Salina) en el adulto. Si el paciente no responde o es un respondedor transitorio, se debe activar de inmediato el protocolo de transfusión masiva (sangre y derivados) para evitar la hemodilución, la hipotermia y la coagulopatía.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: CA de ovario (Oncología Ginecológica)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 62 años, nuligesta, acude a consulta por presentar aumento progresivo del perímetro abdominal en los últimos 3 meses, acompañado de saciedad temprana, dispepsia y dolor pélvico vago. A la exploración física se detecta signo de la oleada ascítica positivo y a la palpación bimanual se identifica una masa pélvica anexial derecha, de bordes irregulares, fija a planos profundos y de consistencia pétrea.

Pregunta 1

Ante la sospecha de una neoplasia maligna epitelial del ovario, ¿cuál es el marcador tumoral sérico de mayor utilidad para la evaluación inicial y el seguimiento posterior al tratamiento?

A) Antígeno Carcinoembrionario (ACE).

B) Fracción beta de la Hormona Gonadotropina Coriónica (hCG).

C) CA-125. *

D) CA 15-3.

Retroalimentación Pregunta 1:

El cáncer epitelial de ovario es el tipo histológico más frecuente (y el más letal de los tumores ginecológicos). El antígeno CA-125 se encuentra elevado en más del 80% de los cánceres epiteliales no mucinosos avanzados. Aunque no es específico para el cribado en población general, es el marcador estándar para apoyar el diagnóstico en una masa sospechosa y es vital para monitorear la respuesta a la quimioterapia o detectar recidivas.

Pregunta 2

Si los estudios de imagen (TAC) confirman enfermedad extendida a la cavidad peritoneal (carcinomatosis), ¿cuál es el abordaje terapéutico quirúrgico primario estándar?

A) Histerectomía simple vía laparoscópica.

B) Laparotomía exploradora estadificadora y cirugía de citorreducción máxima. *

C) Radioterapia pélvica exclusiva sin cirugía.

D) Toma de biopsia con aguja fina guiada por ultrasonido y vigilancia.

Retroalimentación Pregunta 2:

La piedra angular del tratamiento del cáncer de ovario es la cirugía. El objetivo es realizar una citorreducción óptima (dejar una enfermedad residual nula o menor a 1

cm en su diámetro mayor). Esto generalmente implica una laparotomía media que incluya histerectomía, salpingooforectomía bilateral, omentectomía, linfadenectomía y resección de cualquier implante peritoneal visible, seguido de quimioterapia adyuvante.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Brucelosis (Enfermedades por Zoonosis)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 45 años de edad, de ocupación ganadero, acude a consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por fiebre de predominio vespertino y nocturno, diaforesis profusa de olor penetrante, astenia, adinamia y mialgias severas. A la exploración física se documenta temperatura de 38.5°C, palidez de tegumentos y se palpa el borde hepático 2 cm por debajo del reborde costal, así como esplenomegalia leve.

Pregunta 1

De acuerdo con la sospecha clínica, ¿cuál es la prueba de escrutinio inicial de elección para esta patología infecciosa?

A) Hemocultivo medio Ruiz Castañeda.

B) Reacciones febriles (Reacción de Widal).

C) Aglutinación con antígeno Rosa de Bengala. *

D) Prueba de ELISA para IgM e IgG.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Brucelosis (Fiebre de Malta) es una zoonosis clásica cuyo factor de riesgo principal es el contacto con ganado o el consumo de lácteos no pasteurizados. La fiebre ondulante y la diaforesis nocturna son signos cardinales. La prueba de aglutinación con Rosa de Bengala es rápida, económica y tiene alta sensibilidad, por lo que se utiliza como el escrutinio inicial en México.

Pregunta 2

Si la prueba confirmatoria (SAT y 2-Mercaptoetanol) resulta positiva, ¿cuál es el esquema de tratamiento de primera línea (Esquema A de la OMS/NOM) indicado para este paciente adulto sin contraindicaciones?

A) Ciprofloxacino y Clindamicina por 14 días.

B) Tetraciclina y Estreptomicina por 21 días. *

C) Rifampicina y Trimetoprima/Sulfametoxazol por 45 días.

D) Doxiciclina y Ceftriaxona por 10 días.

Retroalimentación Pregunta 2:

El Esquema A (de primera elección en adultos sanos y no embarazadas) consiste en la combinación de Tetraciclina (o Doxiciclina) oral más Estreptomicina intramuscular durante 21 días. El Esquema B (Rifampicina + TMP/SMX) se reserva para niños, mujeres embarazadas o pacientes donde el esquema A esté contraindicado.

Especialidad: Cirugía

Tema: Úlcera péptica complicada y perforada (Patología Gástrica)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 60 años con antecedente de osteoartritis en tratamiento crónico con naproxeno. Ingresa al servicio de urgencias por dolor abdominal de inicio súbito, lancinante y de intensidad 10/10 en el epigastrio, que rápidamente se generalizó a todo el abdomen. A la exploración física, el paciente está taquicárdico, diaforético, y presenta un abdomen rígido ("en madera") con signo de rebote generalizado. A la percusión hepática, se detecta timpanismo en lugar de matidez.

Pregunta 1

¿Cómo se le conoce al signo clínico de pérdida de la matidez hepática y cuál es el estudio de imagen inicial más rápido para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Signo de Murphy; Ultrasonido abdominal.

B) Signo de Jobert; Radiografía simple de tórax de pie o abdomen en bipedestación. *

C) Signo de Chilaiditi; Tomografía computarizada con contraste oral.

D) Signo de Courvoisier-Terrier; Resonancia magnética.

Retroalimentación Pregunta 1:

La úlcera péptica perforada es una urgencia quirúrgica mayor. El uso crónico de AINEs es un factor de riesgo altísimo. La perforación hacia la cavidad libre produce neumoperitoneo, el cual se manifiesta clínicamente por la pérdida de la matidez hepática a la percusión (Signo de Jobert). La radiografía de tórax de pie o abdomen en bipedestación es el estudio inicial ideal porque permite visualizar el aire libre subdiafragmático (neumoperitoneo).

Pregunta 2

Dado que el paciente presenta signos claros de irritación peritoneal generalizada (abdomen agudo), ¿cuál es la conducta quirúrgica de urgencia de elección para tratar la perforación duodenal?

A) Gastrectomía total con reconstrucción en Y de Roux.

B) Cierre primario de la perforación con colocación de un parche de epiplón (Parche de Graham). *

C) Vagotomía troncular altamente selectiva.

D) Drenaje percutáneo guiado por ultrasonido.

Retroalimentación Pregunta 2:

El manejo estándar y más rápido para una úlcera péptica perforada (típicamente en la cara anterior del duodeno) en un paciente inestable o con peritonitis es el cierre simple de la lesión reforzado con un parche de epiplón pediculado, conocido como técnica de Graham. Procedimientos definitivos para reducir el ácido (como vagotomías) ya no se realizan de urgencia debido al éxito actual del tratamiento médico con IBPs y erradicación de *H. pylori*.

Especialidad: Pediatría

Tema: Bacterianas (Neumonías)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Preescolar femenino de 4 años de edad, previamente sana y con esquema de vacunación al corriente. Inicia hace 48 horas con fiebre de 39°C de inicio súbito, escalofríos, tos productiva con expectoración purulenta y dolor torácico. A la exploración física: FR 45 rpm, FC 120 lpm. A la auscultación pulmonar se detecta disminución del murmullo vesicular, estertores crepitantes finos y matidez a la percusión en la base del hemitórax derecho.

Pregunta 1

Por el grupo de edad y la presentación clínica típica (inicio súbito, fiebre alta y consolidación focal), ¿cuál es el agente etiológico más probable de esta neumonía adquirida en la comunidad?

A) Mycoplasma pneumoniae.

B) Virus Sincitial Respiratorio.

C) Streptococcus pneumoniae. *

D) Chlamydia trachomatis.

Retroalimentación Pregunta 1:

La neumonía bacteriana "típica" se caracteriza por un inicio abrupto, fiebre elevada, tos productiva y signos de consolidación lobar (estertores, matidez). En niños de 1 a 5 años (y en general en todas las edades pediátricas fuera del periodo neonatal), el neumococo (*Streptococcus pneumoniae*) es la principal causa bacteriana típica.

Pregunta 2

Si la paciente no presenta datos de dificultad respiratoria severa (no hay tiraje, cianosis ni alteración del estado de alerta) y tolera la vía oral, ¿cuál es el tratamiento antibiótico empírico de primera elección para el manejo ambulatorio?

A) Amoxicilina a dosis altas (80-90 mg/kg/día). *

B) Azitromicina.

C) Ceftriaxona intramuscular.

D) Oseltamivir.

Retroalimentación Pregunta 2:

Para el manejo ambulatorio de la neumonía adquirida en la comunidad no complicada y de probable etiología neumocócica en pacientes pediátricos adecuadamente vacunados, la amoxicilina a dosis altas es el fármaco de elección, ya que logra concentraciones adecuadas en el parénquima pulmonar para vencer la resistencia bacteriana. Los macrólidos (como azitromicina) se reservan para sospecha de gérmenes atípicos (Mycoplasma) en niños mayores de 5 años.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Distocias (Patología de Trabajo de Parto)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Paciente de 38 años, multípara, cursa embarazo de 39 semanas de gestación. Se encuentra en periodo expulsivo del trabajo de parto, con un feto macrosómico estimado por ultrasonido en 4,200 g. Tras la expulsión de la cabeza fetal, esta se retrae firmemente contra el periné materno (signo de la tortuga) y no se logra la expulsión de los hombros a pesar de la tracción suave hacia abajo y los pujos maternos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico de esta emergencia obstétrica y cuál es la primera maniobra de primera línea que debe realizarse para intentar desimpactar el hombro anterior?

A) Retención de placenta; Maniobra de Brandt-Andrews.

B) Distocia de hombros; Maniobra de McRoberts (hiperflexión de las piernas maternas sobre el abdomen). *

C) Distocia de presentación; Maniobra de Zavanelli (reintroducción de la cabeza y cesárea).

D) Ruptura uterina; Episiotomía amplia inmediata.

Retroalimentación Pregunta 1:

La distocia de hombros ocurre cuando el hombro anterior del feto se impacta detrás de la sínfisis del pubis materno después de que la cabeza ha nacido ("signo de la tortuga"). La macrosomía es el principal factor de riesgo. La maniobra de McRoberts aplana el promontorio sacro y aumenta el diámetro anteroposterior de la pelvis, siendo la intervención inicial de elección por su alta tasa de éxito y baja morbilidad.

Pregunta 2

Si después de realizar diversas maniobras el feto nace con una postura del brazo derecho en aducción y rotación interna, con el codo extendido, el antebrazo en pronación y la muñeca flexionada ("propina de mesero"), ¿qué estructura nerviosa resultó lesionada durante la distocia?

A) Raíces inferiores del plexo braquial (C8-T1).

B) Nervio torácico largo.

C) Raíces superiores del plexo braquial (C5-C6). *

D) Nervio mediano aislado.

Retroalimentación Pregunta 2:

La parálisis de Erb-Duchenne es la complicación neonatal más frecuente de la distocia de hombros. Ocurre por el estiramiento o avulsión de las raíces superiores del plexo braquial (C5 y C6). Clínicamente se manifiesta por la incapacidad para abducir y rotar externamente el brazo, así como para supinar el antebrazo, dando la clásica postura de "propina de mesero" o "brazo de policía".

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Primigesta de 31 semanas de gestación acude por salida súbita de líquido transvaginal claro desde hace 4 horas. Refiere disminución de movimientos fetales no, niega sangrado y presenta leve actividad uterina irregular. A la exploración con espejo vaginal se observa salida de líquido por orificio cervical. No hay fiebre ni datos de corioamnionitis.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Ruptura prematura de membranas pretérmino *
B) Incontinencia urinaria.
C) Trabajo de parto pretérmino con membranas íntegras.
D) Placenta previa.

Pregunta 2
¿Cuál es la conducta general más adecuada si no hay datos de infección ni sufrimiento fetal?
A) Manejo expectante con esteroides y vigilancia *
B) Inducción inmediata en todos los casos.
C) Tacto vaginal repetido cada hora.
D) Alta con antibiótico oral sin seguimiento.

Retroalimentación:
La ruptura prematura de membranas pretérmino ocurre antes de las 37 semanas y antes del inicio del trabajo de parto. Si no hay datos de infección, sufrimiento fetal o trabajo de parto establecido, suele indicarse manejo expectante, maduración pulmonar fetal y vigilancia estrecha.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: DIABETES GESTACIONAL
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 30 años, con 28 semanas de gestación, antecedente de obesidad y macrosomía fetal en embarazo previo. Acude a control prenatal sin síntomas. Se realiza tamiz con carga de glucosa y resulta alterado.

Pregunta 1
¿Cuál es el factor de riesgo más importante en esta paciente para diabetes gestacional?
A) Obesidad materna *
B) Edad menor de 35 años.
C) Primigesta.
D) Talla baja aislada.

Pregunta 2
¿Cuál es la principal complicación fetal asociada a diabetes gestacional mal controlada?
A) Macrosomía fetal *
B) Microcefalia.
C) Labio y paladar hendido.
D) Agenesia renal bilateral.

Retroalimentación:
La diabetes gestacional se asocia con obesidad, antecedente de macrosomía y otros factores de riesgo metabólico. La hiperglucemia materna favorece hiperinsulinemia fetal y crecimiento excesivo, aumentando riesgo de macrosomía y distocia de hombros.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: ENDOMETRIOSIS
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 32 años consulta por dolor pélvico crónico, dismenorrea progresiva, dispareunia profunda e infertilidad de 2 años de evolución. A la exploración presenta dolor en fondo de saco posterior.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Endometriosis *
B) Enfermedad inflamatoria pélvica aguda.
C) Miomatosis uterina.
D) Amenaza de aborto.

Pregunta 2
¿Cuál es el sitio de localización más frecuente de esta enfermedad?
A) Ovarios *
B) Hígado.
C) Cuello uterino.
D) Vulva.

Retroalimentación:
La endometriosis debe sospecharse ante la tríada de dismenorrea, dolor pélvico crónico e infertilidad. Los ovarios son un sitio frecuente de implantación ectópica del tejido endometrial, formando endometriomas.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: CRUP VIRAL
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niño de 2 años con cuadro de rinorrea y febrícula de 2 días, que evoluciona con tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio. Se observa retracción supraesternal leve, pero buena perfusión y saturación conservada.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Laringotraqueítis viral *

B) Epiglotitis.
C) Bronquiolitis.
D) Cuerpo extraño esofágico.

Pregunta 2
¿Cuál es el tratamiento farmacológico indicado en la mayoría de los casos?
A) Dexametasona *
B) Amoxicilina.
C) Aciclovir.
D) Furosemida.

Retroalimentación:
El crup viral se caracteriza por tos perruna, disfonía y estridor, generalmente precedidos por síntomas catarrales. La dexametasona disminuye edema de la vía aérea y mejora la evolución clínica.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: INVAGINACIÓN INTESTINAL
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Lactante de 9 meses presenta episodios súbitos de llanto intenso con flexión de piernas sobre el abdomen, vómitos y periodos de aparente mejoría. Horas después evacúa heces con moco y sangre en jalea de grosella.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Invaginación intestinal *
B) Apendicitis aguda.
C) Estreñimiento funcional.
D) Gastroenteritis viral simple.

Pregunta 2
¿Cuál es el estudio o procedimiento diagnóstico-terapéutico más útil en pacientes estables?
A) Enema neumático o hidrostático *
B) Colonoscopia total.
C) Serie ósea completa.
D) Electroencefalograma.

Retroalimentación:
La invaginación intestinal es una causa frecuente de obstrucción intestinal en lactantes. El cuadro clásico incluye dolor abdominal intermitente, vómito y evacuaciones en jalea de grosella. En pacientes sin perforación ni peritonitis, el enema puede ser diagnóstico y terapéutico.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: MENINGITIS BACTERIANA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Escolar de 6 años con fiebre alta, cefalea intensa, vómito y rigidez de nuca. Se observa irritable y somnoliento. A la exploración presenta signos meníngeos positivos.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Meningitis bacteriana aguda *
B) Migraña con aura.
C) Gastroenteritis infecciosa.
D) Crisis de ausencia.

Pregunta 2
¿Cuál es la conducta inicial más importante ante la sospecha clínica?
A) Iniciar antibióticos de forma oportuna tras toma de muestras pertinentes *
B) Esperar 24 horas para confirmar el diagnóstico.
C) Indicar solo antipiréticos y observación domiciliaria.
D) Administrar diuréticos como única medida.

Retroalimentación:
La meningitis bacteriana es una urgencia médica. La combinación de fiebre, cefalea, vómito, alteración del estado mental y rigidez de nuca obliga a tratamiento temprano, ya que el retraso incrementa mortalidad y secuelas neurológicas.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: COLECISTITIS AGUDA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 42 años con dolor en hipocondrio derecho de 12 horas de evolución, posterior a ingesta copiosa de alimentos grasos. Presenta náusea, vómito y fiebre. A la exploración hay dolor en hipocondrio derecho con interrupción inspiratoria a la palpación.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Colecistitis aguda *
B) Hepatitis aguda.
C) Apendicitis retrocecal.
D) Pancreatitis crónica.

Pregunta 2
¿Cuál es el signo clínico clásico presente en esta paciente?
A) Signo de Murphy *
B) Signo de Cullen.
C) Signo de Rovsing.
D) Signo de Tinel.

Retroalimentación:
La colecistitis aguda suele presentarse con dolor en hipocondrio derecho, fiebre y náusea, frecuentemente desencadenada por obstrucción del conducto cístico por litos. El signo de Murphy apoya el diagnóstico clínico.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: OCLUSIÓN INTESTINAL
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Masculino de 58 años con antecedente de laparotomía hace 3 años. Acude por dolor abdominal tipo cólico, distensión progresiva, vómitos y ausencia de evacuaciones y gases desde hace 24 horas. A la exploración hay abdomen distendido y ruidos intestinales aumentados.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Obstrucción intestinal mecánica *
B) Perforación gástrica.

C) Colitis ulcerativa.
D) Pielonefritis aguda.

Pregunta 2
¿Cuál es la causa más frecuente de este cuadro en un paciente con antecedente quirúrgico abdominal?
A) Bridas o adherencias *
B) Apendicitis.
C) Hemorroides internas.
D) Litiasis vesicular.

Retroalimentación:
La obstrucción intestinal mecánica se manifiesta con dolor cólico, distensión, vómitos y obstipación. En pacientes con cirugías abdominales previas, las adherencias postoperatorias son la causa más frecuente.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 67 años con aumento de volumen inguinal derecho de larga evolución, que ahora presenta dolor intenso, irreductibilidad, náusea y vómito. La tumoración es sensible a la palpación y no disminuye con decúbito.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hernia inguinal estrangulada *
B) Adenopatía inguinal reactiva.
C) Hidrocele no complicado.
D) Varicocele.

Pregunta 2
¿Cuál es la conducta más adecuada?
A) Cirugía urgente *
B) Observación ambulatoria.
C) Faja abdominal y reposo.
D) Antibiótico oral y revaloración en un mes.

Retroalimentación:
La irreductibilidad asociada con dolor intenso y datos de obstrucción intestinal sugiere estrangulación herniaria. Es una urgencia quirúrgica por riesgo de isquemia y necrosis intestinal.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: HIPOTIROIDISMO PRIMARIO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 45 años consulta por fatiga, intolerancia al frío, estreñimiento y aumento de peso. A la exploración presenta piel seca, bradicardia y facies abotagada.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hipotiroidismo primario *
B) Hipertiroidismo.
C) Síndrome nefrótico.
D) Insuficiencia suprarrenal aguda.

Pregunta 2
¿Cuál es el patrón de laboratorio esperado en la mayoría de los casos?
A) TSH elevada y T4 libre disminuida *
B) TSH baja y T4 libre elevada.
C) TSH baja y T4 libre baja.
D) TSH normal y T4 libre elevada.

Retroalimentación:
El hipotiroidismo primario se manifiesta con enlentecimiento metabólico: fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío y piel seca. La alteración típica es elevación de TSH con disminución de T4 libre.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: CIRROSIS HEPÁTICA DESCOMPENSADA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Masculino de 56 años con antecedente de alcoholismo crónico consulta por

aumento del perímetro abdominal, edema en miembros inferiores y episodios de somnolencia. A la exploración presenta ictericia, circulación colateral y ascitis.

Pregunta 1
¿Cuál es la complicación que explica los episodios de somnolencia y confusión?
A) Encefalopatía hepática *
B) Hipertiroidismo.
C) Síndrome coronario agudo.
D) Litiasis renal.

Pregunta 2
¿Cuál es una manifestación clásica de hipertensión portal en este contexto?
A) Ascitis *
B) Hematuria.
C) Exoftalmos.
D) Otitis media.

Retroalimentación:
La cirrosis descompensada puede producir ascitis, encefalopatía hepática, ictericia y várices por hipertensión portal. La acumulación de toxinas nitrogenadas participa en el deterioro neurológico característico.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 61 años, hipertenso y fumador, presenta dolor opresivo retroesternal de 40 minutos de duración, irradiado a brazo izquierdo y mandíbula, acompañado de diaforesis y náusea.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?
A) Síndrome coronario agudo *
B) Costocondritis.
C) Reflujo gastroesofágico simple.
D) Crisis de ansiedad aislada.

Pregunta 2
¿Cuál es el estudio inicial indispensable para la valoración inmediata?

A) Electrocardiograma de 12 derivaciones *
B) Radiografía simple de cráneo.
C) Espirometría.
D) Uroanálisis.

Retroalimentación:
El dolor torácico opresivo con irradiación y síntomas neurovegetativos obliga a descartar síndrome coronario agudo. El electrocardiograma temprano permite identificar elevación del ST u otros cambios isquémicos y orientar el manejo inmediato.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ANEMIA FERROPÉNICA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 34 años con menorragia crónica consulta por fatiga, palpitaciones y disminución del rendimiento físico. En la biometría hemática se documenta Hb baja con VCM disminuido.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Anemia ferropénica *
B) Anemia hemolítica autoinmune.
C) Anemia aplásica.
D) Policitemia vera.

Pregunta 2
¿Cuál es el patrón de laboratorio más compatible con este padecimiento?
A) Ferritina baja *
B) Vitamina B12 elevada.
C) Reticulocitosis marcada obligatoria.
D) Bilirrubina indirecta muy elevada como hallazgo principal.

Retroalimentación:
La anemia ferropénica suele ser microcítica e hipocrómica y en mujeres jóvenes con frecuencia se relaciona con pérdidas menstruales crónicas. La ferritina baja orienta a deficiencia de hierro como causa principal.

Especialidad: Cirugía

Tema: Pancreatitis crónica (Patología Pancreática)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 55 años con antecedente de tabaquismo intenso y alcoholismo crónico de 20 años de evolución. Acude a consulta externa por presentar dolor abdominal epigástrico sordo, intermitente, que se irradia a la espalda y empeora al ingerir alimentos. En los últimos meses ha notado pérdida de peso involuntaria y evacuaciones voluminosas, fétidas y flotantes (esteatorrea). Sus laboratorios de rutina muestran una glucosa en ayuno de 145 mg/dL.

Pregunta 1

De acuerdo con la presentación clínica, ¿cuál es la tríada clásica que define los estadios avanzados de esta enfermedad?

A) Dolor epigástrico, ictericia y masa palpable (Tríada de Courvoisier).

B) Calcificaciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes mellitus. *

C) Dolor en cinturón, amilasemia elevada y signo de Cullen.

D) Hepatomegalia, ascitis y red venosa colateral.

Retroalimentación Pregunta 1:

La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria progresiva que causa daño estructural irreversible. Su etiología más común a nivel mundial es el alcoholismo. La tríada clásica de calcificaciones pancreáticas (visibles en imagen), esteatorrea (por insuficiencia exocrina) y diabetes mellitus (por insuficiencia endocrina) es patognomónica, aunque suele presentarse solo en fases muy tardías de la enfermedad.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de imagen inicial de elección, por su alta sensibilidad, para detectar las calcificaciones pancreáticas patognomónicas de esta enfermedad?

A) Ultrasonido abdominal convencional.

B) Tomografía Axial Computarizada (TAC) de abdomen sin contraste. *

C) Radiografía simple de abdomen en bipedestación.

D) Resonancia Magnética con gadolinio.

Retroalimentación Pregunta 2:

La TAC de abdomen (especialmente en su fase simple o sin contraste) es el método no invasivo de primera línea, ya que detecta las calcificaciones parenquimatosas o intraductales con excelente precisión, además de permitir visualizar atrofia glandular o dilatación del conducto pancreático principal.

Especialidad: Pediatría

Tema: Intoxicaciones por paracetamol (Urgencias Pediátricas)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Preescolar masculino de 3 años es traído al servicio de urgencias por su madre, quien refiere haberlo encontrado hace 4 horas con un frasco de jarabe de paracetamol vacío. La madre estima que el niño ingirió aproximadamente 200 mg/kg de la medicación. Al momento de la evaluación, el paciente se encuentra alerta, asintomático, con signos vitales estables y solo refiere náuseas leves.

Pregunta 1

Considerando el tiempo transcurrido desde la ingesta, ¿cuál es la herramienta clínica utilizada para determinar la probabilidad de hepatotoxicidad y la necesidad de administrar un antídoto?

A) Escala de Glasgow.

B) Criterios del King's College.

C) Nomograma de Rumack-Matthew. *

D) Escala de Silverman-Andersen.

Retroalimentación Pregunta 1:

El nomograma de Rumack-Matthew es el estándar para guiar el manejo en la intoxicación aguda por paracetamol. Relaciona la concentración sérica del fármaco con el tiempo transcurrido desde la ingesta. Para que sea interpretable, el nivel sérico debe medirse al menos 4 horas después de la ingestión (cuando se asume que la absorción y distribución están completas).

Pregunta 2

Al graficar los niveles séricos del paciente en el nomograma, estos caen en la zona de "posible toxicidad hepática". ¿Cuál es el antídoto específico de elección y su mecanismo de acción?

A) Flumazenil; Antagonista competitivo de los receptores benzodiazepínicos.

B) Naloxona; Antagonista puro de los receptores opioides.

C) N-acetilcisteína; Actúa como precursor del glutatión para neutralizar el metabolito tóxico NAPQI. *

D) Carbón activado; Bloquea la absorción intestinal del fármaco de forma selectiva.

Retroalimentación Pregunta 2:

El paracetamol se metaboliza en el hígado; una sobredosis agota las reservas de glutatión, lo que permite la acumulación del metabolito altamente tóxico NAPQI (N-acetil-p-benzoquinona imina), causando necrosis hepática. La N-acetilcisteína (NAC) repone las reservas de glutatión hepático y es altamente efectiva para prevenir el daño severo si se administra en las primeras 8 horas post-ingesta.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Edo Hiperosmolar (Complicaciones Diabetes)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 78 años con antecedente de Diabetes Mellitus tipo 2 de 15 años de diagnóstico. Es traído por paramédicos por presentar deterioro profundo del estado de alerta (estupor) y signos de deshidratación severa (mucosas secas, hundimiento ocular, pliegue cutáneo positivo). La familia refiere que cursó con una infección de vías urinarias no tratada hace una semana. Los laboratorios de urgencia muestran: Glucosa 850 mg/dL, Sodio corregido 150 mEq/L, pH 7.35, Bicarbonato 20 mEq/L, Cetonas séricas negativas y una osmolaridad sérica efectiva de 345 mOsm/kg.

Pregunta 1

Con base en los hallazgos clínicos y de laboratorio, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cetoacidosis diabética severa.

B) Estado Hiperosmolar Hiperglucémico. *

C) Hipoglucemia inducida por sulfonilureas.

D) Encefalopatía urémica aguda.

Retroalimentación Pregunta 1:

El Estado Hiperosmolar Hiperglucémico (EHH) es una complicación aguda típica de los adultos mayores con DM2. Se distingue de la cetoacidosis por una hiperglucemia extrema (frecuentemente >600 mg/dL), osmolaridad sérica elevada (>320 mOsm/kg) y ausencia de acidosis o cetosis significativa (pH >7.30, HCO_3 >18 mEq/L). La alteración del estado mental es secundaria a la deshidratación intracelular cerebral provocada por la hiperosmolaridad.

Pregunta 2

¿Cuál es la medida terapéutica inicial de mayor prioridad durante la primera hora de atención en este paciente?

A) Administrar un bolo intravenoso de 10 unidades de insulina regular.

B) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio al 8.4%.

C) Reanimación agresiva con líquidos intravenosos (solución salina isotónica al 0.9%). *

D) Administrar antibióticos de amplio espectro de forma profiláctica.

Retroalimentación Pregunta 2:

Al igual que en la cetoacidosis, el pilar fundamental y más urgente en el EHH es la reposición de líquidos. El déficit de agua libre en estos pacientes es masivo (frecuentemente de 9 a 12 litros). La reanimación inicial con cristaloides isotónicos restaura el volumen intravascular, mejora la perfusión tisular y la tasa de filtración glomerular, lo que por sí solo disminuye drásticamente los niveles de glucosa en sangre antes de siquiera administrar insulina.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Trichomonas (Patología Infecciosa Cervical)

Dificultad: Baja

Caso Clínico

Mujer de 26 años acude a consulta por presentar flujo vaginal abundante de aparición reciente, el cual describe como amarillento-verdoso, espumoso y con mal olor. Refiere también ardor al orinar (disuria) y dolor durante las relaciones sexuales. A la exploración física con espéculo, se observa el flujo descrito y el cérvix presenta múltiples hemorragias puntiformes en la mucosa.

Pregunta 1

El hallazgo a la exploración de las hemorragias puntiformes se conoce como "cérvix en fresa". ¿Cuál es el agente etiológico responsable de esta patología?

A) Candida albicans.

B) Neisseria gonorrhoeae.

C) Gardnerella vaginalis.

D) Trichomonas vaginalis. *

Retroalimentación Pregunta 1:

La tricomoniasis es causada por *Trichomonas vaginalis*, un protozoario flagelado. Su cuadro clínico clásico incluye un flujo amarillo-verdoso, espumoso y fétido. El hallazgo de petequias o hemorragias subepiteliales en el cérvix (colpitis macular o "cérvix en fresa") es altamente específico y patognomónico de esta infección de transmisión sexual.

Pregunta 2

De acuerdo con las guías de tratamiento, ¿cuál es el fármaco de elección para esta paciente y qué indicación adicional es obligatoria?

A) Fluconazol oral; no es necesario tratar a la pareja.

B) Clindamicina en crema vaginal; indicar abstinencia temporal.

C) Metronidazol oral; es mandatorio tratar a la pareja sexual de forma simultánea. *

D) Azitromicina dosis única; profilaxis para otras ITS.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento de elección para erradicar *T. vaginalis* es el Metronidazol por vía oral (ya sea en dosis única de 2g o un esquema de 7 días). Al ser considerada estrictamente una enfermedad de transmisión sexual (ETS), es imperativo brindar

tratamiento simultáneo a las parejas sexuales de la paciente para cortar la cadena de transmisión y evitar la reinfección (efecto ping-pong).

Especialidad: Pediatría

Tema: Púrpura de Henoch Schonlein (Especialidades Pedia)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Niño de 6 años de edad es traído a consulta por presentar dolor abdominal tipo cólico difuso y dolor en ambas rodillas y tobillos (artralgias). La madre refiere que hace una semana el niño cursó con una infección de vías respiratorias superiores. A la exploración física, los signos vitales son normales, pero destaca la presencia de lesiones purpúricas palpables, no pruriginosas, distribuidas simétricamente en las nalgas y en las extremidades inferiores. El recuento de plaquetas es de 250,000/mm^3.

Pregunta 1

Ante la presencia de púrpura palpable con plaquetas normales, ¿cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Púrpura Trombocitopénica Inmunitaria (PTI).

B) Enfermedad de Kawasaki.

C) Púrpura de Henoch-Schönlein. *

D) Meningococcemia.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Púrpura de Henoch-Schönlein (vasculitis por IgA) es la vasculitis sistémica más común en la infancia. Se caracteriza clásicamente por la tétrada de: púrpura palpable (típicamente en extremidades inferiores y glúteos), artritis/artralgias, dolor abdominal y afectación renal. A diferencia de la PTI, el recuento plaquetario es rigurosamente normal o incluso elevado.

Pregunta 2

¿Cuál es la fisiopatología subyacente que provoca la inflamación de los pequeños vasos en esta enfermedad?

A) Depósito de inmunocomplejos formados por Inmunoglobulina A (IgA) en las paredes vasculares. *

B) Producción de autoanticuerpos IgG dirigidos contra las glucoproteínas plaquetarias IIb/IIIa.

C) Daño endotelial directo mediado por exotoxinas estafilocócicas.

D) Infiltración linfocítica masiva de las arterias de mediano y gran calibre.

Retroalimentación Pregunta 2:

El mecanismo patogénico central es una respuesta inmune anómala (frecuentemente desencadenada por una infección respiratoria previa) que resulta en la formación y depósito de inmunocomplejos de IgA en los vasos sanguíneos de pequeño calibre (vasculitis leucocitoclástica), afectando principalmente piel, tracto gastrointestinal, articulaciones y riñones.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: DPPNI (Hemorragias del Segundo Trimestre)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 32 años, cursando su segunda gestación a las 36 semanas. Cuenta con diagnóstico reciente de preeclampsia. Ingresa a urgencias por presentar dolor abdominal intenso y de inicio brusco, acompañado de sangrado transvaginal de color rojo oscuro (vinoso). A la exploración física, la tensión arterial es de 160/100 mmHg y a la palpación abdominal el útero se encuentra hipertónico (con consistencia "de

madera") y muy doloroso. El registro cardiotocográfico muestra bradicardia fetal sostenida de 90 lpm.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según el temario de Hemorragias del Segundo/Tercer Trimestre?

A) Placenta previa.

B) Ruptura uterina.

C) Vasa previa.

D) Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoincerta (DPPNI). *

Retroalimentación Pregunta 1:

El DPPNI (Abruptio placentae) se presenta con la tríada clásica de: sangrado vaginal oscuro, dolor abdominal/pélvico agudo e hipertonía uterina o polisistolia. El antecedente de enfermedad hipertensiva del embarazo (preeclampsia) es el factor de riesgo materno más fuertemente asociado a esta complicación. En la placenta previa, el sangrado es rojo rutilante, indoloro y con tono uterino normal.

Pregunta 2

Ante los hallazgos descritos y el estado del feto, ¿cuál es la conducta obstétrica de elección y más urgente?

A) Administración de tocolíticos para relajar el útero.

B) Realización de cesárea de urgencia. *

C) Inducción del trabajo de parto con oxitocina.

D) Manejo expectante y vigilancia con ultrasonido.

Retroalimentación Pregunta 2:

El desprendimiento placentario compromete drásticamente el intercambio de oxígeno, llevando rápidamente a hipoxia y acidosis fetal. La presencia de bradicardia

fetal sostenida (sufrimiento fetal agudo) en el contexto de un DPPNI es una indicación absoluta e impostergable para la interrupción del embarazo mediante cesárea de emergencia para salvar la vida del feto y prevenir complicaciones maternas como la coagulación intravascular diseminada (CID).

Especialidad: Cirugía

Tema: Hepatitis agudas y crónicas (Patología Hepática)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 25 años, sin antecedentes médicos relevantes, acude a consulta por presentar desde hace 5 días astenia marcada, hiporexia, náuseas, dolor en hipocondrio derecho y fiebre de bajo grado. Hoy notó que sus escleras están amarillas (ictericia), su orina es muy oscura (coluria) y sus heces son pálidas (acolia). Refiere haber comido mariscos crudos en un puesto callejero hace un mes. Las pruebas de función hepática muestran ALT de 1,200 U/L y AST de 1,050 U/L.

Pregunta 1

De acuerdo con la vía de transmisión y la presentación clínica aguda, ¿cuál es el agente etiológico viral más probable?

A) Virus de la Hepatitis A (VHA). *

B) Virus de la Hepatitis B (VHB).

C) Virus de la Hepatitis C (VHC).

D) Virus de la Hepatitis D (VHD).

Retroalimentación Pregunta 1:

El Virus de la Hepatitis A es típicamente responsable de brotes de hepatitis aguda autolimitada. Se transmite por vía fecal-oral, frecuentemente por el consumo de agua o alimentos contaminados (como mariscos crudos o mal cocidos). Produce una elevación masiva de las transaminasas (>1,000 U/L) acompañada del síndrome ictérico clásico. No cronifica.

Pregunta 2

¿Cuál es el marcador serológico específico que confirmaría la infección aguda por este virus en el paciente?

A) Anti-VHA IgG positivo.

B) Antígeno de superficie (HBsAg) positivo.

C) Anti-VHC positivo.

D) Anti-VHA IgM positivo. *

Retroalimentación Pregunta 2:

Para confirmar el diagnóstico de infección aguda por Hepatitis A, se requiere la detección del anticuerpo de tipo IgM contra el virus (Anti-VHA IgM), el cual aparece precozmente y desaparece en unos meses. La presencia exclusiva de Anti-VHA IgG indicaría una infección pasada, resuelta y que el paciente tiene inmunidad de por vida.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Enfermedad de Graves (Patología Tiroidea)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 32 años acude por pérdida de peso de 6 kg en los últimos dos meses a pesar de tener el apetito conservado. Refiere palpitaciones frecuentes, nerviosismo, insomnio y diarrea ocasional. A la exploración física, se observa temblor fino en las manos, piel caliente y sudorosa, retracción palpebral superior y proptosis bilateral (exoftalmos). En el cuello se palpa una glándula tiroides aumentada de tamaño de forma difusa, simétrica y no dolorosa.

Pregunta 1

¿Cuál es el autoanticuerpo directamente responsable de la fisiopatología de esta enfermedad?

A) Anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (Anti-TPO).

B) Anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI / TRAb). *

C) Anticuerpos anti-tiroglobulina (Anti-Tg).

D) Anticuerpos antinucleares (ANA).

Retroalimentación Pregunta 1:

La Enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune causado por la producción de inmunoglobulinas que se unen y activan constitutivamente el receptor de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Estos anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI o TRAb) provocan la hipertrofia de la glándula (bocio difuso) y la hiperproducción de hormonas tiroideas (hipertiroidismo).

Pregunta 2

De acuerdo con las guías clínicas, ¿cuál es el tratamiento farmacológico antitiroideo de primera línea de elección en esta paciente (no embarazada) para lograr el eutiroidismo?

A) Levotiroxina sódica.

B) Yodo radiactivo (I-131) como primera opción obligatoria.

C) Tiamazol (Metimazol). *

D) Propiltiouracilo (PTU).

Retroalimentación Pregunta 2:

Las tionamidas son el pilar del tratamiento médico del hipertiroidismo. El Tiamazol (Metimazol) es el fármaco de primera línea debido a su perfil de seguridad, menor hepatotoxicidad y mayor comodidad posológica (puede darse en dosis única diaria) en comparación con el Propiltiouracilo (PTU). El PTU se reserva principalmente para el primer trimestre del embarazo o en casos de tormenta tiroidea severa.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: ABRUPTIO PLACENTAE
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 35 años, G2P1, con 36 semanas de gestación, acude por dolor abdominal súbito e intenso, acompañado de sangrado transvaginal oscuro y disminución de movimientos fetales. A la exploración presenta hipertonicidad uterina y taquicardia materna.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta *
B) Placenta previa.
C) Ruptura uterina.
D) Amenaza de parto pretérmino.

Retroalimentación:
La combinación de dolor abdominal intenso, sangrado oscuro e hipertonía uterina orienta a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. A diferencia de la placenta previa, aquí el sangrado suele acompañarse de dolor y aumento del tono uterino.

Pregunta 2
¿Cuál es el dato clínico que más ayuda a diferenciarlo de placenta previa?
A) Dolor abdominal con útero hipertónico *
B) Sangrado rojo brillante.
C) Antecedente de cesárea previa.
D) Multigestación.

Retroalimentación:
En el desprendimiento prematuro de placenta el útero suele estar doloroso e

hipertónico. En la placenta previa, el sangrado clásicamente es indoloro y el útero se palpa relajado.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: ECLAMPSIA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Primigesta de 19 años con 33 semanas de gestación llega a urgencias tras presentar una convulsión tónico-clónica generalizada. Tiene antecedente de cefalea intensa, fosfenos y edema en las últimas 24 horas. TA 170/110 mmHg.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Eclampsia *
B) Epilepsia de novo.
C) Crisis conversiva.
D) Hipoglucemia aislada.

Retroalimentación:
La eclampsia se define por la presencia de convulsiones en una paciente con datos de preeclampsia y sin otra causa que las explique. La hipertensión, la cefalea y los fosfenos refuerzan este diagnóstico.

Pregunta 2
¿Cuál es el tratamiento anticonvulsivo de elección?
A) Sulfato de magnesio *
B) Fenobarbital.
C) Carbamazepina.
D) Fenitoína como primera elección universal.

Retroalimentación:
El sulfato de magnesio es el fármaco de elección para prevenir y tratar convulsiones en preeclampsia y eclampsia. Otros anticonvulsivos pueden usarse en situaciones especiales, pero no desplazan al magnesio como primera línea.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: EMBARAZO MOLAR
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 21 años con amenorrea de 12 semanas, náusea y vómito intensos, además de sangrado transvaginal escaso. El útero se palpa mayor al esperado para edad gestacional y el ultrasonido reporta imagen en “tormenta de nieve”.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Mola hidatidiforme *
B) Embarazo ectópico.
C) Aborto diferido.
D) Miomatosis uterina.

Retroalimentación:
El crecimiento uterino mayor al esperado, la hiperémesis y la imagen ultrasonográfica en “tormenta de nieve” son hallazgos clásicos de enfermedad trofoblástica gestacional, especialmente mola hidatidiforme.

Pregunta 2
¿Cuál es el marcador útil para seguimiento posterior al tratamiento?
A) BHCG sérica *
B) CA 125.
C) Alfafetoproteína.
D) Antígeno carcinoembrionario.

Retroalimentación:
La cuantificación seriada de BHCG permite valorar la respuesta al tratamiento y detectar enfermedad persistente o progresión a neoplasia trofoblástica gestacional.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: EXANTEMA SÚBITO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Lactante de 14 meses presenta fiebre alta de 3 días de evolución, sin foco claro. Al ceder la fiebre, aparece exantema maculopapular rosado que inicia en tronco y se extiende a cuello y extremidades.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Exantema súbito *

B) Sarampión.
C) Rubéola.
D) Escarlatina.

Retroalimentación:
El exantema súbito se caracteriza por fiebre elevada de varios días que desaparece bruscamente y da paso al exantema. La secuencia temporal es muy sugerente.

Pregunta 2
¿Cuál es el agente etiológico más frecuente?
A) Herpesvirus humano tipo 6 *
B) Parvovirus B19.
C) Adenovirus.
D) Virus influenza.

Retroalimentación:
El herpesvirus humano 6 es la causa más común de exantema súbito. Afecta sobre todo a lactantes y niños pequeños.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: CRISIS FEBRILES
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niño de 2 años previamente sano presenta una convulsión generalizada de 3 minutos de duración durante un episodio febril por infección respiratoria alta. Después del evento se recupera por completo y no tiene déficit neurológico.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Crisis febril simple *
B) Epilepsia.
C) Meningitis bacteriana.
D) Crisis de ausencia.

Retroalimentación:
La crisis febril simple ocurre entre los 6 meses y 5 años, es generalizada, dura menos de 15 minutos y no recurre dentro de 24 horas. El niño se recupera sin secuelas neurológicas inmediatas.

Pregunta 2
¿Cuál de las siguientes características apoya que sea una crisis febril simple?
A) Duración menor de 15 minutos *
B) Focalidad neurológica posterior.
C) Repetición varias veces en el mismo día.
D) Presencia de signos meníngeos.

Retroalimentación:
La duración corta, el carácter generalizado y la ausencia de recurrencia en 24 horas son criterios de crisis febril simple. La focalidad o recurrencia obligan a ampliar el abordaje.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: DESHIDRATACIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Lactante de 11 meses con diarrea y vómito de 2 días de evolución. A la exploración presenta irritabilidad, mucosas secas, ojos hundidos y llenado capilar ligeramente prolongado. Tolera la vía oral.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?
A) Deshidratación leve a moderada *
B) Shock séptico.
C) Abdomen agudo obstructivo.
D) Cetoacidosis diabética.

Retroalimentación:
Los datos clínicos descritos orientan a deshidratación leve a moderada, especialmente por la irritabilidad, las mucosas secas y los ojos hundidos sin datos claros de choque.

Pregunta 2
¿Cuál es la medida terapéutica inicial más adecuada si tolera vía oral?
A) Solución de rehidratación oral *
B) Ayuno absoluto por 24 horas.
C) Antibiótico intravenoso obligatorio.
D) Diurético de asa.

Retroalimentación:
La rehidratación oral es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos de deshidratación leve a moderada por diarrea aguda, siempre que el paciente tolere la vía oral.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: PANCREATITIS AGUDA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 48 años con antecedente de litiasis vesicular consulta por dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, acompañado de náusea y vómito. Refiere que el dolor empeora en decúbito y mejora ligeramente al inclinarse hacia adelante.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Pancreatitis aguda *
B) Colecistitis crónica.
C) Úlcera péptica perforada.
D) Hepatitis viral.

Retroalimentación:
El dolor epigástrico irradiado a la espalda, con náusea y vómito, es clásico de pancreatitis aguda. La litiasis vesicular es una de las causas más frecuentes.

Pregunta 2
¿Cuál es la etiología más probable en esta paciente?
A) Biliar *
B) Traumática.
C) Autoinmune.
D) Farmacológica.

Retroalimentación:
En una paciente con antecedente de litiasis vesicular, la etiología biliar es la causa más probable. La obstrucción transitoria de la ampolla puede desencadenar inflamación pancreática.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: ÚLCERA PÉPTICA PERFORADA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Masculino de 54 años con antecedente de uso crónico de AINE presenta dolor abdominal súbito, intenso y generalizado. A la exploración tiene abdomen rígido, con defensa involuntaria y datos de irritación peritoneal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Perforación de víscera hueca por úlcera péptica *
B) Gastroenteritis aguda.
C) Colitis funcional.
D) Diverticulosis no complicada.

Retroalimentación:
El dolor súbito intenso con abdomen en tabla y signos de irritación peritoneal es muy sugestivo de perforación de víscera hueca. El antecedente de AINE aumenta la probabilidad de úlcera péptica complicada.

Pregunta 2
¿Cuál es el hallazgo radiológico clásico si se solicita una placa de tórax o abdomen en bipedestación?
A) Neumoperitoneo *
B) Derrame pleural bilateral.
C) Calcificación pancreática.
D) Niveles hidroaéreos colónicos aislados.

Retroalimentación:
La presencia de aire libre subdiafragmático en estudios simples es un hallazgo clásico de perforación gastrointestinal y apoya el diagnóstico de neumoperitoneo.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: CRISIS ASMÁTICA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 24 años con antecedente de asma presenta disnea, sibilancias

generalizadas y sensación de opresión torácica tras exposición a polvo. Habla con frases cortas y utiliza musculatura accesoria.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Exacerbación aguda de asma *
B) Neumotórax a tensión.
C) Edema agudo pulmonar cardiogénico.
D) Tromboembolia pulmonar masiva.

Retroalimentación:
La disnea, las sibilancias y la opresión torácica en un paciente asmático orientan a crisis asmática. El uso de músculos accesorios sugiere mayor gravedad.

Pregunta 2
¿Cuál es el tratamiento broncodilatador inicial de elección?
A) Salbutamol inhalado de acción corta *
B) Montelukast como único manejo agudo.
C) Teofilina oral como primera medida.
D) Antibiótico empírico en todos los casos.

Retroalimentación:
Los agonistas beta 2 de acción corta inhalados son la base del manejo inicial de la exacerbación asmática. Montelukast y otros fármacos no sustituyen esta intervención en la fase aguda.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 58 años, posoperada de reemplazo de rodilla hace 10 días, presenta dolor y aumento de volumen en pantorrilla izquierda. A la exploración hay edema unilateral y dolor a la palpación profunda.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Trombosis venosa profunda *
B) Linfedema congénito.

C) Esguince de tobillo.
D) Insuficiencia arterial aguda.

Retroalimentación:
El antecedente de cirugía reciente, junto con edema y dolor unilateral en extremidad inferior, orienta a trombosis venosa profunda.

Pregunta 2
¿Cuál es la complicación aguda más temida de este padecimiento?
A) Tromboembolia pulmonar *
B) Endocarditis infecciosa.
C) Pericarditis constrictiva.
D) Hemorragia subaracnoidea.

Retroalimentación:
La tromboembolia pulmonar es la complicación más grave de una trombosis venosa profunda, ya que un fragmento del trombo puede migrar a la circulación pulmonar.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: INSUFICIENCIA CARDIACA IZQUIERDA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Hombre de 72 años con antecedente de hipertensión y cardiopatía isquémica consulta por disnea progresiva, ortopnea y disnea paroxística nocturna. A la auscultación tiene estertores bibasales.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Insuficiencia cardiaca izquierda *
B) EPOC estable.
C) Neumonía lobar.
D) Crisis de ansiedad.

Retroalimentación:
La ortopnea, la disnea paroxística nocturna y los estertores bibasales son manifestaciones clásicas de congestión pulmonar secundaria a insuficiencia cardiaca izquierda.

Pregunta 2
¿Cuál es un hallazgo clínico esperado por congestión pulmonar?

A) Estertores bibasales *
B) Hipersonoridad generalizada.
C) Soplo carotídeo aislado.
D) Rigidez de nuca.

Retroalimentación:
La acumulación de líquido en el intersticio y los alvéolos pulmonares produce estertores, sobre todo en bases, en pacientes con insuficiencia cardiaca izquierda.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Paciente masculino de 47 años acude a revisión. Se documentan cifras tensionales de 152/96 mmHg y 150/94 mmHg en dos mediciones separadas, sin síntomas asociados. Niega antecedente de enfermedad renal conocida.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hipertensión arterial sistémica *
B) Hipotensión ortostática.
C) Emergencia hipertensiva.
D) Síncope vasovagal.

Retroalimentación:
La persistencia de cifras tensionales elevadas en mediciones separadas apoya el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, incluso en ausencia de síntomas.

Pregunta 2
¿Cuál de los siguientes datos sugeriría una urgencia o emergencia hipertensiva y no hipertensión crónica asintomática?
A) Datos de daño agudo a órgano blanco *
B) Cefalea tensional ocasional.
C) Ansiedad durante la consulta.
D) Edad mayor de 40 años.

Retroalimentación:
La presencia de daño agudo a órgano blanco, como alteración neurológica, edema

pulmonar o lesión renal aguda, cambia el contexto a urgencia o emergencia hipertensiva y modifica el manejo.

Especialidad: Pediatría

Tema: Vacunación

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante de 2 meses de edad es traído por su madre a la consulta de niño sano para su revisión y aplicación de inmunizaciones correspondientes. El paciente nació a término, sin complicaciones, y recibió las vacunas BCG y Hepatitis B al nacer. Actualmente se encuentra asintomático, con peso y talla en el percentil 50.

Pregunta 1

De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación en México, ¿cuáles son las vacunas que deben administrarse en esta visita de los 2 meses?

A) DPT, Rotavirus y Triple Viral (SRP).

B) Hexavalente acelular, Rotavirus y Neumocócica conjugada. *

C) Pentavalente, Hepatitis A y Varicela.

D) Hexavalente acelular, VPH y Neumocócica polisacárida.

Retroalimentación Pregunta 1:

A los 2 meses de edad, el esquema primario de inmunización marca la aplicación de la primera dosis de tres vacunas fundamentales: la Hexavalente acelular (DTPa-VIP-Hib-HepB), la vacuna contra el Rotavirus y la vacuna Neumocócica conjugada.

Pregunta 2

Si este paciente tuviera el antecedente médico de haber presentado una invaginación intestinal corregida el mes pasado, ¿cuál de las siguientes vacunas estaría absolutamente contraindicada?

A) Vacuna Hexavalente.

B) Vacuna Neumocócica conjugada.

C) Vacuna contra Rotavirus. *

D) Vacuna contra Hepatitis B.

Retroalimentación Pregunta 2:

La vacuna contra el rotavirus es de virus vivos atenuados y se administra por vía oral. Su aplicación está estrictamente contraindicada en lactantes con antecedente de invaginación intestinal o con malformaciones congénitas no corregidas del tracto gastrointestinal (como el divertículo de Meckel), debido al riesgo incrementado de desencadenar un nuevo cuadro de intususcepción.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Artritis reumatoide (Reumatología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 45 años acude a consulta por presentar dolor, inflamación y rigidez matutina de más de 1 hora de duración en ambas manos, muñecas y rodillas. El cuadro tiene 3 meses de evolución. A la exploración física, se documenta sinovitis simétrica en articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales bilaterales, con dolor a la compresión lateral (signo de Morton positivo).

Pregunta 1

Para confirmar la sospecha diagnóstica, se solicitan estudios inmunológicos. ¿Cuál es el autoanticuerpo que posee la mayor especificidad diagnóstica y valor pronóstico para esta enfermedad?

A) Factor Reumatoide (FR).

B) Anticuerpos Antinucleares (ANA).

C) Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (Anti-CCP). *

D) Anticuerpos anti-DNA de doble cadena.

Retroalimentación Pregunta 1:

Aunque el Factor Reumatoide es muy sensible y clásico en la Artritis Reumatoide, los Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) tienen una especificidad mucho mayor (hasta del 95-98%). Además, suelen aparecer en fases tempranas de la enfermedad y se asocian a un pronóstico más severo y erosivo.

Pregunta 2

Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cuál es el Fármaco Modificador de la Enfermedad (FAME) sintético convencional de primera línea que debe iniciarse de inmediato para detener el daño estructural?

A) Prednisona a dosis altas.

B) Metotrexato. *

C) Ibuprofeno horario.

D) Infliximab.

Retroalimentación Pregunta 2:

El Metotrexato es la piedra angular y el FAME de primera elección en el tratamiento de la Artritis Reumatoide. Su inicio temprano (ventana de oportunidad) retrasa la progresión radiográfica y previene la discapacidad. Los AINEs y los glucocorticoides se utilizan únicamente como terapia "puente" para el control rápido de los síntomas inflamatorios, pero no modifican el curso de la enfermedad.

Especialidad: Cirugía

Tema: Apendicitis

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 24 años, cursando un embarazo de 20 semanas de gestación. Acude a urgencias por dolor abdominal de 12 horas de evolución que inició en epigastrio y posteriormente migró al flanco derecho y cuadrante inferior derecho. Presenta náuseas y un episodio de vómito. Sus signos vitales muestran taquicardia leve y temperatura de 37.8°C. Los laboratorios reportan leucocitosis de 14,000/mm^3 con neutrofilia.

Pregunta 1

Ante la sospecha de un cuadro apendicular en esta paciente embarazada, ¿cuál es el estudio de imagen inicial de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Tomografía Computarizada (TAC) de abdomen y pelvis.

B) Radiografía simple de abdomen.

C) Ultrasonido abdominal con compresión graduada. *

D) Gammagrama con leucocitos marcados.

Retroalimentación Pregunta 1:

En la paciente embarazada, el Ultrasonido abdominal es el estudio de imagen de primera línea para evaluar patología del cuadrante inferior derecho, debido a su seguridad al no emitir radiación ionizante (que puede ser teratogénica). Si el ultrasonido no es concluyente, el siguiente paso ideal es la Resonancia Magnética sin gadolinio.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes escalas clínicas y de laboratorio es la más utilizada internacionalmente para estratificar el riesgo y la probabilidad diagnóstica en cuadros de dolor en fosa iliaca derecha?

A) Escala de Alvarado. *

B) Criterios de Ranson.

C) Escala de Glasgow-Blatchford.

D) Criterios de Tokio.

Retroalimentación Pregunta 2:

La escala de Alvarado es una herramienta clínica muy validada para la sospecha de apendicitis aguda. Evalúa la migración del dolor, anorexia, náuseas/vómitos, dolor en cuadrante inferior derecho, signo de rebote, fiebre, leucocitosis y desviación a la izquierda. Un puntaje de 7 o más indica una alta probabilidad de requerir intervención quirúrgica.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Cáncer de Mama

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 58 años de edad, asintomática, acude a su chequeo anual con los resultados de su mastografía de tamizaje. No tiene antecedentes familiares de neoplasias. El reporte radiológico describe la presencia de una masa densa, espiculada, de 2.5 cm en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, acompañada de microcalcificaciones pleomórficas agrupadas. La piel se observa engrosada.

Pregunta 1

De acuerdo con el sistema de reporte, ¿qué categoría BI-RADS le corresponde a este hallazgo y qué conducta clínica indica?

A) BI-RADS 3; Probablemente benigno, seguimiento en 6 meses.

B) BI-RADS 4; Sospecha de malignidad, requiere biopsia.

C) BI-RADS 5; Altamente sugestivo de malignidad, requiere biopsia obligatoria. *

D) BI-RADS 6; Malignidad comprobada, planear cirugía.

Retroalimentación Pregunta 1:

La categoría BI-RADS 5 se asigna cuando los hallazgos radiológicos (como una masa espiculada con microcalcificaciones pleomórficas y cambios cutáneos) tienen una probabilidad de malignidad igual o superior al 95%. La conducta ineludible es realizar una biopsia con aguja de corte (tru-cut) para el diagnóstico histopatológico definitivo.

Pregunta 2

Al recibir el reporte de patología de la biopsia, se confirma una neoplasia maligna invasora. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama infiltrante a nivel mundial?

A) Carcinoma lobulillar infiltrante.

B) Carcinoma ductal infiltrante (o sin tipo especial). *

C) Carcinoma medular.

D) Enfermedad de Paget de la mama.

Retroalimentación Pregunta 2:

El carcinoma ductal infiltrante (actualmente denominado por la OMS como carcinoma invasor de tipo no especial) es la variedad histológica más común, representando aproximadamente entre el 70% y el 80% de todos los cánceres de mama invasivos. Su diseminación ocurre tempranamente hacia los ganglios linfáticos axilares.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: INCOMPATIBILIDAD Rh
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 24 años, G2P1, con 30 semanas de gestación, acude a control prenatal. Refiere que en su embarazo previo tuvo un recién nacido con ictericia intensa en los primeros días de vida. En este embarazo se documenta que la madre es Rh negativo y la pareja Rh positivo.

Pregunta 1
¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de este padecimiento?
A) Formación de anticuerpos maternos contra eritrocitos fetales *
B) Deficiencia fetal de hierro.
C) Hemorragia placentaria masiva obligatoria.
D) Alteración congénita de la médula ósea fetal.

Retroalimentación:
La incompatibilidad Rh ocurre cuando una madre Rh negativa se sensibiliza al antígeno D y desarrolla anticuerpos que atraviesan la placenta y destruyen eritrocitos fetales Rh positivos.

Pregunta 2
¿Cuál es la medida preventiva más importante en pacientes no sensibilizadas?
A) Aplicación de inmunoglobulina anti-D *
B) Administración de hierro oral.
C) Restricción de actividad física.
D) Uso rutinario de antibióticos.

Retroalimentación:
La inmunoglobulina anti-D previene la sensibilización materna al neutralizar eritrocitos fetales Rh positivos que hayan pasado a la circulación materna.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 27 años con 32 semanas de gestación presenta dolor tipo cólico en hipogastrio y contracciones uterinas regulares desde hace 3 horas. A la exploración

obstétrica se documenta borramiento cervical del 60% y dilatación de 3 cm. No hay datos de corioamnionitis.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Trabajo de parto pretérmino *
B) Amenaza de aborto.
C) Placenta previa.
D) Ruptura uterina.

Retroalimentación:
El trabajo de parto pretérmino se define por contracciones uterinas regulares acompañadas de cambios cervicales antes de las 37 semanas de gestación.

Pregunta 2
¿Cuál es un objetivo importante del uso de tocolíticos en este contexto?
A) Ganar tiempo para maduración pulmonar fetal *
B) Curar definitivamente la causa del parto pretérmino.
C) Evitar toda vía de parto vaginal futura.
D) Disminuir el líquido amniótico.

Retroalimentación:
Los tocolíticos no resuelven la causa de fondo, pero pueden retrasar temporalmente el parto para permitir la administración de corticosteroides antenatales.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: CÁNCER CERVICOUTERINO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 43 años consulta por sangrado transvaginal poscoital y leucorrea persistente. Inició vida sexual a los 15 años y ha tenido múltiples parejas sexuales. No cuenta con tamizaje cervicouterino reciente.

Pregunta 1
¿Cuál es el principal factor etiológico asociado a este padecimiento?
A) Infección persistente por VPH de alto riesgo *
B) Deficiencia de progesterona.
C) Hiperprolactinemia.
D) Miomatosis uterina.

Retroalimentación:
La infección persistente por virus del papiloma humano de alto riesgo, especialmente tipos oncogénicos, es el principal factor implicado en la génesis del cáncer cervicouterino.

Pregunta 2
¿Cuál es un síntoma clásico de presentación clínica?
A) Sangrado poscoital *
B) Amenorrea primaria.
C) Galactorrea.
D) Prurito palmoplantar aislado.

Retroalimentación:
El sangrado poscoital es un dato de alarma frecuente en lesiones cervicales malignas o premalignas y obliga a una evaluación ginecológica completa.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: CONJUNTIVITIS BACTERIANA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Escolar de 7 años presenta ojo rojo bilateral, sensación de cuerpo extraño y secreción abundante amarillenta desde hace 2 días. Refiere que al despertar tiene los párpados pegados.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Conjuntivitis bacteriana *
B) Uveítis anterior.
C) Glaucoma agudo.
D) Queratocono.

Retroalimentación:
La secreción purulenta abundante y los párpados pegados por la mañana son hallazgos típicos de conjuntivitis bacteriana.

Pregunta 2
¿Cuál es el dato clínico que más orienta al origen bacteriano?
A) Secreción purulenta *
B) Fotofobia intensa severa.

C) Dolor ocular profundo.
D) Midriasis fija.

Retroalimentación:
Aunque el ojo rojo tiene múltiples causas, la presencia de secreción purulenta es especialmente sugestiva de etiología bacteriana.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Niño de 8 años con antecedente reciente de infección respiratoria alta, que inicia con dolor abdominal, artralgias en tobillos y rodillas, y lesiones purpúricas palpables en extremidades inferiores y glúteos.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Púrpura de Henoch-Schönlein *
B) Trombocitopenia inmune primaria.
C) Enfermedad meningocócica invasiva.
D) Hemofilia A.

Retroalimentación:
La vasculitis por IgA suele presentarse con la tétrada de púrpura palpable, artralgias, dolor abdominal y afección renal, con predominio en extremidades inferiores y glúteos.

Pregunta 2
¿Cuál es una complicación que debe vigilarse durante la evolución?
A) Afección renal *
B) Miocardiopatía hipertrófica.
C) Catarata congénita.
D) Atresia esofágica.

Retroalimentación:
La nefropatía por IgA puede aparecer como hematuria o proteinuria, por lo que es importante vigilar la función renal y el examen general de orina.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: PAROTIDITIS
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niño de 9 años presenta fiebre, malestar general y aumento de volumen doloroso en región parotídea bilateral. Refiere dolor al masticar y al ingerir alimentos ácidos.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Parotiditis viral *
B) Absceso retrofaríngeo.
C) Adenitis cervical supurada.
D) Laringitis espasmódica.

Retroalimentación:
La tumefacción dolorosa de glándulas parótidas, con fiebre y dolor al masticar, es característica de parotiditis, clásicamente de origen viral.

Pregunta 2
¿Cuál es una complicación clásica en adolescentes y adultos?
A) Orquitis *
B) Apendicitis.
C) Hernia umbilical.
D) Atresia biliar.

Retroalimentación:
La orquitis es una complicación conocida de la infección por virus de parotiditis, sobre todo en pacientes postpuberales.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: DIVERTICULITIS AGUDA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente masculino de 63 años presenta dolor abdominal en fosa iliaca izquierda, fiebre y alteraciones del hábito intestinal. A la exploración existe dolor localizado sin datos francos de irritación peritoneal generalizada.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Diverticulitis aguda *
B) Apendicitis aguda típica.
C) Colecistitis aguda.
D) Torsión testicular.

Retroalimentación:
La diverticulitis aguda suele presentarse con dolor en fosa iliaca izquierda, fiebre y cambios del tránsito intestinal, especialmente en adultos mayores.

Pregunta 2
¿Cuál es el sitio anatómico más frecuentemente afectado?
A) Colon sigmoides *
B) Ciego.
C) Yeyuno proximal.
D) Conducto colédoco.

Retroalimentación:
El colon sigmoides es la localización más habitual de enfermedad diverticular sintomática en adultos.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 76 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito e intenso, desproporcionado a los hallazgos iniciales de la exploración física. Posteriormente desarrolla distensión y deterioro hemodinámico.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Isquemia mesentérica aguda *
B) Colelitiasis no complicada.
C) Gastritis erosiva.
D) Litiasis renal.

Retroalimentación:
El dolor abdominal intenso desproporcionado a la exploración en un paciente con factores de riesgo embólicos, como fibrilación auricular, es muy sugerente de isquemia mesentérica aguda.

Pregunta 2
¿Cuál es el principal factor predisponente en este caso?
A) Fibrilación auricular *
B) Hipotiroidismo subclínico.
C) Hernia hiatal.
D) Rinitis alérgica.

Retroalimentación:
La fibrilación auricular favorece fenómenos embólicos arteriales, incluyendo oclusión de vasos mesentéricos.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ENDOCARDITIS INFECCIOSA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 39 años con antecedente de valvulopatía consulta por fiebre persistente, pérdida de peso y aparición de un nuevo soplo cardiaco. Refiere antecedente reciente de procedimiento dental.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Endocarditis infecciosa *
B) Miocarditis viral.
C) Pericarditis aguda.
D) Fiebre reumática aguda.

Retroalimentación:
La fiebre persistente, el nuevo soplo y el antecedente de valvulopatía o procedimiento dental sugieren fuertemente endocarditis infecciosa.

Pregunta 2
¿Cuál es el estudio clave para documentar vegetaciones valvulares?
A) Ecocardiograma *
B) Espirometría.
C) Radiografía de rodilla.
D) Audiometría.

Retroalimentación:
El ecocardiograma permite identificar vegetaciones, abscesos o insuficiencia valvular y es central en la evaluación diagnóstica de endocarditis.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: HIPERTIROIDISMO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 31 años consulta por pérdida de peso, palpitaciones, intolerancia al calor, nerviosismo y aumento en la frecuencia de evacuaciones. A la exploración presenta temblor fino distal y taquicardia.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hipertiroidismo *
B) Hipotiroidismo.
C) Síndrome nefrótico.
D) Enfermedad de Addison.

Retroalimentación:
La pérdida de peso con apetito conservado o aumentado, palpitaciones, intolerancia al calor y temblor fino son manifestaciones clásicas de exceso de hormona tiroidea.

Pregunta 2
¿Cuál es el patrón de laboratorio más esperado?
A) TSH disminuida y T4 libre elevada *
B) TSH elevada y T4 libre disminuida.
C) TSH elevada y T4 libre normal.
D) TSH normal y T4 libre baja.

Retroalimentación:
En el hipertiroidismo primario la elevación de hormonas tiroideas suprime la secreción hipofisaria de TSH.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
Dificultad: Media

Caso Clínico
Masculino de 52 años acude por fiebre, tos productiva, disnea y dolor torácico tipo pleurítico de 4 días de evolución. A la exploración presenta estertores localizados y taquipnea.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Neumonía adquirida en la comunidad *
B) Asma intermitente.
C) Reflujo gastroesofágico.
D) Pericarditis crónica.

Retroalimentación:
La combinación de fiebre, tos productiva, dolor pleurítico y hallazgos respiratorios focales orienta a neumonía adquirida en la comunidad.

Pregunta 2
¿Cuál es un agente etiológico clásico y frecuente en adultos?
A) Streptococcus pneumoniae *
B) Giardia lamblia.
C) Plasmodium vivax.
D) Clostridium tetani.

Retroalimentación:
Streptococcus pneumoniae sigue siendo uno de los patógenos más frecuentes de neumonía adquirida en la comunidad en adultos.

Especialidad: Pediatría

Tema: Vacunación

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante de 2 meses de edad es traído por su madre a la consulta de niño sano para su revisión y aplicación de inmunizaciones correspondientes. El paciente nació a término, sin complicaciones, y recibió las vacunas BCG y Hepatitis B al nacer. Actualmente se encuentra asintomático, con peso y talla en el percentil 50.

Pregunta 1

De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación en México, ¿cuáles son las vacunas que deben administrarse en esta visita de los 2 meses?

A) DPT, Rotavirus y Triple Viral (SRP).

B) Hexavalente acelular, Rotavirus y Neumocócica conjugada. *

C) Pentavalente, Hepatitis A y Varicela.

D) Hexavalente acelular, VPH y Neumocócica polisacárida.

Retroalimentación Pregunta 1:

A los 2 meses de edad, el esquema primario de inmunización marca la aplicación de la primera dosis de tres vacunas fundamentales: la Hexavalente acelular (DTPa-VIP-Hib-HepB), la vacuna contra el Rotavirus y la vacuna Neumocócica conjugada.

Pregunta 2

Si este paciente tuviera el antecedente médico de haber presentado una invaginación intestinal corregida el mes pasado, ¿cuál de las siguientes vacunas estaría absolutamente contraindicada?

A) Vacuna Hexavalente.

B) Vacuna Neumocócica conjugada.

C) Vacuna contra Rotavirus. *

D) Vacuna contra Hepatitis B.

Retroalimentación Pregunta 2:

La vacuna contra el rotavirus es de virus vivos atenuados y se administra por vía oral. Su aplicación está estrictamente contraindicada en lactantes con antecedente de invaginación intestinal o con malformaciones congénitas no corregidas del tracto gastrointestinal (como el divertículo de Meckel), debido al riesgo incrementado de desencadenar un nuevo cuadro de intususcepción.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Artritis reumatoide (Reumatología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 45 años acude a consulta por presentar dolor, inflamación y rigidez matutina de más de 1 hora de duración en ambas manos, muñecas y rodillas. El cuadro tiene 3 meses de evolución. A la exploración física, se documenta sinovitis simétrica en articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales bilaterales, con dolor a la compresión lateral (signo de Morton positivo).

Pregunta 1

Para confirmar la sospecha diagnóstica, se solicitan estudios inmunológicos. ¿Cuál es el autoanticuerpo que posee la mayor especificidad diagnóstica y valor pronóstico para esta enfermedad?

A) Factor Reumatoide (FR).

B) Anticuerpos Antinucleares (ANA).

C) Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (Anti-CCP). *

D) Anticuerpos anti-DNA de doble cadena.

Retroalimentación Pregunta 1:

Aunque el Factor Reumatoide es muy sensible y clásico en la Artritis Reumatoide, los Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) tienen una especificidad mucho mayor (hasta del 95-98%). Además, suelen aparecer en fases tempranas de la enfermedad y se asocian a un pronóstico más severo y erosivo.

Pregunta 2

Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cuál es el Fármaco Modificador de la Enfermedad (FAME) sintético convencional de primera línea que debe iniciarse de inmediato para detener el daño estructural?

A) Prednisona a dosis altas.

B) Metotrexato. *

C) Ibuprofeno horario.

D) Infliximab.

Retroalimentación Pregunta 2:

El Metotrexato es la piedra angular y el FAME de primera elección en el tratamiento de la Artritis Reumatoide. Su inicio temprano (ventana de oportunidad) retrasa la progresión radiográfica y previene la discapacidad. Los AINEs y los glucocorticoides se utilizan únicamente como terapia "puente" para el control rápido de los síntomas inflamatorios, pero no modifican el curso de la enfermedad.

Especialidad: Cirugía

Tema: Apendicitis

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 24 años, cursando un embarazo de 20 semanas de gestación. Acude a urgencias por dolor abdominal de 12 horas de evolución que inició en epigastrio y posteriormente migró al flanco derecho y cuadrante inferior derecho. Presenta náuseas y un episodio de vómito. Sus signos vitales muestran taquicardia leve y temperatura de 37.8°C. Los laboratorios reportan leucocitosis de 14,000/mm^3 con neutrofilia.

Pregunta 1

Ante la sospecha de un cuadro apendicular en esta paciente embarazada, ¿cuál es el estudio de imagen inicial de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Tomografía Computarizada (TAC) de abdomen y pelvis.

B) Radiografía simple de abdomen.

C) Ultrasonido abdominal con compresión graduada. *

D) Gammagrama con leucocitos marcados.

Retroalimentación Pregunta 1:

En la paciente embarazada, el Ultrasonido abdominal es el estudio de imagen de primera línea para evaluar patología del cuadrante inferior derecho, debido a su seguridad al no emitir radiación ionizante (que puede ser teratogénica). Si el ultrasonido no es concluyente, el siguiente paso ideal es la Resonancia Magnética sin gadolinio.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes escalas clínicas y de laboratorio es la más utilizada internacionalmente para estratificar el riesgo y la probabilidad diagnóstica en cuadros de dolor en fosa iliaca derecha?

A) Escala de Alvarado. *

B) Criterios de Ranson.

C) Escala de Glasgow-Blatchford.

D) Criterios de Tokio.

Retroalimentación Pregunta 2:

La escala de Alvarado es una herramienta clínica muy validada para la sospecha de apendicitis aguda. Evalúa la migración del dolor, anorexia, náuseas/vómitos, dolor en cuadrante inferior derecho, signo de rebote, fiebre, leucocitosis y desviación a la

izquierda. Un puntaje de 7 o más indica una alta probabilidad de requerir intervención quirúrgica.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Cáncer de Mama

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 58 años de edad, asintomática, acude a su chequeo anual con los resultados de su mastografía de tamizaje. No tiene antecedentes familiares de neoplasias. El reporte radiológico describe la presencia de una masa densa, espiculada, de 2.5 cm en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, acompañada de microcalcificaciones pleomórficas agrupadas. La piel se observa engrosada.

Pregunta 1

De acuerdo con el sistema de reporte, ¿qué categoría BI-RADS le corresponde a este hallazgo y qué conducta clínica indica?

A) BI-RADS 3; Probablemente benigno, seguimiento en 6 meses.

B) BI-RADS 4; Sospecha de malignidad, requiere biopsia.

C) BI-RADS 5; Altamente sugestivo de malignidad, requiere biopsia obligatoria. *

D) BI-RADS 6; Malignidad comprobada, planear cirugía.

Retroalimentación Pregunta 1:

La categoría BI-RADS 5 se asigna cuando los hallazgos radiológicos (como una masa espiculada con microcalcificaciones pleomórficas y cambios cutáneos) tienen una

probabilidad de malignidad igual o superior al 95%. La conducta ineludible es realizar una biopsia con aguja de corte (tru-cut) para el diagnóstico histopatológico definitivo.

Pregunta 2

Al recibir el reporte de patología de la biopsia, se confirma una neoplasia maligna invasora. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama infiltrante a nivel mundial?

A) Carcinoma lobulillar infiltrante.

B) Carcinoma ductal infiltrante (o sin tipo especial). *

C) Carcinoma medular.

D) Enfermedad de Paget de la mama.

Retroalimentación Pregunta 2:

El carcinoma ductal infiltrante (actualmente denominado por la OMS como carcinoma invasor de tipo no especial) es la variedad histológica más común, representando aproximadamente entre el 70% y el 80% de todos los cánceres de mama invasivos. Su diseminación ocurre tempranamente hacia los ganglios linfáticos axilares.

Especialidad: Pediatría

Tema: Hernias diafragmáticas (Patología Neonatal)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido de término presenta dificultad respiratoria severa y cianosis desde el primer minuto de vida. A la exploración física destaca un abdomen excavado y se auscultan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo, con un evidente desplazamiento del latido cardiaco hacia el lado derecho del tórax.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y a través de qué defecto anatómico protruyen habitualmente las vísceras en este caso?

A) Hernia de Morgagni; defecto retroesternal anterior.

B) Eventración diafragmática; parálisis del nervio frénico.

C) Hernia de Bochdalek; defecto posterolateral izquierdo. *

D) Hernia hiatal congénita; defecto del hiato esofágico.

Retroalimentación Pregunta 1:

La hernia de Bochdalek es la hernia diafragmática congénita más frecuente (representando entre el 85% y 90% de los casos) y clásicamente se localiza en la región posterolateral izquierda. El abdomen excavado (por ausencia de vísceras en la cavidad abdominal) y la auscultación de ruidos intestinales en el tórax son signos clínicos patognomónicos.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial prioritario en la sala de partos para este neonato antes del tratamiento quirúrgico definitivo?

A) Ventilación con presión positiva mediante mascarilla facial.

B) Intubación endotraqueal inmediata y colocación de sonda orogástrica. *

C) Toracocentesis de urgencia en hemitórax izquierdo.

D) Cierre quirúrgico del defecto diafragmático en las primeras 2 horas de vida.

Retroalimentación Pregunta 2:

La intubación endotraqueal inmediata es vital para asegurar la ventilación y evitar la insuflación del tracto gastrointestinal. La ventilación con mascarilla facial está estrictamente contraindicada porque introduce aire al estómago y a los intestinos herniados, lo que comprime aún más los pulmones hipoplásicos y agrava la insuficiencia respiratoria. La sonda orogástrica ayuda a descomprimir las vísceras.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Sx nefríticos (Nefrología)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Niño de 8 años de edad es llevado a consulta por presentar orina de color "café oscuro" (coluria) y edema periorbitario de predominio matutino. La madre refiere que hace 2 semanas el niño presentó un cuadro de faringoamigdalitis purulenta que solo se trató con remedios caseros. A la exploración física, presenta una tensión arterial de 130/85 mmHg (hipertensión grado 2 para su edad y percentil de talla).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y qué hallazgo patognomónico se esperaría encontrar en el sedimento urinario?

A) Síndrome nefrótico; cilindros hialinos y proteinuria masiva.

B) Glomerulonefritis postestreptocócica; eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos. *

C) Nefropatía por IgA; piuria estéril y cilindros leucocitarios.

D) Infección de vías urinarias; bacteriuria y abundantes leucocitos.

Retroalimentación Pregunta 1:

La glomerulonefritis aguda postestreptocócica es el prototipo del síndrome nefrítico en la edad pediátrica, presentándose típicamente de 1 a 3 semanas después de una infección faríngea (o 3-6 semanas tras una infección cutánea). El síndrome nefrítico clásico se caracteriza por la tríada de hematuria de origen glomerular (eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos), hipertensión arterial y edema periorbitario.

Pregunta 2

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente que provoca el daño estructural en el glomérulo en esta entidad?

A) Depósito de inmunocomplejos circulantes (antígeno-anticuerpo) y activación del complemento. *

B) Producción de autoanticuerpos dirigidos específicamente contra la membrana basal glomerular.

C) Toxicidad tubular directa por exotoxinas bacterianas sistémicas.

D) Invasión bacteriana directa e infección del parénquima renal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La glomerulonefritis postestreptocócica es una enfermedad inmunológica mediada por inmunocomplejos (reacción de hipersensibilidad tipo III). Los complejos formados por antígenos del estreptococo y anticuerpos maternos se depositan en los glomérulos, lo que activa potentemente la vía alterna del complemento (reflejado en laboratorios como un consumo de C3 con un C4 normal) y desencadena una grave cascada inflamatoria local.

Especialidad: Cirugía

Tema: Hernias (Hernias/Esplenectomía)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 45 años, con índice de masa corporal de 35 y antecedente de 4 embarazos. Acude al servicio de urgencias por presentar dolor exquisito en la región inguinal derecha de inicio súbito tras cargar un objeto pesado. El cuadro se asocia a náuseas y dos episodios de vómito gastrointestinal. A la exploración física, se palpa una

tumoración pequeña, tensa, irreductible y muy dolorosa localizada por debajo de la línea de Malgaigne (ligamento inguinal), medial a los vasos femorales.

Pregunta 1

De acuerdo con las referencias anatómicas descritas, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta hernia?

A) Hernia inguinal indirecta.

B) Hernia inguinal directa.

C) Hernia femoral (crural). *

D) Hernia obturatriz.

Retroalimentación Pregunta 1:

Las hernias femorales (o crurales) protruyen a través del anillo femoral, anatómicamente situadas por debajo de la cinta iliopúbica y del ligamento inguinal (línea de Malgaigne). Epidemiológicamente, son mucho más frecuentes en mujeres (especialmente en multíparas) debido a la mayor amplitud de la pelvis femenina en comparación con la masculina.

Pregunta 2

¿Cuál es la principal característica clínica y complicación inherente a este tipo específico de hernia de la pared abdominal?

A) Suelen alcanzar tamaños gigantes y rara vez presentan compromiso isquémico.

B) Tienen el mayor índice de encarcelamiento y estrangulación debido a la rigidez de su anillo. *

C) Se asocian comúnmente a varicocele ipsilateral por compresión venosa.

D) Resuelven de manera espontánea con la disminución de peso y el reposo.

Retroalimentación Pregunta 2:

El anillo femoral es un espacio sumamente estrecho y delimitado por estructuras muy rígidas e inextensibles (ligamento lacunar, ligamento pectíneo o de Cooper, y la vaina de la vena femoral). Esto provoca que las hernias femorales tengan la tasa más alta de encarcelamiento e isquemia intestinal (estrangulación) de todas las hernias abdominales, convirtiéndolas en una indicación quirúrgica inmediata.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hiperemesis gravidica (Control Prenatal)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Primigesta de 10 semanas de gestación acude a urgencias por presentar vómitos incoercibles (más de 10 episodios al día) desde hace dos semanas, con imposibilidad absoluta para tolerar la vía oral. Refiere pérdida de peso de 4 kg (aproximadamente el 6% de su peso corporal previo al embarazo). A la exploración física, presenta signos evidentes de deshidratación (mucosas orales secas, hipotensión ortostática y taquicardia). Los exámenes de laboratorio urgentes reportan cetonuria (+++) e hipopotasemia severa.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico que define la severidad de este cuadro gastrointestinal?

A) Emesis fisiológica del embarazo.

B) Hiperemesis gravídica. *

C) Enfermedad trofoblástica gestacional.

D) Gastroenteritis infecciosa aguda.

Retroalimentación Pregunta 1:

La hiperemesis gravídica es el extremo más grave del espectro de las náuseas y vómitos del embarazo. Se diferencia de la emesis fisiológica por su severidad objetiva, la cual condiciona pérdida de peso mayor al 5% del peso pregestacional, deshidratación, alteraciones electrolíticas (típicamente hipopotasemia y alcalosis metabólica) y cetonuria franca secundaria al estado de inanición celular.

Pregunta 2

¿Qué complicación neurológica grave, secundaria a una deficiencia vitamínica crónica, se debe prevenir activamente en el manejo intrahospitalario de esta paciente antes de administrar soluciones parenterales glucosadas?

A) Encefalopatía de Wernicke; por deficiencia de Tiamina (Vitamina B1). *

B) Degeneración combinada subaguda; por deficiencia de Cianocobalamina (Vitamina B12).

C) Pelagra; por deficiencia de Niacina (Vitamina B3).

D) Ceguera nocturna; por deficiencia de Vitamina A.

Retroalimentación Pregunta 2:

En pacientes con desnutrición severa y cuadros prolongados de hiperemesis gravídica, existe un déficit importante de Tiamina (Vitamina B1). La administración de glucosa intravenosa sin realizar la reposición profiláctica de tiamina puede precipitar de forma aguda una encefalopatía de Wernicke (tríada de ataxia, confusión y oftalmoplejía), ya que el metabolismo de la carga de glucosa consume rápidamente las escasas reservas de tiamina del sistema nervioso central.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: HEMORRAGIA POSPARTO POR ATONÍA UTERINA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 29 años, multípara, cursando puerperio inmediato posterior a parto vaginal de producto macrosómico. Presenta sangrado transvaginal abundante, taquicardia y palidez. A la exploración se encuentra útero aumentado de tamaño y flácido a la palpación.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hemorragia posparto por atonía uterina *
B) Desgarro cervical aislado.
C) Inversión uterina.
D) Retención urinaria posparto.

Retroalimentación:
La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto. El útero flácido y mal contraído, junto con sangrado abundante en el puerperio inmediato, orienta de forma importante a este diagnóstico.

Pregunta 2
¿Cuál es la primera medida terapéutica específica?
A) Masaje uterino y uterotónicos *
B) Histerectomía inmediata en todos los casos.
C) Tocolíticos intravenosos.
D) Restricción de líquidos.

Retroalimentación:
El manejo inicial incluye masaje uterino bimanual y administración de uterotónicos, además de reanimación hemodinámica. La histerectomía se reserva para casos refractarios.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 26 años con 24 semanas de gestación consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional. Niega fiebre, dolor lumbar o contracciones uterinas. En el examen general de orina se reporta leucocituria y nitritos positivos.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Cistitis en el embarazo *
B) Pielonefritis aguda.
C) Vaginosis bacteriana.
D) Trabajo de parto pretérmino.

Retroalimentación:
La presencia de síntomas urinarios bajos sin fiebre ni dolor lumbar orienta a cistitis. En el embarazo es importante tratarla de forma oportuna para evitar progresión a pielonefritis.

Pregunta 2
¿Cuál es una complicación obstétrica asociada si no se trata adecuadamente?
A) Parto pretérmino *
B) Placenta acreta.
C) Embarazo molar.
D) Transposición de grandes vasos.

Retroalimentación:
Las infecciones urinarias durante el embarazo se asocian con mayor riesgo de complicaciones como parto pretérmino y bajo peso al nacer, sobre todo si progresan o se repiten.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 23 años consulta por dolor pélvico bilateral, fiebre y leucorrea purulenta. Refiere vida sexual activa sin uso consistente de preservativo. A la exploración presenta dolor a la movilización cervical y dolor anexial bilateral.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Enfermedad inflamatoria pélvica *
B) Endometriosis.
C) Quiste ovárico funcional.
D) Amenorrea hipotalámica.

Retroalimentación:
El dolor pélvico, la fiebre, la leucorrea y el dolor a la movilización cervical son hallazgos clásicos de enfermedad inflamatoria pélvica en una paciente con factores de riesgo sexual.

Pregunta 2
¿Cuál es una secuela importante a largo plazo?

A) Infertilidad por daño tubario *
B) Miocardiopatía dilatada.
C) Catarata bilateral.
D) Hipertiroidismo.

Retroalimentación:
La inflamación y cicatrización de las trompas de Falopio pueden ocasionar infertilidad y aumentar el riesgo de embarazo ectópico en el futuro.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: IMPÉTIGO
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Escolar de 6 años presenta lesiones peribucales eritematosas con costras color miel, pruriginosas, de varios días de evolución. No tiene fiebre ni datos de afección sistémica.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Impétigo no ampolloso *
B) Varicela.
C) Tiña corporal.
D) Dermatitis seborreica.

Retroalimentación:
Las costras melicéricas o color miel son muy características del impétigo no ampolloso, una infección superficial de la piel frecuente en niños.

Pregunta 2
¿Cuál es un agente etiológico frecuente en este cuadro?
A) Staphylococcus aureus *
B) Mycobacterium tuberculosis.
C) Candida albicans.
D) Virus de Epstein-Barr.

Retroalimentación:
Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes son causas frecuentes de impétigo. El contexto clínico y las lesiones ayudan al diagnóstico sin requerir, en la mayoría de casos, estudios complejos.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: TOS FERINA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Lactante de 4 meses presenta accesos de tos paroxística, enrojecimiento facial y vómito posterior a la tos. La madre refiere que en ocasiones parece “quedarse sin aire” al terminar los episodios. No cuenta con esquema de vacunación completo.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Tos ferina *
B) Bronquiolitis.
C) Crup viral.
D) Neumotórax espontáneo.

Retroalimentación:
La tos paroxística en accesos, el vómito postusígeno y las pausas respiratorias en lactantes son muy sugestivos de tos ferina, especialmente cuando el esquema de vacunación está incompleto.

Pregunta 2
¿Cuál es el agente causal?
A) Bordetella pertussis *
B) Corynebacterium diphtheriae.
C) Streptococcus pyogenes.
D) Moraxella catarrhalis.

Retroalimentación:
Bordetella pertussis es el agente etiológico de la tos ferina. La prevención mediante vacunación es fundamental, sobre todo en lactantes.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: ESTATUS EPILÉPTICO
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Niño de 5 años llega a urgencias convulsionando desde hace 8 minutos, sin

recuperación del estado de alerta entre episodios. Los familiares niegan antecedente traumático reciente y refieren fiebre baja desde la mañana.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico sindromático?
A) Estatus epiléptico *
B) Síncope vasovagal.
C) Migraña basilar.
D) Crisis de ausencia simple.

Retroalimentación:
La actividad convulsiva prolongada o la repetición de convulsiones sin recuperación del estado basal constituye un estatus epiléptico y requiere tratamiento inmediato.

Pregunta 2
¿Cuál es el fármaco inicial de elección en urgencias?
A) Benzodiacepina *
B) Hierro oral.
C) Furosemida.
D) Ibuprofeno como único tratamiento.

Retroalimentación:
Las benzodiacepinas son la primera línea para abortar una crisis convulsiva prolongada. El objetivo es detener rápidamente la actividad eléctrica anormal para disminuir complicaciones neurológicas.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: PERITONITIS SECUNDARIA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Masculino de 47 años con antecedente de apendicitis no tratada acude con dolor abdominal generalizado, fiebre alta, vómito y postración. A la exploración presenta abdomen rígido, defensa involuntaria difusa y rebote positivo.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Peritonitis secundaria *
B) Síndrome de intestino irritable.

C) Gastritis aguda.
D) Hemorroide externa trombosada.

Retroalimentación:
La presencia de abdomen agudo con irritación peritoneal difusa, fiebre y deterioro clínico es compatible con peritonitis secundaria, generalmente por perforación o extensión de un foco intraabdominal.

Pregunta 2
¿Cuál es la conducta general más adecuada?
A) Reanimación, antibióticos y valoración quirúrgica urgente *
B) Dieta blanda y seguimiento ambulatorio.
C) Únicamente antiácidos.
D) Manejo exclusivo con laxantes.

Retroalimentación:
La peritonitis secundaria requiere manejo agresivo con estabilización hemodinámica, antibióticos de amplio espectro y, en muchos casos, control quirúrgico de la fuente.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: ENFERMEDAD HEMORROIDAL INTERNA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Paciente de 44 años refiere sangrado rojo rutilante al evacuar, que observa en el papel higiénico y ocasionalmente en la taza. Niega dolor intenso. Refiere estreñimiento crónico y pujo frecuente.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hemorroides internas *
B) Fisura anal aguda.
C) Absceso perianal.
D) Isquemia mesentérica.

Retroalimentación:
El sangrado rojo brillante no doloroso relacionado con la evacuación es típico de enfermedad hemorroidal interna. El antecedente de estreñimiento y pujo refuerza esta posibilidad.

Pregunta 2
¿Cuál es una medida inicial útil en casos no complicados?
A) Aumento de fibra y medidas higiénico-dietéticas *
B) Cirugía de urgencia en todos los casos.
C) Anticoagulación plena.
D) Supresión total de líquidos.

Retroalimentación:
El tratamiento inicial suele incluir fibra, hidratación, evitar pujo y mejorar hábitos evacuatorios. Muchas formas leves responden a estas medidas conservadoras.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: SÍNDROME NEFRÍTICO AGUDO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 17 años acude por edema facial matutino, oliguria y orina color "coca-cola" una semana después de una faringitis. A la exploración presenta hipertensión arterial leve.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?
A) Síndrome nefrítico agudo *
B) Síndrome nefrótico puro.
C) Insuficiencia venosa periférica.
D) Cistitis no complicada.

Retroalimentación:
La combinación de hematuria macroscópica, edema, oliguria e hipertensión tras una infección faríngea sugiere síndrome nefrítico agudo, frecuentemente de origen postinfeccioso.

Pregunta 2
¿Cuál es un hallazgo típico que ayuda a diferenciarlo de síndrome nefrótico?
A) Hematuria con hipertensión *
B) Proteinuria masiva aislada.
C) Hiperlipidemia marcada como dato principal.
D) Ascitis como manifestación inicial universal.

Retroalimentación:
En el síndrome nefrítico predominan hematuria, hipertensión y disminución de la filtración glomerular. En el síndrome nefrótico destacan proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edema.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Hombre de 38 años refiere ardor epigástrico recurrente, relacionado con ayuno prolongado, que mejora temporalmente al ingerir alimentos. Niega pérdida de peso y hematemesis.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Úlcera duodenal *
B) Colecistitis aguda.
C) Pancreatitis aguda.
D) Diverticulitis.

Retroalimentación:
El dolor epigástrico tipo ardor que mejora con alimentos y reaparece horas después es un patrón clásico de úlcera duodenal.

Pregunta 2
¿Cuál es un agente etiológico frecuentemente asociado?
A) Helicobacter pylori *
B) Virus sincitial respiratorio.
C) Entamoeba histolytica.
D) Plasmodium falciparum.

Retroalimentación:
Helicobacter pylori es una de las causas más importantes de enfermedad ácido péptica, especialmente úlcera duodenal, junto con el uso de AINE.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: GOTA AGUDA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Masculino de 51 años presenta dolor súbito e intenso en la primera articulación metatarsofalángica del pie derecho, con eritema, calor y limitación funcional. Refiere ingesta abundante de alcohol el día previo.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Artritis gotosa aguda *
B) Osteoartritis.
C) Artritis reumatoide.
D) Esguince de tobillo.

Retroalimentación:
La monoartritis aguda muy dolorosa del primer dedo del pie, de inicio súbito y con inflamación intensa, es típica de gota aguda.

Pregunta 2
¿Cuál es la articulación clásicamente afectada en este cuadro?
A) Primera metatarsofalángica *
B) Temporomandibular.
C) Esternoclavicular.
D) Sacroilíaca.

Retroalimentación:
La podagra, que afecta la primera articulación metatarsofalángica, es la forma clásica de presentación de la artritis gotosa aguda.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Anemia megaloblástica (Anemias Introducción y Anemias Carenciales)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 65 años de edad acude a consulta por presentar astenia progresiva, palidez y sensación de hormigueo (parestesias) en ambas piernas desde hace 4 meses. Refiere también que su lengua le arde al comer alimentos condimentados. A la exploración física destaca palidez con un tinte levemente ictérico, glositis atrófica (lengua lisa y roja) y disminución de la sensibilidad vibratoria en miembros inferiores.

En la biometría hemática se reporta Hemoglobina de 8.2 g/dL y un Volumen Corpuscular Medio (VCM) de 115 fL.

Pregunta 1

De acuerdo con el cuadro clínico y el hallazgo de macrocitosis, ¿cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la causa patogénica clásica si se sospecha de Anemia Perniciosa?

A) Anemia por deficiencia de folatos; destrucción autoinmune de la mucosa duodenal.

B) Anemia megaloblástica; presencia de autoanticuerpos contra el factor intrínseco o las células parietales gástricas. *

C) Anemia hemolítica autoinmune; anticuerpos calientes IgG contra la membrana del eritrocito.

D) Síndrome mielodisplásico; mutación clonal de las células madre hematopoyéticas.

Retroalimentación Pregunta 1:

La anemia perniciosa es la causa más frecuente de deficiencia severa de Vitamina B12 (cobalamina). Es una enfermedad autoinmune donde se producen anticuerpos que destruyen las células parietales del estómago o bloquean directamente al factor intrínseco, impidiendo la absorción de la vitamina B12 en el íleon terminal, lo que detiene la síntesis de ADN y genera eritrocitos gigantes (macrocitosis).

Pregunta 2

¿Cuál es la manifestación clínica clave presente en este caso que permite diferenciar clínicamente la deficiencia de Vitamina B12 de la deficiencia de Ácido Fólico (B9) antes de tener los niveles séricos?

A) La presencia de glositis atrófica.

B) El hallazgo de un VCM mayor a 110 fL.

C) La presencia de síntomas neurológicos (parestesias y alteración de la sensibilidad vibratoria). *

D) El desarrollo de pancitopenia en el frotis de sangre periférica.

Retroalimentación Pregunta 2:

Tanto la deficiencia de B12 como la de folatos producen anemia megaloblástica idéntica en la biometría (macrocitosis, neutrófilos hipersegmentados). Sin embargo, la Vitamina B12 es indispensable para la síntesis de mielina. Su deficiencia provoca degeneración combinada subaguda de la médula espinal (cordones posteriores y laterales), lo que se traduce en síntomas neurológicos que no se presentan en la deficiencia de ácido fólico.

Especialidad: Pediatría

Tema: EMH (Patología Respiratoria del Pediátrico)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Recién nacido prematuro de 28 semanas de gestación, obtenido por cesárea de urgencia debido a preeclampsia materna severa. La madre no recibió esquema de maduración pulmonar. A los pocos minutos de nacer, el neonato presenta dificultad respiratoria grave caracterizada por aleteo nasal, quejido espiratorio audible, tiraje intercostal y cianosis central. La radiografía de tórax inicial muestra un patrón reticulonodular difuso bilateral con imagen en "vidrio esmerilado" y broncograma aéreo evidente. El volumen pulmonar está disminuido.

Pregunta 1

¿Cuál es la fisiopatología principal que origina la Enfermedad de Membrana Hialina (Síndrome de Dificultad Respiratoria tipo 1) en este paciente?

A) Obstrucción de la vía aérea pequeña por aspiración de meconio intraútero.

B) Deficiencia cuantitativa y cualitativa de factor surfactante producido por los neumocitos tipo II. *

C) Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal por falta de trabajo de parto.

D) Hipoplasia pulmonar secundaria a la compresión torácica por oligohidramnios.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) afecta casi exclusivamente a los recién nacidos prematuros. La inmadurez pulmonar se traduce en una producción insuficiente de factor surfactante, cuya función es reducir la tensión superficial en los alvéolos. Sin surfactante, los alvéolos colapsan al final de la espiración (atelectasia progresiva), reduciendo drásticamente el intercambio gaseoso y la distensibilidad pulmonar.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento profiláctico de elección, con mayor impacto en la reducción de la morbimortalidad, que debió administrarse a la madre ante la inminencia del parto pretérmino?

A) Antibióticos profilácticos intravenosos (Ampicilina).

B) Tocolíticos agresivos (Indometacina) por al menos 7 días.

C) Corticosteroides prenatales (Dexametasona o Betametasona) administrados entre las 24 y 34 semanas de gestación. *

D) Sulfato de magnesio exclusivamente para neuroprotección fetal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La medida preventiva más eficaz y con mayor evidencia para disminuir la incidencia y severidad de la EMH (así como de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante) es la administración de un esquema completo de corticosteroides prenatales a la madre con riesgo inminente de parto prematuro, ya que aceleran la maduración de los neumocitos tipo II y la síntesis de surfactante.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Cándida (Patología Infecciosa Cervical)

Dificultad: Baja

Caso Clínico

Mujer de 25 años acude a la consulta externa por presentar prurito vulvovaginal intenso, ardor y dispareunia de 5 días de evolución. Refiere haber completado recientemente un esquema de antibióticos de amplio espectro por una infección de vías urinarias. A la exploración con espéculo se observa eritema y edema vulvar, acompañado de un flujo vaginal blanquecino, espeso, grumoso y adherente, con aspecto de "requesón" o "leche cortada".

Pregunta 1

De acuerdo con las características clínicas, ¿cuál es el diagnóstico más probable y cómo se espera encontrar el pH vaginal de esta paciente?

A) Vaginosis bacteriana; pH > 4.5.

B) Tricomoniasis; pH > 5.0.

C) Candidiasis vulvovaginal; pH normal (< 4.5). *

D) Infección por Chlamydia; pH alcalino.

Retroalimentación Pregunta 1:

La candidiasis vulvovaginal se caracteriza clásicamente por un prurito intenso, eritema vulvar y un flujo blanco y grumoso ("en requesón"). Un dato clínico y de laboratorio fundamental para diferenciarla de otras infecciones vaginales (como la vaginosis bacteriana o la tricomoniasis) es que en la infección por hongos el pH vaginal se mantiene dentro de los límites normales (ácido, entre 4.0 y 4.5).

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico en el consultorio, se toma una muestra del flujo. ¿Qué sustancia se añade al frotis y qué estructura patognomónica se observaría al microscopio?

A) Solución salina; visualización de "células clave" (clue cells).

B) Hidróxido de potasio (KOH) al 10%; visualización de hifas, pseudohifas y esporas. *

C) Tinción de Gram; diplococos gramnegativos intracelulares.

D) Ácido acético; blanqueamiento del epitelio afectado.

Retroalimentación Pregunta 2:

La preparación en fresco con KOH al 10% (hidróxido de potasio) destruye las células epiteliales y los detritos celulares del flujo, facilitando la visualización microscópica directa de las estructuras fúngicas típicas de la *Candida albicans*, que son las levaduras en gemación y las pseudohifas.

Especialidad: Cirugía

Tema: Abdomen agudo (Introducción a Cirugía y Cirugía Abdominal)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 42 años ingresa a la sala de choque en el servicio de urgencias por dolor abdominal generalizado, intenso y de inicio brusco. A la exploración física, el paciente se encuentra postrado, evitando cualquier movimiento. Sus signos vitales muestran TA 90/50 mmHg, FC 125 lpm y temperatura de 39.0°C. El abdomen se palpa rígido (en "tabla"), con dolor intenso a la compresión superficial y profunda, y un signo de

rebote claramente positivo en los cuatro cuadrantes. No se auscultan ruidos peristálticos.

Pregunta 1

El signo de dolor exacerbado al soltar rápidamente la presión ejercida sobre el abdomen (Signo de rebote) tiene un epónimo clásico. ¿Cuál es su nombre y qué indica patofisiológicamente?

A) Signo de Murphy; indica inflamación vesicular focal.

B) Signo de Von Blumberg; indica irritación peritoneal severa. *

C) Signo de Rovsing; indica migración del dolor apendicular.

D) Signo de Courvoisier; indica obstrucción biliar maligna.

Retroalimentación Pregunta 1:

El dolor al rebote (descompresión brusca) es el signo cardinal de la peritonitis parietal. Su nombre clásico es el Signo de Von Blumberg. Ocurre porque la liberación rápida de la presión sobre la pared abdominal estira bruscamente el peritoneo parietal que se encuentra sumamente inflamado e hipersensibilizado por pus, sangre o contenido gastrointestinal libre en la cavidad.

Pregunta 2

Ante los datos francos de peritonitis generalizada y choque distributivo (séptico), ¿cuál es el paso definitivo en el abordaje terapéutico inmediato tras iniciar la reanimación hídrica con cristaloides y antibióticos de amplio espectro?

A) Realizar una tomografía contrastada y esperar evolución en piso.

B) Colocación de drenaje percutáneo guiado por ecografía.

C) Laparotomía exploradora de urgencia. *

D) Observación clínica con evaluaciones seriadas cada 4 horas.

Retroalimentación Pregunta 2:

Un paciente con datos clínicos innegables de peritonitis generalizada (abdomen en madera, rebote positivo) que además cursa con inestabilidad hemodinámica (choque séptico) tiene indicación de laparotomía exploradora de urgencia (cirugía de control de daños). En estos escenarios críticos, retrasar la entrada a quirófano para realizar estudios de imagen avanzados (como TAC) solo aumenta drásticamente la mortalidad.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Fibrilación auricular (Arritmias)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 68 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica de 15 años de evolución. Acude a consulta refiriendo palpitaciones rápidas, disnea de medianos esfuerzos y fatiga desde hace 48 horas. A la exploración física, la tensión arterial es de 135/85 mmHg y el pulso se palpa marcadamente arrítmico, con una frecuencia cardiaca apical de 125 lpm y un pulso radial de 110 lpm (déficit de pulso).

Pregunta 1

Se solicita un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo. ¿Cuáles son los hallazgos electrocardiográficos clásicos que confirmarían el diagnóstico de la arritmia más probable en este paciente?

A) Ausencia de ondas P, presencia de ondas "f" minúsculas e intervalos R-R irregularmente irregulares. *

B) Presencia de ondas "F" mayúsculas en "dientes de sierra" con intervalos R-R regulares.

C) Intervalos PR prolongados (>0.20 s) constantes, con todas las ondas P conduciendo un complejo QRS.

D) Complejos QRS anchos (>0.12 s) prematuros, sin onda P precedente, seguidos de una pausa compensadora.

Retroalimentación Pregunta 1:

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca sostenida más común. Fisiopatológicamente, las aurículas presentan una activación eléctrica caótica y desorganizada, lo que se traduce en el electrocardiograma como la pérdida de la onda P (pérdida de la contracción auricular o "patada auricular"). Los intervalos R-R son característicamente irregulares debido a la conducción variable a través del nodo auriculoventricular.

Pregunta 2

Una vez controlada la frecuencia cardiaca, ¿qué escala clínica debe utilizarse obligatoriamente para calcular el riesgo tromboembólico del paciente y decidir la necesidad de iniciar anticoagulación oral a largo plazo?

A) Escala de HAS-BLED.

B) Criterios de Framingham.

C) Escala CHA2DS2-VASc. *

D) Escala TIMI para riesgo cardiovascular.

Retroalimentación Pregunta 2:

La complicación más temida de la fibrilación auricular es el evento vascular cerebral (EVC) isquémico por cardioembolismo (formación de trombos en la orejuela izquierda). La escala CHA2DS2-VASc evalúa factores como falla cardiaca, hipertensión, edad, diabetes, EVC previo y enfermedad vascular. Un puntaje $\ge$ 2 en hombres (o $\ge$ 3 en mujeres) es una indicación clase I para iniciar anticoagulación oral plena.

Especialidad: Cirugía

Tema: Fx de clavícula (Patología de Extremidad Superior)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 22 años es llevado a urgencias tras sufrir una caída desde su propia altura mientras andaba en bicicleta, golpeándose directamente sobre el hombro derecho. A la exploración física, el paciente sostiene su extremidad superior derecha con la mano contralateral para aliviar el dolor. Se observa aumento de volumen, equimosis y una deformidad evidente con un resalte óseo palpable en la región anterior del hombro derecho. Los pulsos distales y la sensibilidad de la mano están intactos.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología y la anatomía de este hueso, ¿en qué porción anatómica se localiza el trazo de fractura con mayor frecuencia?

A) Tercio distal (lateral).

B) Tercio proximal (medial).

C) A nivel de la articulación acromioclavicular.

D) Tercio medio (diafisario). *

Retroalimentación Pregunta 1:

La clavícula es uno de los huesos que más frecuentemente se fractura en el cuerpo humano. Aproximadamente el 80% de estas fracturas ocurren en su tercio medio. Esto se debe a que es la zona más delgada, carece de soporte muscular o ligamentario denso (a diferencia de los tercios distales y proximales) y es el punto donde el hueso cambia su curvatura, concentrando las fuerzas del impacto.

Pregunta 2

Si la radiografía anteroposterior confirma una fractura transversal simple, no desplazada y sin compromiso de la piel ni estructuras neurovasculares, ¿cuál es el tratamiento conservador inicial de elección?

A) Reducción cerrada bajo sedación y colocación de yeso toracobraquial.

B) Inmovilización con cabestrillo o vendaje en forma de "8" (guarismo) por 4 a 6 semanas. *

C) Fijación interna inmediata con placa y tornillos.

D) Aplicación de tracción cutánea continua.

Retroalimentación Pregunta 2:

La gran mayoría de las fracturas de clavícula del tercio medio sin desplazamiento significativo se tratan de forma conservadora. El uso de un cabestrillo simple o un vendaje en 8 proporciona soporte, inmoviliza la zona, alivia el dolor y permite una adecuada consolidación ósea, la cual típicamente toma entre 4 y 6 semanas en adultos jóvenes.

Especialidad: Pediatría

Tema: Escabiosis (Dermatología Pediátrica)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Niño de 5 años es traído a la consulta externa por presentar prurito generalizado muy intenso que empeora significativamente por las noches, impidiéndole dormir. La madre refiere que otros miembros de la familia (incluyendo a ella y a un hermano mayor) han comenzado con síntomas similares en los últimos días. A la exploración física, se observan pápulas eritematosas, costras hemáticas y escoriaciones lineales en los espacios interdigitales de las manos, en las caras flexoras de las muñecas y alrededor del ombligo.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico responsable de este cuadro clínico altamente contagioso?

A) Pediculus humanus capitis.

B) Malassezia furfur.

C) Sarcoptes scabiei var. hominis. *

D) Trichophyton rubrum.

Retroalimentación Pregunta 1:

La escabiosis (sarna) es causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei*. La hembra fertilizada excava túneles en el estrato córneo de la epidermis para depositar sus huevos y heces. La presencia del ácaro y sus productos de desecho desencadena una reacción de hipersensibilidad retardada severa, lo que explica el intenso prurito nocturno. La afectación de otros miembros de la familia es un dato clínico casi confirmatorio.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea recomendado tanto para el paciente pediátrico como para el resto de sus contactos cercanos sintomáticos y asintomáticos?

A) Crema de Ketoconazol al 2%.

B) Loción de Permetrina al 5% aplicada en todo el cuerpo. *

C) Ungüento de Mupirocina al 2% en las lesiones activas.

D) Hidrocortisona al 1% tópica durante 14 días.

Retroalimentación Pregunta 2:

La Permetrina al 5% en crema o loción es el escabicida tópico de elección por su alta eficacia y bajo perfil de toxicidad. Se debe aplicar desde el cuello hasta la punta de los pies (en lactantes también se incluye el cuero cabelludo) y dejarse actuar entre 8 y 14 horas antes de bañarse. Es crucial tratar a todos los convivientes simultáneamente y lavar la ropa y sábanas con agua caliente para erradicar la infestación y evitar recurrencias.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Cáncer Cervicouterino (Oncología Ginecológica)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 45 años, con inicio de vida sexual activa a los 16 años y antecedente de tabaquismo, acude a consulta por presentar sangrado transvaginal intermitente, predominantemente poscoital (sinusorragia), acompañado de un flujo vaginal fétido y sanguinolento de 6 meses de evolución. Refiere que no se ha realizado un Papanicolaou en más de 10 años. A la exploración con espéculo, el cérvix se encuentra reemplazado por una masa exofítica, friable y sangrante al roce.

Pregunta 1

Dado el factor de riesgo infeccioso indispensable para el desarrollo de esta neoplasia, ¿cuáles son los serotipos virales oncogénicos de alto riesgo más frecuentemente involucrados y cuál es el tipo histológico más común?

A) VPH 6 y 11; Adenocarcinoma.

B) VPH 16 y 18; Carcinoma epidermoide (células escamosas). *

C) Virus del Herpes Simple tipo 2; Carcinoma de células claras.

D) VPH 31 y 33; Sarcoma cervical.

Retroalimentación Pregunta 1:

La infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo es el factor etiológico principal y necesario para el cáncer cervicouterino. Los serotipos 16 y 18 son responsables de aproximadamente el 70% de los casos mundiales. El carcinoma epidermoide (o de células escamosas) representa entre el 70% y el 80% de las neoplasias cervicales, originándose típicamente en la zona de transformación del cérvix.

Pregunta 2

Si la biopsia confirma un carcinoma invasor que se limita estrictamente al cérvix, con un diámetro tumoral visible de 3 cm (Estadio IB según FIGO), ¿cuál es el tratamiento quirúrgico primario estándar con intención curativa?

A) Conización cervical con asa diatérmica (LEEP).

B) Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral. *

C) Quimioterapia sistémica paliativa exclusiva.

D) Crioterapia de la zona de transformación.

Retroalimentación Pregunta 2:

En estadios tempranos donde el tumor es invasivo, visible clínicamente pero está confinado al cérvix (Estadio IB), el tratamiento estándar de oro es la cirugía radical. La histerectomía radical (tipo Piver III) implica la extirpación del útero, el cérvix, los parametrios y el tercio superior de la vagina, acompañada siempre de una evaluación de los ganglios linfáticos pélvicos (linfadenectomía) para asegurar el control locorregional de la enfermedad.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: DISTOCIA DE HOMBROS
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 32 años, G3P2, con trabajo de parto a término. Tras la expulsión de la cabeza fetal, esta retrae contra el periné y no se logra completar el nacimiento con la siguiente contracción. El producto es macrosómico.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Distocia de hombros *
B) Presentación de cara.
C) Procidencia de cordón.
D) Placenta previa.

Retroalimentación:
La salida de la cabeza fetal seguida de imposibilidad para completar el parto, con

retracción de la cabeza contra el periné, es característica de distocia de hombros. La macrosomía es un factor de riesgo importante.

Pregunta 2
¿Cuál es la primera maniobra recomendada habitualmente?
A) Maniobra de McRoberts *
B) Versión cefálica externa.
C) Maniobra de Kristeller rutinaria.
D) Tacto vaginal repetido sin maniobras.

Retroalimentación:
La maniobra de McRoberts, que consiste en hiperflexión de los muslos sobre el abdomen materno, es una de las primeras intervenciones recomendadas porque puede aumentar el diámetro pélvico funcional.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: ABORTO INCOMPLETO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 27 años con amenorrea de 10 semanas acude por dolor tipo cólico y sangrado transvaginal abundante. Refiere expulsión parcial de tejido. A la exploración el cérvix se encuentra abierto.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Aborto incompleto *
B) Amenaza de aborto.
C) Embarazo ectópico roto.
D) Mola hidatidiforme.

Retroalimentación:
El aborto incompleto se sospecha cuando existe sangrado, dolor, dilatación cervical y expulsión parcial de productos de la concepción, permaneciendo tejido aún dentro del útero.

Pregunta 2
¿Cuál es un hallazgo que apoya este diagnóstico?
A) Cérvix dilatado con expulsión parcial de tejido *
B) Cérvix cerrado sin sangrado.

C) Masa anexial con inestabilidad hemodinámica.
D) Útero mayor al esperado con imagen en tormenta de nieve.

Retroalimentación:
La dilatación cervical y la salida parcial de tejido orientan a aborto incompleto. En la amenaza de aborto, por ejemplo, el cuello permanece cerrado.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 22 años consulta por menstruaciones irregulares desde la adolescencia, acné e incremento de vello en mentón y abdomen. Tiene sobrepeso. Refiere dificultad para embarazarse desde hace un año.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Síndrome de ovario poliquístico *
B) Insuficiencia ovárica primaria.
C) Síndrome de Turner.
D) Endometritis crónica.

Retroalimentación:
La combinación de oligoamenorrea, hiperandrogenismo clínico y sobrepeso es muy sugestiva de síndrome de ovario poliquístico, una causa frecuente de infertilidad anovulatoria.

Pregunta 2
¿Cuál es una alteración metabólica frecuentemente asociada?
A) Resistencia a la insulina *
B) Hipocalcemia severa.
C) Déficit de vitamina B12.
D) Hiperuricemia aislada obligatoria.

Retroalimentación:
El síndrome de ovario poliquístico se asocia con frecuencia a resistencia a la insulina, mayor riesgo cardiometabólico y alteraciones del metabolismo de la glucosa.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: ESCARLATINA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Escolar de 7 años presenta fiebre, odinofagia y exantema eritematoso difuso áspero al tacto, de predominio en tronco. A la exploración tiene lengua en fresa y eritema faríngeo.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Escarlatina *
B) Rubéola.
C) Exantema súbito.
D) Eritema infeccioso.

Retroalimentación:
La fiebre, faringitis y exantema áspero tipo “lija”, junto con lengua en fresa, son hallazgos clásicos de escarlatina.

Pregunta 2
¿Cuál es el agente etiológico causal?
A) Streptococcus pyogenes *
B) Staphylococcus epidermidis.
C) Virus coxsackie.
D) Bordetella pertussis.

Retroalimentación:
La escarlatina es causada por cepas de Streptococcus pyogenes productoras de exotoxinas eritrogénicas.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: ERITEMA INFECCIOSO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niña de 6 años presenta exantema en ambas mejillas con aspecto de “bofetada”, seguido por erupción reticulada en tronco y extremidades. Se encuentra en buen estado general.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Eritema infeccioso *
B) Sarampión.
C) Varicela.
D) Meningococcemia.

Retroalimentación:
El aspecto de “mejillas abofeteadas” seguido de exantema reticular es altamente sugestivo de eritema infeccioso.

Pregunta 2
¿Cuál es el agente etiológico más frecuente?
A) Parvovirus B19 *
B) Adenovirus.
C) Virus Epstein-Barr.
D) Rotavirus.

Retroalimentación:
El eritema infeccioso o quinta enfermedad se asocia clásicamente a infección por parvovirus B19.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: DIABETES MELLITUS TIPO 1 DEBUT
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Niño de 10 años es llevado por pérdida de peso, poliuria, polidipsia y fatiga de varias semanas de evolución. En los últimos dos días presenta náusea y dolor abdominal. La glucosa capilar es de 320 mg/dL.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Diabetes mellitus tipo 1 *
B) Diabetes insípida nefrogénica.
C) Hipotiroidismo congénito.
D) Síndrome nefrótico.

Retroalimentación:
La poliuria, polidipsia, pérdida de peso e hiperglucemia en un niño orientan fuertemente a debut de diabetes mellitus tipo 1.

Pregunta 2
¿Cuál es un dato de alarma que obliga a descartar cetoacidosis diabética?
A) Dolor abdominal y náusea *
B) Aumento del apetito aislado.
C) Rinorrea hialina.
D) Prurito nasal.

Retroalimentación:
Síntomas como náusea, vómito, dolor abdominal, respiración profunda o alteración del estado mental pueden indicar progresión a cetoacidosis diabética.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: FISURA ANAL AGUDA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Paciente de 31 años refiere dolor anal intenso durante y después de la evacuación, acompañado de escaso sangrado rojo brillante en el papel higiénico. Tiene antecedente de estreñimiento importante.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Fisura anal aguda *
B) Hemorroide interna no complicada.
C) Fístula perianal.
D) Prolapso rectal completo.

Retroalimentación:
El dolor intenso al evacuar con pequeño sangrado rojo brillante y antecedente de estreñimiento es típico de fisura anal aguda.

Pregunta 2
¿Cuál es la localización más frecuente?
A) Línea media posterior *
B) Cara lateral derecha del conducto anal.

C) Fondo de saco rectouterino.
D) Colon sigmoides.

Retroalimentación:
La mayoría de las fisuras anales agudas se localizan en la línea media posterior del conducto anal.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: ABSCESO PERIANAL
Dificultad: Media

Caso Clínico
Hombre de 40 años acude por dolor anal progresivo, fiebre y dificultad para sentarse. A la exploración se observa eritema, aumento de volumen y dolor exquisito en región perianal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Absceso perianal *
B) Hemorroide externa trombosada.
C) Fisura anal crónica.
D) Diverticulitis.

Retroalimentación:
El dolor anal intenso con fiebre, eritema y aumento de volumen perianal es compatible con absceso perianal, una infección que suele requerir drenaje.

Pregunta 2
¿Cuál es el tratamiento principal?
A) Drenaje quirúrgico *
B) Solo pomadas locales.
C) Dieta líquida exclusivamente.
D) Antihistamínicos.

Retroalimentación:
El manejo definitivo del absceso perianal es el drenaje, ya que los antibióticos por sí solos no suelen resolver el problema.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Varón de 58 años con antecedente de ingesta crónica de AINE presenta melena, debilidad y un episodio de hematemesis. A la exploración se encuentra taquicárdico y con palidez tegumentaria.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?
A) Hemorragia digestiva alta *
B) Hemorragia digestiva baja.
C) Pancreatitis aguda.
D) Colitis ulcerativa.

Retroalimentación:
La hematemesis y la melena orientan a sangrado digestivo proximal al ángulo de Treitz, es decir, hemorragia digestiva alta.

Pregunta 2
¿Cuál es una causa frecuente en este contexto?
A) Úlcera péptica *
B) Apendicitis.
C) Hemorroides externas.
D) Fístula anal.

Retroalimentación:
El antecedente de AINE aumenta el riesgo de úlcera péptica, una de las causas más comunes de hemorragia digestiva alta.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: EMBOLIA PULMONAR
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 46 años, con antecedente de inmovilización prolongada, presenta disnea súbita, dolor torácico pleurítico y taquicardia. La saturación de oxígeno está disminuida al aire ambiente.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Tromboembolia pulmonar *
B) Crisis asmática leve.
C) Reflujo gastroesofágico.
D) Pericarditis constrictiva.

Retroalimentación:
La disnea súbita, el dolor pleurítico, la taquicardia y el antecedente de inmovilización son hallazgos que obligan a sospechar tromboembolia pulmonar.

Pregunta 2
¿Cuál es el origen más frecuente del trombo responsable?
A) Sistema venoso profundo de miembros inferiores *
B) Aurícula izquierda.
C) Arteria radial.
D) Vena porta.

Retroalimentación:
La mayoría de los émbolos pulmonares se originan en trombos de las venas profundas de los miembros inferiores.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 63 años con diabetes mellitus e hipertensión de larga evolución consulta por fatiga, prurito y edema leve. En laboratorios presenta creatinina elevada persistente desde hace varios meses.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Enfermedad renal crónica *
B) Lesión renal aguda prerrenal.
C) Cistitis recurrente.
D) Nefrolitiasis aislada.

Retroalimentación:
La elevación persistente de creatinina durante meses, en un paciente con diabetes e hipertensión, orienta a enfermedad renal crónica.

Pregunta 2
¿Cuáles son dos causas frecuentes de este padecimiento?
A) Diabetes mellitus e hipertensión arterial *
B) Rinitis alérgica y asma.
C) Varicela y rubéola.
D) Gastritis y úlcera duodenal.

Retroalimentación:
La diabetes y la hipertensión son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en adultos y su control adecuado puede retrasar la progresión.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ARTRITIS REUMATOIDE
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 49 años presenta dolor y rigidez matutina en ambas manos, de más de una hora de duración, con afección simétrica de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Artritis reumatoide *
B) Gota aguda.
C) Osteoartritis localizada.
D) Lupus cutáneo aislado.

Retroalimentación:
La afección simétrica de pequeñas articulaciones y la rigidez matutina prolongada son muy características de artritis reumatoide.

Pregunta 2
¿Cuál es un patrón articular típico de esta enfermedad?
A) Poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones *
B) Monoartritis del primer dedo del pie.

C) Compromiso exclusivo de columna lumbar.
D) Dolor migratorio sin inflamación.

Retroalimentación:
La artritis reumatoide suele presentarse como poliartritis inflamatoria simétrica, con predominio en manos y muñecas.

Especialidad: Pediatría

Tema: Crisis febriles (Neurología Pediátrica)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante masculino de 18 meses de edad es traído a urgencias por presentar un episodio de movimientos tónico-clónicos generalizados que duró aproximadamente 3 minutos, acompañado de pérdida del estado de alerta y relajación de esfínteres. La madre refiere que el niño estaba "muy caliente". A su llegada, el paciente se encuentra somnoliento pero reactivo (estado postictal leve), con temperatura de 39.2°C y una membrana timpánica derecha hiperémica y abombada. Es su primer episodio y tiene un desarrollo neurológico completamente normal.

Pregunta 1

De acuerdo con las características del episodio (duración, tipo de crisis y estado neurológico previo), ¿cómo se clasifica este evento?

A) Crisis febril compleja.

B) Epilepsia mioclónica benigna de la infancia.

C) Crisis febril simple. *

D) Estatus epiléptico febril.

Retroalimentación Pregunta 1:

Las crisis febriles simples son la causa más común de convulsiones en la infancia (típicamente entre los 6 meses y 5 años). Se caracterizan por ser generalizadas, durar menos de 15 minutos, no recurrir en un periodo de 24 horas y ocurrir en un niño con

desarrollo neurológico normal, sin evidencia de infección del sistema nervioso central (la causa aquí es la OMA).

Pregunta 2

Dado el diagnóstico, ¿cuál es la conducta terapéutica de mantenimiento recomendada para este paciente al egreso?

A) Iniciar Ácido Valproico por 12 meses para prevenir epilepsia.

B) Indicar Fenobarbital a dosis bajas como profilaxis continua.

C) Prescribir Diazepam oral profiláctico ante cualquier cuadro febril.

D) Tratar la causa de la fiebre (antibiótico/antipirético) y tranquilizar a los padres; no requiere profilaxis antiepiléptica. *

Retroalimentación Pregunta 2:

Las crisis febriles simples tienen un pronóstico excelente a largo plazo y no aumentan significativamente el riesgo de desarrollar epilepsia en el futuro. Por lo tanto, las guías internacionales desaconsejan rotundamente el uso de antiepilépticos de mantenimiento (por sus efectos adversos) y se enfocan en tratar la infección subyacente y controlar la fiebre, además de educar a la familia.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Tromboembolia Pulmonar (Neumología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 55 años de edad, quien se encuentra en su cuarto día posoperatorio de un reemplazo total de cadera derecha. Inicia de forma súbita con disnea de reposo, dolor torácico de características pleuríticas y ansiedad extrema. A la exploración

física: Tensión arterial 100/60 mmHg, Frecuencia Cardiaca 115 lpm, Frecuencia Respiratoria 28 rpm y saturación de oxígeno de 87% al aire ambiente. Se observa ingurgitación yugular leve.

Pregunta 1

Se le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones en urgencias. ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en esta patología y cuál es el patrón clásico (aunque menos sensible) de sobrecarga del ventrículo derecho?

A) Taquicardia sinusal (más frecuente); Patrón S1Q3T3 (clásico). *

B) Fibrilación auricular (más frecuente); Bloqueo de rama izquierda (clásico).

C) Bradicardia sinusal (más frecuente); Inversión de onda T en V5-V6 (clásico).

D) Bloqueo AV de primer grado (más frecuente); Elevación del ST en cara inferior (clásico).

Retroalimentación Pregunta 1:

En la Tromboembolia Pulmonar (TEP), la taquicardia sinusal es la alteración electrocardiográfica que se encuentra con mayor frecuencia. El patrón S1Q3T3 (onda S en DI, onda Q en DIII y onda T invertida en DIII) es el signo clásico descrito históricamente que indica "cor pulmonale" agudo o sobrecarga del ventrículo derecho, aunque aparece en menos del 20% de los casos.

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico de certeza en esta paciente con alta probabilidad clínica (según la escala de Wells), ¿cuál es el estudio de imagen de elección (estándar de oro actual no invasivo)?

A) Radiografía de tórax en proyecciones PA y lateral.

B) Angiografía pulmonar por Tomografía Axial Computarizada (AngioTAC). *

C) Gammagrama pulmonar ventilatorio/perfusorio (V/Q).

D) Ecocardiograma transesofágico.

Retroalimentación Pregunta 2:

La AngioTAC de tórax es actualmente el estudio de primera línea y estándar de oro clínico para el diagnóstico de TEP en pacientes estables o con alta sospecha clínica, debido a su alta sensibilidad y especificidad para visualizar directamente el defecto de llenado (trombo) en las arterias pulmonares principales, lobares o segmentarias.

Especialidad: Cirugía

Tema: Diverticulitis (Patología Intestinal Qx)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 65 años de edad acude a consulta de urgencias por presentar dolor abdominal de 48 horas de evolución, constante, localizado en la fosa iliaca izquierda. Refiere también fiebre no cuantificada y cambios en el hábito intestinal (estreñimiento reciente). A la exploración física, la temperatura es de 38.2°C y hay dolor selectivo a la palpación profunda en el cuadrante inferior izquierdo, sin datos claros de irritación peritoneal (rebote negativo). Los laboratorios muestran leucocitosis de 13,000/mm^3 con neutrofilia.

Pregunta 1

Ante la sospecha de enfermedad diverticular complicada, ¿cuál es el estudio de imagen de elección que permite confirmar el diagnóstico y estadificar la gravedad?

A) Colon por enema con bario.

B) Colonoscopia total.

C) Tomografía Computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste. *

D) Ultrasonido pélvico.

Retroalimentación Pregunta 1:

La TAC de abdomen y pelvis es el estudio de elección para la diverticulitis aguda. Permite confirmar el diagnóstico (engrosamiento de la pared del colon, inflamación de la grasa pericólica), identificar la presencia de divertículos y, lo más importante, detectar complicaciones como abscesos, fístulas o aire libre (perforación), lo cual sirve para clasificar la enfermedad (Clasificación de Hinchey). La colonoscopia y el enema están contraindicados en la fase aguda por el alto riesgo de perforación iatrogénica.

Pregunta 2

Si la tomografía reporta inflamación pericólica aislada sin abscesos ni líquido libre, ¿cuál es el estadio de Hinchey y el manejo inicial indicado?

A) Hinchey I; Manejo conservador con antibióticos y dieta líquida. *

B) Hinchey II; Drenaje percutáneo guiado por TAC.

C) Hinchey III; Resección sigmoidea y anastomosis primaria.

D) Hinchey IV; Cirugía de Hartmann de urgencia.

Retroalimentación Pregunta 2:

Un cuadro inflamatorio confinado a la pared del colon y la grasa pericólica (flemón) corresponde a un estadio Hinchey I (o Ia). Al no haber perforación libre ni un absceso organizado grande (>4 cm), el tratamiento es eminentemente médico: reposo intestinal (dieta líquida o ayuno) y esquema de antibióticos que cubran bacilos gramnegativos y anaerobios.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Embarazo ectópico (Hemorragias del Primer Trimestre)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 28 años de edad, nuligesta, con antecedente de Enfermedad Pélvica Inflamatoria hace 3 años. Acude al servicio de urgencias por dolor pélvico intenso de inicio súbito, predominantemente en fosa iliaca derecha, asociado a mareo y sangrado transvaginal escaso. Su fecha de última menstruación fue hace 7 semanas. A la exploración: Tensión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardiaca de 115 lpm, palidez de tegumentos y abdomen doloroso a la palpación profunda con signo de rebote positivo. La prueba inmunológica de embarazo en orina es positiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y en qué porción anatómica se localiza con mayor frecuencia esta patología?

A) Amenaza de aborto; cavidad uterina.

B) Ruptura de quiste del cuerpo lúteo; ovario derecho.

C) Embarazo ectópico roto; porción ampular de la trompa de Falopio. *

D) Apendicitis aguda; ciego.

Retroalimentación Pregunta 1:

El cuadro clásico de embarazo ectópico roto consiste en amenorrea, dolor pélvico agudo y sangrado transvaginal, que evoluciona rápidamente a signos de irritación peritoneal (hemoperitoneo) y choque hipovolémico. El antecedente de EPI es el principal factor de riesgo (por daño ciliar tubárico). Más del 95% de los embarazos ectópicos ocurren en la trompa de Falopio, siendo la región de la ampolla (ampular) el sitio más frecuente (70-80%).

Pregunta 2

Dado el estado hemodinámico inestable de la paciente y los signos de irritación peritoneal, ¿cuál es la conducta terapéutica de elección y más urgente?

A) Administrar Metotrexato intramuscular dosis única.

B) Laparotomía o laparoscopia de urgencia para control de daños (salpingectomía). *

C) Reposo absoluto e inicio de progesterona micronizada.

D) Realizar un legrado uterino instrumental.

Retroalimentación Pregunta 2:

La inestabilidad hemodinámica (hipotensión, taquicardia) y la presencia de un abdomen agudo (hemoperitoneo) son indicaciones absolutas para cirugía de emergencia. El objetivo principal es detener la hemorragia, lo cual generalmente requiere la extirpación de la trompa afectada (salpingectomía). El manejo médico con Metotrexato está estrictamente reservado para pacientes estables, sin dolor severo, con ectópicos no rotos y niveles bajos de fracción beta de hCG.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hipotiroidismo (Patología Tiroidea)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 45 años de edad acude a consulta externa refiriendo fatiga crónica, aumento de peso de 6 kg en el último semestre a pesar de tener poco apetito, intolerancia al frío y estreñimiento. A la exploración física, destaca la presencia de piel seca y áspera, caída de la cola de las cejas (madarosis), bradicardia de 55 lpm y reflejos osteotendinosos con fase de relajación prolongada. La glándula tiroides no es palpable.

Pregunta 1

Ante la sospecha de hipotiroidismo primario, ¿cuál es el perfil tiroideo confirmatorio que se espera encontrar en los estudios de laboratorio?

A) TSH disminuida y T4 libre elevada.

B) TSH elevada y T4 libre normal.

C) TSH elevada y T4 libre disminuida. *

D) TSH disminuida y T4 libre disminuida.

Retroalimentación Pregunta 1:

El hipotiroidismo primario se caracteriza por la falla directa de la glándula tiroides para producir hormonas. Ante la caída de los niveles de T4 libre, el eje hipotálamo-hipófisis pierde la retroalimentación negativa, lo que desencadena una elevación compensatoria y marcada de la Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH). El patrón de TSH elevada con T4 libre baja confirma el diagnóstico.

Pregunta 2

¿Cuál es la etiología autoinmune más frecuente de esta patología en áreas geográficas con suficiencia de yodo y qué anticuerpos son patognomónicos?

A) Tiroiditis de Hashimoto; Anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (anti-TPO). *

B) Enfermedad de Graves; Anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI).

C) Tiroiditis subaguda de De Quervain; Anticuerpos antinucleares (ANA).

D) Bocio multinodular tóxico; Anticuerpos anti-tiroglobulina exclusivamente.

Retroalimentación Pregunta 2:

La Tiroiditis de Hashimoto (tiroiditis linfocítica crónica) es la causa número uno de hipotiroidismo en regiones donde no hay deficiencia de yodo. Se caracteriza por la destrucción autoinmune mediada por células T y autoanticuerpos, siendo los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (anti-TPO) los más específicos y presentes en más del 90% de los pacientes.

Especialidad: Cirugía

Tema: Glaucoma de ángulo cerrado (Oftalmología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 60 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar dolor ocular derecho de inicio súbito y de extremada intensidad, irradiado a la hemicara ipsilateral, acompañado de náuseas y vómitos. Refiere visión borrosa y percepción de "halos de colores" alrededor de las luces. A la exploración, el ojo derecho presenta hiperemia conjuntival ciliar (ojo rojo), la córnea se observa opaca (edematosa) y la pupila está en midriasis media y no responde a la luz (arrefléctica). A la palpación bidigital, el globo ocular derecho se siente duro como una piedra.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta verdadera urgencia oftalmológica?

A) Uveítis anterior aguda.

B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado. *

C) Queratitis herpética.

D) Endoftalmitis bacteriana.

Retroalimentación Pregunta 1:

El glaucoma agudo de ángulo cerrado se presenta como un cuadro aparatoso de dolor ocular severo, síntomas vagales (náuseas/vómitos) y disminución de la agudeza visual. Los signos cardinales a la exploración son el ojo rojo (inyección ciliar), el edema corneal (que causa los halos de colores), la pupila en midriasis media fija y una presión intraocular elevadísima (ojo duro a la palpación).

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial sistémico de primera línea para disminuir rápidamente la presión intraocular y preparar a la paciente para la iridotomía definitiva?

A) Corticosteroides intravenosos a altas dosis.

B) Acetazolamida (inhibidor de la anhidrasa carbónica) vía intravenosa u oral, junto con agentes hiperosmóticos (Manitol). *

C) Antibióticos tópicos de amplio espectro.

D) Ciclopléjicos tópicos (Atropina) para relajar el cuerpo ciliar.

Retroalimentación Pregunta 2:

El objetivo inmediato es salvar el nervio óptico disminuyendo la presión intraocular (PIO). Se logra reduciendo la producción de humor acuoso con Acetazolamida sistémica y deshidratando el vítreo con Manitol IV. Se añaden mióticos tópicos (Pilocarpina) para abrir el ángulo. Los ciclopléjicos como la Atropina están absolutamente contraindicados porque dilatan la pupila (midriasis) y cierran aún más el ángulo de drenaje.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Trastorno Depresivo Mayor (Psiquiatría)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 35 años es llevado a consulta por su esposa. Ella refiere que desde hace un mes y medio su esposo se muestra profundamente triste, llora sin motivo aparente y ha perdido el interés por actividades que antes disfrutaba, como jugar fútbol los domingos. El paciente manifiesta sentirse "como una carga", presenta insomnio de despertar temprano (se despierta a las 3:00 a.m. y no vuelve a dormir) y ha perdido 4 kg de peso por falta de apetito. Niega consumo de sustancias.

Pregunta 1

De acuerdo con los criterios del DSM-5, ¿cuáles son los dos síntomas cardinales, de los cuales al menos uno debe estar presente de forma obligatoria por un mínimo de 2 semanas, para establecer el diagnóstico?

A) Estado de ánimo deprimido y anhedonia (pérdida de interés o placer). *

B) Ideación suicida e insomnio severo.

C) Alteraciones del apetito y fatiga crónica.

D) Sentimientos de culpa y enlentecimiento psicomotor.

Retroalimentación Pregunta 1:

Para diagnosticar un Trastorno Depresivo Mayor según el DSM-5, el paciente debe presentar al menos 5 de los 9 síntomas establecidos durante al menos 2 semanas continuas. Sin embargo, es requisito indispensable que al menos uno de esos síntomas sea el estado de ánimo deprimido (tristeza) o la anhedonia (incapacidad para experimentar placer o pérdida de interés en casi todas las actividades).

Pregunta 2

¿Cuál es el grupo de psicofármacos considerado de primera elección por su perfil de eficacia y seguridad clínica en el tratamiento ambulatorio inicial de este paciente?

A) Antidepresivos tricíclicos (ej. Amitriptilina).

B) Inhibidores de la monoaminooxidasa (ej. Selegilina).

C) Benzodiacepinas de alta potencia (ej. Clonazepam).

D) Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina - ISRS (ej. Sertralina, Fluoxetina). *

Retroalimentación Pregunta 2:

Los ISRS son el tratamiento farmacológico de primera línea para la depresión mayor. Tienen una eficacia comparable a los antidepresivos de generaciones anteriores (como los tricíclicos) pero con un perfil de efectos secundarios mucho más benigno y tolerable, y son mucho menos letales en caso de sobredosis. Su inicio de acción terapéutica tarda entre 2 y 4 semanas.

Especialidad: Cirugía

Tema: Hiperplasia Prostática Benigna (Urología)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 68 años de edad acude a consulta por sintomatología urinaria de 2 años de evolución, la cual se ha exacerbado recientemente. Refiere que tiene que levantarse hasta 4 veces por la noche a orinar (nocturia), nota que el chorro de orina ha perdido fuerza, presenta goteo terminal y en ocasiones tiene que pujar para iniciar la micción. Al tacto rectal, se palpa una próstata aumentada de tamaño, de superficie lisa, consistencia fibroelástica, bordes bien definidos, sin nódulos pétreos y no dolorosa.

Pregunta 1

Anatómicamente, ¿en qué zona de la glándula prostática se desarrolla predominantemente la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), lo que explica la compresión temprana de la uretra?

A) Zona periférica.

B) Zona central.

C) Zona de transición (periuretral). *

D) Zona del estroma fibromuscular anterior.

Retroalimentación Pregunta 1:

La HPB se origina de manera característica en la zona de transición, la cual rodea inmediatamente a la uretra prostática. Su crecimiento nodular comprime directamente el conducto, generando los síntomas obstructivos del tracto urinario

inferior (STUI). En contraste, el cáncer de próstata se desarrolla típicamente en la zona periférica (que es la porción que se palpa en el tacto rectal).

Pregunta 2

Si el paciente presenta síntomas del tracto urinario inferior de moderados a severos que afectan su calidad de vida, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea recomendado para aliviar rápidamente los síntomas obstructivos dinámicos?

A) Inhibidores de la 5-alfa reductasa (ej. Finasterida).

B) Bloqueadores alfa-1 adrenérgicos (ej. Tamsulosina, Terazosina). *

C) Antimuscarínicos (ej. Oxibutinina).

D) Inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (ej. Sildenafil).

Retroalimentación Pregunta 2:

Los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos actúan relajando el músculo liso del cuello vesical y de la cápsula prostática (componente dinámico de la obstrucción). Son de primera elección porque proporcionan un alivio rápido de los síntomas (en días o pocas semanas). Los inhibidores de la 5-alfa reductasa (que reducen el tamaño de la próstata) tardan hasta 6 meses en tener un efecto clínico significativo y se suelen usar combinados con los alfa-bloqueadores en próstatas muy grandes (>40 gramos).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: HIPERÉMESIS GRAVÍDICA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 20 años con 10 semanas de gestación acude por náusea y vómito incoercibles desde hace 2 semanas, con pérdida de 4 kg de peso, intolerancia a la vía oral y datos de deshidratación. Niega dolor abdominal y sangrado transvaginal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hiperémesis gravídica *
B) Gastroenteritis aguda.
C) Pielonefritis aguda.
D) Amenaza de aborto.

Retroalimentación:
La hiperémesis gravídica se caracteriza por náusea y vómito intensos en el embarazo, con pérdida de peso, cetosis o alteraciones hidroelectrolíticas, más allá del malestar matutino habitual.

Pregunta 2
¿Cuál es una alteración frecuentemente asociada?
A) Deshidratación y trastornos electrolíticos *
B) Policitemia severa.
C) Hiperpotasemia obligatoria.
D) Hemorragia uterina masiva.

Retroalimentación:
La pérdida persistente de líquidos por vómito favorece deshidratación, hipocloremia, hipokalemia y alcalosis metabólica, por lo que el abordaje debe incluir corrección hidroelectrolítica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: PROLAPSO DE CORDÓN UMBILICAL
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 34 semanas de gestación acude por inicio de trabajo de parto. Posterior a ruptura de membranas presenta bradicardia fetal súbita. A la exploración se palpa una estructura pulsátil por delante de la presentación fetal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Prolapso de cordón umbilical *
B) Desprendimiento prematuro de placenta.
C) Placenta previa.
D) Circular de cordón simple.

Retroalimentación:
La palpación de una estructura pulsátil delante de la presentación fetal, junto con bradicardia fetal tras ruptura de membranas, es altamente sugestiva de prolapso de cordón umbilical.

Pregunta 2
¿Cuál es la principal complicación fetal inmediata?

A) Hipoxia fetal aguda *
B) Macrosomía.
C) Polihidramnios.
D) Isoinmunización Rh.

Retroalimentación:
La compresión del cordón disminuye el flujo sanguíneo fetoplacentario y puede producir hipoxia fetal aguda, por lo que es una urgencia obstétrica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: MIOMATOSIS UTERINA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 39 años consulta por menstruaciones abundantes, sensación de peso pélvico y aumento del perímetro abdominal. A la exploración ginecológica se palpa útero aumentado de tamaño, irregular y móvil.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Miomatosis uterina *
B) Endometritis aguda.
C) Embarazo ectópico.
D) Atrofia endometrial.

Retroalimentación:
Los miomas uterinos suelen presentarse con sangrado menstrual abundante, síntomas compresivos y aumento del tamaño uterino con contornos irregulares.

Pregunta 2
¿Cuál es el síntoma más frecuente asociado a esta entidad?
A) Sangrado uterino anormal *
B) Galactorrea.
C) Coluria.
D) Hemoptisis.

Retroalimentación:
Dependiendo de su localización, los miomas pueden ocasionar sangrado uterino anormal, especialmente cuando deforman la cavidad o incrementan la superficie endometrial.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: OTITIS MEDIA AGUDA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Lactante de 18 meses presenta fiebre, irritabilidad y llanto al acostarse. La madre refiere que se jala repetidamente la oreja derecha. A la otoscopia se observa membrana timpánica eritematosa y abombada.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Otitis media aguda *
B) Otitis externa.
C) Mastoiditis crónica.
D) Tapón de cerumen.

Retroalimentación:
La fiebre, irritabilidad y membrana timpánica abombada orientan a otitis media aguda, una infección frecuente en lactantes y preescolares.

Pregunta 2
¿Cuál es el hallazgo otoscópico más sugestivo?
A) Abombamiento de la membrana timpánica *
B) Perforación timpánica seca antigua.
C) Conducto auditivo con costras.
D) Presencia de hipoacusia sin otros datos.

Retroalimentación:
El abombamiento timpánico es un dato especialmente útil para identificar inflamación y acumulación de exudado en oído medio.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: CRUP ESPASMÓDICO / OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niño de 3 años es llevado por despertar nocturno súbito con tos metálica, voz ronca y estridor inspiratorio. Se encuentra ansioso, pero afebril y sin aspecto tóxico.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Crup espasmódico *
B) Epiglotitis bacteriana.
C) Bronquiolitis.
D) Neumonía lobar.

Retroalimentación:
El inicio nocturno súbito, con tos ronca o “perruna”, estridor y ausencia de fiebre importante, es compatible con crup espasmódico.

Pregunta 2
¿Cuál es un dato que lo aleja de epiglotitis?
A) Ausencia de aspecto tóxico importante *
B) Estridor inspiratorio.
C) Disfonía.
D) Dificultad respiratoria.

Retroalimentación:
La epiglotitis suele acompañarse de fiebre alta, aspecto tóxico, sialorrea y mayor compromiso general. Un niño afebril y sin aspecto séptico orienta más a crup.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Escolar de 9 años presenta edema palpebral, hipertensión y orina oscura dos semanas después de un episodio de faringoamigdalitis. Refiere disminución del volumen urinario.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Glomerulonefritis postestreptocócica *
B) Síndrome nefrótico idiopático.
C) Infección urinaria baja.
D) Litiasis renal.

Retroalimentación:
La hematuria macroscópica, edema e hipertensión posteriores a infección estreptocócica son hallazgos clásicos de glomerulonefritis postinfecciosa.

Pregunta 2
¿Cuál es un dato clínico esperado en este padecimiento?
A) Hematuria con edema e hipertensión *
B) Proteinuria masiva aislada sin hematuria.
C) Poliuria persistente con hipernatremia.
D) Dolor lumbar cólico con irradiación inguinal.

Retroalimentación:
Se trata de un cuadro nefrítico, por lo que predominan hematuria, retención de líquidos, hipertensión y disminución de la filtración glomerular.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: TRAUMA ABDOMINAL CON LESIÓN ESPLÉNICA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Masculino de 25 años sufre accidente automovilístico y recibe golpe contuso en hemiabdomen izquierdo. Posteriormente presenta dolor en hipocondrio izquierdo, palidez, taquicardia y dolor irradiado a hombro izquierdo.

Pregunta 1
¿Cuál es el órgano lesionado con mayor probabilidad?
A) Bazo *
B) Páncreas.
C) Vejiga.
D) Colon sigmoides.

Retroalimentación:
En trauma contuso de hemiabdomen izquierdo, el bazo es uno de los órganos más frecuentemente lesionados. El dolor referido a hombro izquierdo corresponde al signo de Kehr.

Pregunta 2
¿Cuál es el dato que apoya irritación diafragmática por hemoperitoneo?
A) Dolor referido a hombro izquierdo *
B) Ictericia progresiva.

C) Hemoptisis.
D) Disuria.

Retroalimentación:
La sangre intraperitoneal puede irritar el diafragma y producir dolor referido al hombro izquierdo, hallazgo típico en lesión esplénica.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: TORSIÓN DE ASA INTESTINAL / VÓLVULO DE SIGMOIDES
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 71 años con estreñimiento crónico acude por dolor abdominal, distensión marcada y ausencia de evacuaciones y gases. Presenta timpanismo generalizado y abdomen muy distendido.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Vólvulo de sigmoides *
B) Apendicitis aguda.
C) Colitis microscópica.
D) Gastritis aguda.

Retroalimentación:
En adultos mayores con estreñimiento crónico y gran distensión abdominal, el vólvulo de sigmoides es una causa importante de obstrucción intestinal.

Pregunta 2
¿Cuál es el mecanismo principal de este padecimiento?
A) Torsión del colon sobre su mesenterio *
B) Perforación gástrica espontánea.
C) Espasmo anal severo.
D) Herniación diafragmática traumática.

Retroalimentación:
El vólvulo ocurre cuando un segmento intestinal gira sobre su eje mesentérico, provocando obstrucción y potencial compromiso vascular.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ACV ISQUÉMICO
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 68 años con antecedente de hipertensión y fibrilación auricular presenta inicio súbito de hemiparesia derecha y dificultad para hablar desde hace 45 minutos. Se encuentra consciente y sin datos de trauma.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Evento vascular cerebral isquémico *
B) Migraña con aura prolongada.
C) Crisis conversiva.
D) Absceso cerebral.

Retroalimentación:
La aparición súbita de déficit neurológico focal, como hemiparesia y afasia, obliga a pensar en un evento vascular cerebral isquémico hasta demostrar lo contrario.

Pregunta 2
¿Cuál es un factor de riesgo cardioembólico importante presente en este caso?
A) Fibrilación auricular *
B) Rinitis alérgica.
C) Gastritis crónica.
D) Hipotiroidismo leve.

Retroalimentación:
La fibrilación auricular favorece la formación de trombos intracardiacos que pueden embolizar a la circulación cerebral y causar infarto cerebral.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: ANAFILAXIA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 30 años recibe un antibiótico y minutos después presenta urticaria generalizada, disnea, sibilancias, edema labial y sensación de desvanecimiento. La presión arterial es de 80/50 mmHg.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Anafilaxia *
B) Crisis asmática aislada.
C) Ataque de pánico.
D) Urticaria simple sin repercusión sistémica.

Retroalimentación:
La afectación cutánea junto con compromiso respiratorio y hemodinámico tras exposición a un alérgeno es característica de anafilaxia.

Pregunta 2
¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?
A) Adrenalina intramuscular *
B) Antihistamínico oral únicamente.
C) Salbutamol como monoterapia.
D) Furosemida intravenosa.

Retroalimentación:
La adrenalina intramuscular es el tratamiento de primera línea en anafilaxia, ya que revierte broncoconstricción, vasodilatación y edema de vía aérea.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 41 años con antecedente de uso crónico de esteroides suspendidos abruptamente acude por debilidad intensa, náusea, vómito, hipotensión y dolor abdominal. Se observa somnoliento y deshidratado.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Crisis suprarrenal *
B) Hipertiroidismo severo.
C) Colecistitis aguda.
D) Gastroenteritis viral simple.

Retroalimentación:
La suspensión brusca de esteroides en un paciente dependiente puede precipitar

insuficiencia suprarrenal aguda, con hipotensión, síntomas gastrointestinales y deterioro general.

Pregunta 2
¿Cuál es la medida terapéutica urgente más importante?
A) Hidrocortisona intravenosa y líquidos *
B) Restricción hídrica.
C) Insulina subcutánea.
D) Solo observación.

Retroalimentación:
El tratamiento urgente de la crisis suprarrenal incluye reposición vigorosa de líquidos y administración de glucocorticoides parenterales, típicamente hidrocortisona.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: CIRROSIS CON HEMORRAGIA VARICEAL
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 57 años con cirrosis hepática conocida presenta hematemesis abundante y mareo. A la exploración está taquicárdico, con hipotensión y signos de hepatopatía crónica.

Pregunta 1
¿Cuál es la causa más probable del sangrado?
A) Ruptura de várices esofágicas *
B) Hemorroide interna.
C) Fisura anal.
D) Divertículo de Meckel.

Retroalimentación:
En un paciente cirrótico con hematemesis abundante, la ruptura de várices esofágicas secundarias a hipertensión portal es una causa muy probable y potencialmente letal.

Pregunta 2
¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de fondo?
A) Hipertensión portal *
B) Hipotiroidismo crónico.

C) Vasculitis de pequeño vaso.
D) Hipercalcemia severa.

Retroalimentación:
La hipertensión portal favorece la formación de colaterales portosistémicas, incluidas las várices esofágicas, con alto riesgo de ruptura y hemorragia masiva.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Pólipos endometriales (Sangrados Uterinos Anormales: Origen Anatómico Benigno)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 45 años de edad, multípara, acude a consulta por presentar sangrado transvaginal escaso pero frecuente entre sus periodos menstruales regulares (metrorragia intermenstrual) de 4 meses de evolución. Niega uso de hormonales o DIU. A la exploración física, el cérvix se observa macroscópicamente sano y sin lesiones. El ultrasonido transvaginal reporta un útero de tamaño normal con una imagen focal hiperecogénica bien delimitada de 1.5 cm en el interior de la cavidad endometrial.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación PALM-COEIN de la FIGO para sangrado uterino anormal y los hallazgos ecográficos, ¿cuál es el diagnóstico anatómico más probable?

A) Mioma submucoso (L).

B) Adenomiosis (A).

C) Malignidad endometrial (M).

D) Pólipo endometrial (P). *

Retroalimentación Pregunta 1:

La clasificación PALM-COEIN divide las causas de sangrado uterino en estructurales (PALM) y no estructurales (COEIN). Los pólipos endometriales son la causa estructural benigna más común de sangrado intermenstrual en mujeres en edad reproductiva tardía y perimenopausia. Clásicamente, se observan en el ultrasonido como masas focales hiperecogénicas dentro de la cavidad endometrial.

Pregunta 2

¿Cuál es el abordaje diagnóstico confirmatorio (estándar de oro) y terapéutico de elección recomendado para esta paciente?

A) Legrado Uterino Instrumental a ciegas.

B) Histeroscopia con resección dirigida (polipectomía). *

C) Histerectomía total abdominal.

D) Prescripción de progestágenos cíclicos por 6 meses.

Retroalimentación Pregunta 2:

La histeroscopia de consultorio o quirúrgica es el estándar de oro tanto para el diagnóstico definitivo (visualización directa) como para el tratamiento de los pólipos endometriales. Permite la polipectomía dirigida y asegura la extracción completa de la base del pólipo para su estudio histopatológico (descartando así hiperplasia o malignidad), algo que el legrado a ciegas frecuentemente falla en lograr.

Especialidad: Pediatría

Tema: Laringotraqueítis (Patología Respiratoria del Pediátrico)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Lactante masculino de 2 años de edad es llevado a urgencias a las 2:00 a.m. por dificultad respiratoria. La madre refiere que hace dos días inició con escurrimiento nasal hialino y febrícula. Hace unas horas comenzó con una tos muy seca y metálica, descrita como "tos de foca", y presenta un ruido áspero al meter el aire. A la exploración física, el niño se encuentra irritable, con estridor inspiratorio en reposo, tiraje intercostal leve y saturación de 92% al aire ambiente.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente viral más frecuentemente asociado a este cuadro clínico y qué hallazgo radiológico clásico se buscaría en una radiografía anteroposterior del cuello (aunque su diagnóstico es fundamentalmente clínico)?

A) Virus Sincitial Respiratorio; signo de la huella del pulgar.

B) Virus de la Parainfluenza tipo 1 y 3; signo de la aguja o del campanario. *

C) Adenovirus; consolidación apical derecha.

D) Haemophilus influenzae tipo B; ensanchamiento mediastínico.

Retroalimentación Pregunta 1:

La laringotraqueítis aguda (Crup) es una enfermedad viral que causa inflamación y edema de la región subglótica. El virus de la parainfluenza (tipos 1 y 3) es el agente causal en el 75% de los casos. Aunque el diagnóstico es clínico (tríada de tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio), la radiografía AP de cuello puede mostrar el estrechamiento subglótico característico conocido como el "signo del campanario" o "de la aguja".

Pregunta 2

Dado que el paciente presenta estridor en reposo (Crup moderado), ¿cuál es el pilar del tratamiento farmacológico agudo en el servicio de urgencias para disminuir el edema de la vía aérea y evitar la intubación?

A) Glucocorticoides sistémicos (Dexametasona dosis única) y nebulización con L-adrenalina (Epinefrina racémica). *

B) Antibióticos intravenosos (Ceftriaxona) de forma inmediata.

C) Broncodilatadores de acción corta (Salbutamol nebulizado) e ipratropio.

D) Antihistamínicos de primera generación y jarabes antitusivos.

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento fundamental del Crup incluye los glucocorticoides (la Dexametasona oral o intramuscular es de primera línea por su vida media larga). Cuando hay estridor en reposo o dificultad respiratoria evidente, se debe agregar L-adrenalina (o epinefrina racémica) nebulizada, la cual produce una rápida vasoconstricción de la mucosa subglótica, disminuyendo drásticamente el edema y el estridor en cuestión de 10 a 30 minutos.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Gota (Reumatología)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 55 años, con antecedente de hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida. Acude a urgencias por presentar dolor agudo, insoportable e incapacitante en el primer ortejo del pie derecho (podagra) que lo despertó por la madrugada. A la exploración física, la articulación metatarsofalángica del primer dedo se encuentra intensamente eritematosa, edematizada, caliente y exquisitamente dolorosa al más mínimo roce de la sábana.

Pregunta 1

Se realiza una artrocentesis diagnóstica. ¿Cuál es el hallazgo patognomónico esperado en el análisis microscópico de luz polarizada del líquido sinovial que confirmaría el diagnóstico?

A) Cristales romboidales con birrefringencia positiva débil (Pirofosfato de calcio).

B) Cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa fuerte (Urato monosódico). *

C) Abundantes diplococos gramnegativos intracelulares.

D) Cristales de colesterol en forma de placas rectangulares.

Retroalimentación Pregunta 1:

El ataque agudo de gota clásicamente debuta como una monoartritis aguda de la primera articulación metatarsofalángica (podagra). El estándar de oro diagnóstico es la visualización directa de los cristales de urato monosódico fagocitados por neutrófilos en el líquido sinovial. Bajo el microscopio de luz polarizada, estos cristales tienen forma de aguja y presentan una intensa birrefringencia negativa (se ven amarillos cuando están paralelos al eje del compensador).

Pregunta 2

Durante esta fase aguda de inflamación severa, ¿cuál es la pauta farmacológica recomendada por las guías para el manejo inicial y qué fármaco está contraindicado iniciar en este momento?

A) Iniciar Alopurinol de inmediato para bajar el ácido úrico; suspender AINEs.

B) Iniciar AINEs (ej. Indometacina, Naproxeno) a dosis altas o Colchicina; no iniciar Alopurinol durante la crisis aguda. *

C) Administrar antibióticos intraarticulares y Febuxostat oral.

D) Probenecid oral como monoterapia de rescate.

Retroalimentación Pregunta 2:

El objetivo en el ataque agudo es controlar la intensa cascada inflamatoria. Los AINEs a dosis plenas, la Colchicina o los corticosteroides (sistémicos o intraarticulares) son los fármacos de primera línea. Es una regla de oro NO iniciar fármacos hipouremiantes (como el Alopurinol o Febuxostat) durante un ataque agudo, ya que la movilización rápida de los depósitos de urato puede exacerbar y prolongar severamente la crisis.

Especialidad: Cirugía

Tema: Vólvulo (Patología Intestinal Qx)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 78 años, residente de un asilo de ancianos, con antecedente de demencia senil y estreñimiento crónico severo. Es traído a urgencias por presentar distensión abdominal masiva y progresiva de 3 días de evolución, ausencia de canalización de gases, dolor abdominal tipo cólico y vómitos tardíos. A la exploración, el abdomen se observa marcadamente asimétrico, hipertimpánico a la percusión en el flanco izquierdo y sin datos de peritonitis (ausencia de rebote).

Pregunta 1

De acuerdo con el grupo etario y el cuadro clínico, ¿cuál es el diagnóstico más probable y qué signo clásico se observaría en la radiografía simple de abdomen?

A) Obstrucción por bridas; Signo de la pila de monedas.

B) Vólvulo de sigmoides; Signo del grano de café (o asa en omega). *

C) Vólvulo de ciego; Imagen en embudo o pico de pájaro en el cuadrante inferior derecho.

D) Isquemia mesentérica; Neumatosis intestinal.

Retroalimentación Pregunta 1:

El vólvulo de sigmoides (torsión del colon sobre su propio eje mesentérico) es la causa más común de obstrucción de intestino grueso en adultos mayores, especialmente aquellos con estreñimiento crónico severo, megacolon o postración institucional. La radiografía simple de abdomen es muy sugestiva al mostrar una

dilatación masiva y desproporcionada del asa sigmoidea que surge de la pelvis y se dirige hacia el diafragma, dando la apariencia de un gran "grano de café" o un neumático (asa en U invertida).

Pregunta 2

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, los laboratorios no sugieren isquemia (lactato normal, sin acidosis) y no hay datos de irritación peritoneal, ¿cuál es el abordaje terapéutico inicial de primera línea?

A) Laparotomía exploradora con resección sigmoidea de urgencia y colostomía (Hartmann).

B) Descompresión y devolvulación endoscópica mediante colonoscopia o rectosigmoidoscopia rígida. *

C) Colocación de sonda nasogástrica y enemas de bario a presión.

D) Laparoscopia diagnóstica sin manipulación intestinal.

Retroalimentación Pregunta 2:

En ausencia de signos clínicos (peritonitis, choque) o bioquímicos (leucocitosis severa, hiperlactatemia) de isquemia, necrosis o perforación intestinal, el tratamiento inicial de elección es la devolvulación no quirúrgica mediante colonoscopia o rectosigmoidoscopia. Este procedimiento logra descomprimir el intestino y resolver la obstrucción aguda, permitiendo estabilizar al paciente para programar una resección sigmoidea electiva definitiva posteriormente, ya que la tasa de recurrencia si no se opera es altísima.

Especialidad: Nefrología

Tema: Lesión Renal Aguda (Nefrología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 65 años de edad es ingresado a la unidad de cuidados intensivos tras presentar choque hipovolémico secundario a un sangrado de tubo digestivo alto

severo. A pesar de una adecuada reanimación hídrica y transfusión, restaurando la presión arterial a rangos normales, el paciente evoluciona a las 48 horas con oliguria marcada (producción de orina de 200 ml en 24 horas). Los laboratorios reportan un incremento de la creatinina sérica basal de 0.9 mg/dL a 3.2 mg/dL, y el nitrógeno ureico en sangre (BUN) se eleva a 60 mg/dL. Se calcula una Fracción de Excreción de Sodio (FeNa) del 3%.

Pregunta 1

De acuerdo con los hallazgos de laboratorio (relación BUN/Creatinina < 20 y FeNa > 2%), ¿cuál es el diagnóstico fisiopatológico de la lesión renal aguda de este paciente?

A) Lesión renal aguda prerrenal (hipoperfusión sostenida).

B) Lesión renal aguda intrínseca (Necrosis Tubular Aguda isquémica). *

C) Lesión renal aguda posrenal (obstrucción bilateral).

D) Nefritis intersticial aguda por fármacos.

Retroalimentación Pregunta 1:

Aunque el evento inicial fue una hipoperfusión (prerrenal), la falta de recuperación tras restaurar la volemia y los índices urinarios indican daño estructural. Una FeNa > 2% y una relación BUN/Creatinina < 20 son característicos de la Necrosis Tubular Aguda (NTA), la causa más común de lesión renal aguda intrínseca en pacientes hospitalizados. El túbulo necrosado pierde su capacidad de reabsorber sodio, por lo que este se tira en la orina (FeNa alta).

Pregunta 2

¿Cuál es el hallazgo patognomónico que esperaría encontrar en el análisis microscópico del sedimento urinario de este paciente?

A) Cilindros hialinos transparentes.

B) Cilindros hemáticos y eritrocitos dismórficos.

C) Cilindros granulosos pigmentados (color marrón o "fango"). *

D) Cilindros leucocitarios y eosinófilos.

Retroalimentación Pregunta 2:

El hallazgo clásico y patognomónico de la Necrosis Tubular Aguda en el sedimento urinario es la presencia de cilindros granulosos pigmentados gruensos, comúnmente descritos como cilindros "marrón lodo" o "fango" (muddy brown casts). Estos se forman por la descamación de las células tubulares necróticas hacia la luz del túbulo.

Especialidad: Neurología

Tema: Epilepsia (Neurología)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 18 años de edad es traída al servicio de urgencias por sus compañeros de universidad. Refieren que, mientras estaba sentada en clase, la paciente emitió un grito ahogado, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Inmediatamente presentó rigidez generalizada seguida de movimientos de sacudida rítmica en las cuatro extremidades. El episodio duró aproximadamente 2 minutos y se acompañó de relajación de esfínter vesical y mordedura del borde lateral de la lengua. A su llegada a urgencias, la paciente se encuentra confusa, somnolienta y con dolor muscular generalizado.

Pregunta 1

De acuerdo con la semiología del evento, ¿cuál es la clasificación clínica de esta crisis convulsiva?

A) Crisis de ausencia atípica.

B) Crisis focal con alteración de la consciencia (parcial compleja).

C) Crisis focal que evoluciona a bilateral (secundariamente generalizada).

D) Crisis de inicio generalizado motor (tónico-clónica). *

Retroalimentación Pregunta 1:

El cuadro clínico describe la crisis convulsiva clásica por excelencia: la crisis tónico-clónica generalizada (antes llamada "gran mal"). El inicio abrupto con pérdida de consciencia, la fase de rigidez (tónica) seguida de sacudidas rítmicas (clónica), las lesiones asociadas (mordedura lateral de la lengua, pérdida de esfínteres) y el estado postictal de confusión y somnolencia son los pilares diagnósticos.

Pregunta 2

Si el electroencefalograma posterior confirma un patrón de descargas generalizadas y se diagnostica epilepsia, ¿cuál de los siguientes fármacos antiepilépticos es considerado de primera línea por su amplio espectro para este tipo de crisis en una mujer en edad fértil, tomando en cuenta la teratogenicidad?

A) Levetiracetam o Lamotrigina. *

B) Ácido Valproico (Valproato de magnesio) a dosis altas.

C) Fenitoína intravenosa en bolos.

D) Etosuximida oral continua.

Retroalimentación Pregunta 2:

El Ácido Valproico es un excelente fármaco de amplio espectro, pero es altamente teratogénico (defectos del tubo neural) y causa alteraciones metabólicas, por lo que actualmente se evita como primera línea en mujeres en edad reproductiva. En su lugar, el Levetiracetam o la Lamotrigina son los fármacos de primera elección debido a su perfil de seguridad mucho más favorable en caso de embarazo, manteniendo una alta eficacia para crisis generalizadas.

Especialidad: Endocrinología

Tema: Criterios diagnósticos (Diabetes Mellitus)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 48 años, con un índice de masa corporal de 31 (obesidad grado I), acude a su clínica de medicina familiar para un chequeo anual de rutina solicitado por su empresa. El paciente se encuentra completamente asintomático (niega poliuria, polidipsia o pérdida de peso). Se le realiza una química sanguínea que reporta una glucosa plasmática en ayuno de 138 mg/dL.

Pregunta 1

Según los criterios actuales de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico estrictamente necesario para confirmar o descartar el diagnóstico de Diabetes Mellitus en este paciente asintomático?

A) Iniciar inmediatamente tratamiento con Metformina, ya que un solo valor >126 mg/dL hace el diagnóstico.

B) Repetir la medición de glucosa en ayuno en una segunda muestra diferente o solicitar una Hemoglobina Glucosilada (HbA1c). *

C) Solicitar un péptido C y anticuerpos anti-GAD para descartar diabetes tipo 1.

D) Indicar dieta estricta por 3 meses y volver a medir la glucosa capilar.

Retroalimentación Pregunta 1:

Para diagnosticar Diabetes Mellitus en un paciente asintomático, la ADA requiere que un resultado anormal (Glucosa en ayuno $\ge$ 126 mg/dL, HbA1c $\ge$ 6.5%, o Glucosa a las 2 horas $\ge$ 200 mg/dL en curva de tolerancia) sea confirmado por una segunda prueba alterada en una muestra de sangre distinta (o realizar dos pruebas diferentes en la misma muestra). Un solo valor en ausencia de síntomas clásicos (las "4 P") o crisis hiperglucémica no es diagnóstico.

Pregunta 2

Si en la segunda visita la HbA1c resulta en 7.2% confirmando el diagnóstico, y el paciente no tiene contraindicaciones, ¿cuál es el tratamiento farmacológico inicial de primera línea junto con las modificaciones al estilo de vida?

A) Insulina glargina (basal) a 10 unidades diarias.

B) Inhibidor del SGLT2 (ej. Empagliflozina) en monoterapia.

C) Biguanida (Metformina) oral. *

D) Sulfonilurea (Glibenclamida) oral.

Retroalimentación Pregunta 2:

La Metformina sigue siendo el tratamiento farmacológico inicial universal de primera elección para el manejo de la Diabetes Mellitus tipo 2 recién diagnosticada, siempre y cuando no existan contraindicaciones (como tasa de filtración glomerular <30 ml/min o falla hepática severa). Actúa disminuyendo la producción hepática de glucosa y mejorando la sensibilidad a la insulina sin causar hipoglucemia.

Especialidad: Pediatría

Tema: Atresia de vías biliares (Gastroenterología Pediátrica)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Lactante femenino de 4 semanas de vida es traída a la consulta pediátrica porque los padres notan que "sigue amarilla". La niña nació de término sin complicaciones, fue dada de alta al segundo día con lactancia materna exclusiva. A la exploración física, presenta ictericia generalizada (Kramer IV), el abdomen está discretamente globoso y se palpa el borde hepático 3 cm por debajo del reborde costal, de consistencia firme. En el interrogatorio dirigido, la madre menciona que los pañales de orina son muy oscuros (coluria) y las heces son "como masilla blanca" (acolia).

Pregunta 1

Ante la presencia de ictericia prolongada, coluria y acolia en el primer mes de vida, ¿cuál es el diagnóstico que se debe descartar obligatoriamente por su gravedad y naturaleza progresiva?

A) Ictericia por leche materna.

B) Isoinmunización a grupo ABO.

C) Atresia de vías biliares extrahepáticas. *

D) Hipotiroidismo congénito.

Retroalimentación Pregunta 1:

La atresia de vías biliares es la causa más común de ictericia neonatal colestásica (por elevación de bilirrubina directa o conjugada) que requiere intervención quirúrgica. El cuadro clínico clásico es un lactante que aparenta estar sano las primeras dos semanas, pero desarrolla ictericia progresiva, hepatomegalia firme, orina oscura (coluria) y deposiciones descoloridas (acolia o hipocolia) debido a la obstrucción total del flujo biliar hacia el intestino.

Pregunta 2

Una vez confirmado el diagnóstico mediante colangiografía intraoperatoria (estándar de oro), ¿cuál es el procedimiento quirúrgico de elección que debe realizarse idealmente antes de los 60 días de vida para restablecer el flujo biliar y retrasar el daño hepático?

A) Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS).

B) Colecistectomía laparoscópica temprana con exploración de vías biliares.

C) Trasplante hepático ortotópico inmediato como primera y única opción.

D) Hepatoportoenterostomía (Procedimiento de Kasai). *

Retroalimentación Pregunta 2:

El tratamiento de elección inicial para la atresia de vías biliares es la hepatoportoenterostomía de Kasai, la cual consiste en resecar la vía biliar atrésica y unir un asa de yeyuno (en Y de Roux) directamente al hilio hepático para permitir el drenaje de la bilis microscópica. El pronóstico mejora significativamente si la cirugía se realiza antes de las 8 semanas de vida; si se retrasa, la cirrosis biliar es irreversible y el trasplante hepático se vuelve la única alternativa a corto plazo.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: SÍNDROME HELLP
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Primigesta de 35 semanas de gestación acude por cefalea intensa, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, náusea y malestar general. A la exploración tiene TA de 160/105 mmHg y edema en extremidades inferiores. Los laboratorios reportan plaquetas bajas, elevación de transaminasas y datos de hemólisis.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Síndrome HELLP *
B) Colestasis intrahepática del embarazo.
C) Hígado graso agudo del embarazo.
D) Gastritis aguda.

Retroalimentación:
El síndrome HELLP se caracteriza por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, generalmente en el contexto de preeclampsia. El dolor en epigastrio o hipocondrio derecho es un dato clínico importante.

Pregunta 2
¿Qué significa la sigla HELLP?
A) Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia *
B) Hemorragia, edema, leucocitosis, linfopenia y proteinuria.
C) Hipertensión, edema, lesión hepática, leucopenia y plaquetopenia.
D) Hemólisis, edema, leucocituria, lipemia y proteinuria.

Retroalimentación:
La sigla HELLP deriva del inglés: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Es una variante severa de enfermedad hipertensiva del embarazo con riesgo materno-fetal elevado.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: VAGINOSIS BACTERIANA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Mujer de 28 años consulta por flujo vaginal homogéneo grisáceo y mal olor que incrementa después de las relaciones sexuales. Niega prurito intenso y disuria. A la exploración no hay eritema vulvar importante.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Vaginosis bacteriana *
B) Candidiasis vulvovaginal.
C) Tricomoniasis.
D) Herpes genital.

Retroalimentación:
La vaginosis bacteriana suele manifestarse con flujo homogéneo grisáceo y olor a pescado, con mínima inflamación local. El prurito intenso suele ser más típico de candidiasis.

Pregunta 2
¿Cuál es el principal desequilibrio microbiológico en esta entidad?
A) Disminución de lactobacilos con sobrecrecimiento de anaerobios *
B) Invasión por hongos filamentosos.
C) Infección gonocócica ascendente.
D) Reactivación de virus latente en ganglios sacros.

Retroalimentación:
La vaginosis bacteriana no es una infección inflamatoria clásica, sino una alteración del ecosistema vaginal con reducción de lactobacilos y proliferación de microorganismos anaerobios como Gardnerella vaginalis.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: MASTITIS PUERPERAL
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 25 años en la segunda semana del puerperio presenta dolor en mama

izquierda, enrojecimiento localizado, fiebre y malestar general. Refiere lactancia materna y grietas en el pezón.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Mastitis puerperal *
B) Galactocele.
C) Cáncer inflamatorio de mama.
D) Fibroadenoma mamario.

Retroalimentación:
La mastitis puerperal suele presentarse con dolor, eritema localizado, fiebre y síntomas sistémicos en mujeres lactando, especialmente si hay grietas del pezón.

Pregunta 2
¿Cuál es el agente etiológico más frecuente?
A) Staphylococcus aureus *
B) Escherichia coli.
C) Candida tropicalis.
D) Virus del herpes simple.

Retroalimentación:
Staphylococcus aureus es uno de los principales agentes causales de mastitis puerperal, favorecido por la entrada bacteriana a través de lesiones del pezón.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: VARICELA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Niño de 5 años presenta fiebre baja y exantema pruriginoso generalizado. A la exploración se observan lesiones en diferentes etapas evolutivas: máculas, pápulas, vesículas y costras.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Varicela *
B) Sarampión.
C) Rubéola.
D) Escarlatina.

Retroalimentación:
La coexistencia de lesiones en distintas etapas de evolución es muy característica de varicela. El prurito suele ser intenso y la distribución es generalizada.

Pregunta 2
¿Cuál es el agente etiológico causal?
A) Virus varicela-zóster *
B) Virus sincitial respiratorio.
C) Parvovirus B19.
D) Rotavirus.

Retroalimentación:
La varicela es causada por el virus varicela-zóster, un herpesvirus que posteriormente puede permanecer latente y reactivarse como herpes zóster.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: LARINGOMALACIA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Lactante de 2 meses presenta estridor inspiratorio desde las primeras semanas de vida, más evidente al alimentarse o cuando está en decúbito. Se alimenta adecuadamente y gana peso. No presenta fiebre ni aspecto tóxico.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Laringomalacia *
B) Epiglotitis.
C) Aspiración de cuerpo extraño.
D) Bronquiolitis.

Retroalimentación:
La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor crónico en lactantes y suele empeorar con el llanto, la alimentación o el decúbito.

Pregunta 2
¿Cuál es la evolución más frecuente de este padecimiento?
A) Resolución espontánea con el crecimiento *
B) Progresión obligatoria a insuficiencia respiratoria severa.

C) Requiere traqueostomía en todos los casos.
D) Evoluciona siempre a asma.

Retroalimentación:
La mayoría de los casos de laringomalacia son leves y mejoran espontáneamente con la maduración de la vía aérea, aunque algunos requieren valoración especializada si hay mala ganancia ponderal o dificultad respiratoria.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: INVASIÓN POR OXIUROSIS
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Escolar de 7 años presenta prurito anal de predominio nocturno, irritabilidad y alteración del sueño. La madre refiere que en ocasiones ha observado pequeños "gusanos blancos" en la región perianal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Enterobiasis *
B) Ascariasis.
C) Teniasis.
D) Giardiasis.

Retroalimentación:
El prurito anal nocturno es el dato clásico de enterobiasis por Enterobius vermicularis, especialmente en escolares.

Pregunta 2
¿Cuál es el método diagnóstico sencillo y útil en este caso?
A) Prueba de Graham *
B) Coprocultivo.
C) Radiografía de abdomen.
D) Niveles séricos de IgE específica.

Retroalimentación:
La prueba de Graham o cinta adhesiva perianal permite identificar huevos del parásito y es especialmente útil porque estos no siempre aparecen en el coproparasitoscópico rutinario.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: TIROIDITIS / BOCIO TÓXICO VS NÓDULO TIROIDEO QUIRÚRGICO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 44 años consulta por aumento de volumen en cuello de crecimiento progresivo. A la exploración se palpa nódulo tiroideo único, firme, de 2.5 cm, que se moviliza con la deglución. Niega dolor local y fiebre.

Pregunta 1
¿Cuál es el siguiente estudio inicial más útil para estratificar la lesión?
A) Ultrasonido tiroideo *
B) Colonoscopia.
C) Radiografía de pelvis.
D) Espirometría.

Retroalimentación:
Ante un nódulo tiroideo palpable, el ultrasonido es fundamental para valorar tamaño, características de sospecha y guiar decisiones posteriores como biopsia por aspiración.

Pregunta 2
¿Qué característica clínica incrementa la sospecha de malignidad en un nódulo tiroideo?
A) Consistencia firme y crecimiento progresivo *
B) Dolor intenso con fiebre.
C) Disminución del tamaño con la deglución.
D) Asociación con diarrea aguda.

Retroalimentación:
Los nódulos firmes, de crecimiento progresivo, adheridos o acompañados de adenopatías cervicales generan mayor sospecha de malignidad que lesiones blandas o claramente inflamatorias.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: ISQUEMIA AGUDA DE EXTREMIDAD
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Varón de 69 años con antecedente de fibrilación auricular presenta inicio súbito de

dolor intenso en pierna izquierda. A la exploración la extremidad está pálida, fría, con ausencia de pulsos distales y parestesias.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Isquemia aguda de extremidad *
B) Tromboflebitis superficial.
C) Celulitis.
D) Insuficiencia venosa crónica.

Retroalimentación:
El inicio súbito con dolor, palidez, frialdad, ausencia de pulso y síntomas neurológicos corresponde al cuadro clásico de isquemia arterial aguda.

Pregunta 2
¿Cuál es el mecanismo más probable en este paciente?
A) Émbolo arterial de origen cardiaco *
B) Sobreinfección cutánea local.
C) Vasculitis por hipersensibilidad.
D) Compresión por hernia inguinal.

Retroalimentación:
La fibrilación auricular es un factor de riesgo importante para formación de trombos intracardiacos que pueden embolizar a arterias periféricas.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: HIPOGLUCEMIA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 58 años con diabetes mellitus en tratamiento farmacológico presenta sudoración, temblor, palpitaciones y confusión. La glucosa capilar al momento de la valoración es de 48 mg/dL.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Hipoglucemia *
B) Crisis hipertensiva.
C) Cetoacidosis diabética.
D) Accidente isquémico transitorio.

Retroalimentación:
Los síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos junto con glucosa capilar baja son compatibles con hipoglucemia.

Pregunta 2
¿Cuál es una manifestación neuroglucopénica típica?
A) Confusión *
B) Midriasis fija.
C) Hemoptisis.
D) Ictericia.

Retroalimentación:
Las manifestaciones neuroglucopénicas ocurren por falta de glucosa cerebral e incluyen confusión, somnolencia, alteraciones visuales, convulsiones y coma.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: HIPONATREMIA SINTOMÁTICA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Mujer de 72 años llega por cefalea, náusea, letargia y un episodio convulsivo. En laboratorio se documenta sodio sérico de 118 mEq/L. No hay hiperglucemia ni datos de hipernatremia previa.

Pregunta 1
¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico más probable?
A) Hiponatremia sintomática *
B) Hipernatremia.
C) Hipercalcemia.
D) Hipomagnesemia aislada.

Retroalimentación:
Un sodio sérico marcadamente bajo con síntomas neurológicos como letargia o convulsiones es compatible con hiponatremia sintomática.

Pregunta 2
¿Cuál es la principal razón del compromiso neurológico en este trastorno?
A) Edema cerebral *
B) Hemorragia meníngea obligatoria.

C) Vasoespasmo coronario.
D) Hipersecreción pancreática.

Retroalimentación:
La disminución de osmolaridad extracelular favorece el paso de agua al interior de las células cerebrales, causando edema cerebral y síntomas neurológicos.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 26 años presenta artralgias, fotosensibilidad, fatiga y exantema malar que respeta los surcos nasolabiales. Refiere episodios de úlceras orales no dolorosas.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Lupus eritematoso sistémico *
B) Dermatitis seborreica.
C) Rosácea.
D) Psoriasis guttata.

Retroalimentación:
El exantema malar fotosensible, las artralgias y las úlceras orales son hallazgos clásicos de lupus eritematoso sistémico.

Pregunta 2
¿Cuál es una manifestación hematológica o renal que debe buscarse en esta enfermedad?
A) Proteinuria *
B) Neumotórax espontáneo.
C) Otitis media recurrente.
D) Acalasia.

Retroalimentación:
El lupus puede afectar múltiples órganos, incluido el riñón, por lo que la búsqueda de proteinuria o sedimento urinario anormal es fundamental para detectar nefritis lúpica.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: INTOXICACIÓN POR OPIOIDES
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 33 años es encontrado somnoliento, con respiración lenta y superficial. A la exploración presenta miosis puntiforme y disminución del estado de alerta. Los acompañantes refieren probable consumo de heroína.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico toxicológico más probable?
A) Intoxicación por opioides *
B) Intoxicación por cocaína.
C) Intoxicación por salicilatos.
D) Síndrome serotoninérgico.

Retroalimentación:
La tríada de depresión del estado de conciencia, depresión respiratoria y miosis es altamente sugestiva de intoxicación por opioides.

Pregunta 2
¿Cuál es el antídoto específico?
A) Naloxona *
B) Flumazenil.
C) Atropina.
D) N-acetilcisteína.

Retroalimentación:
La naloxona antagoniza los receptores opioides y revierte rápidamente la depresión respiratoria, por lo que es el antídoto de elección.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragia posparto (Hemorragias del Puerperio)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Mujer de 28 años, primigesta, con embarazo a término. Tuvo un trabajo de parto prolongado que culminó en un parto vaginal instrumentado con fórceps de un producto macrosómico de 4,300 g. A los 20 minutos del alumbramiento, la paciente

presenta sangrado transvaginal rojo rutilante, continuo y abundante (estimado en 1,200 ml). A la exploración física, la paciente presenta taquicardia (115 lpm) y el fondo uterino se palpa supraumbilical, blando y sin tono ("útero de Couvelaire" o flácido).

Pregunta 1

Ante la presentación clínica y los factores de riesgo (macrosomía, parto prolongado), ¿cuál es la causa más probable de esta hemorragia obstétrica (las "4 T")?

A) Trauma (laceraciones del canal de parto).

B) Tejido (retención de restos placentarios).

C) Trombina (alteraciones de la coagulación).

D) Tono (atonía uterina). *

Retroalimentación Pregunta 1:

La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto, representando hasta el 80% de los casos. Sus factores de riesgo incluyen la sobredistensión uterina (macrosomía, polihidramnios, embarazo múltiple), el agotamiento muscular (parto prolongado) y la corioamnionitis. Clásicamente, el útero se palpa blando, flácido y por encima de la cicatriz umbilical.

Pregunta 2

Si la paciente tuviera el antecedente de preeclampsia con criterios de severidad durante el embarazo, ¿cuál de los siguientes fármacos uterotónicos de segunda línea estaría estrictamente contraindicado para el manejo de esta hemorragia?

A) Oxitocina intravenosa.

B) Misoprostol intrarrectal.

C) Ergonovina o Metilergonovina intramuscular. *

D) Carbetocina intravenosa.

Retroalimentación Pregunta 2:

La Ergonovina (y la metilergonovina) son alcaloides del cornezuelo del centeno que producen una contracción uterina tetánica sostenida. Sin embargo, tienen un potente efecto vasoconstrictor periférico, por lo que están absolutamente contraindicados en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia/eclampsia) debido al riesgo de precipitar una crisis hipertensiva severa o un evento vascular cerebral.

Especialidad: Pediatría

Tema: Invaginación intestinal (Gastroenterología Pediátrica)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante masculino de 8 meses de edad, previamente sano. Inicia de manera súbita con episodios de llanto intenso, palidez y encogimiento de las piernas hacia el abdomen, que duran unos minutos y se alternan con periodos de letargo donde el niño luce normal. Posteriormente presenta vómitos de contenido gástrico y una evacuación con aspecto de "jalea de grosella". A la palpación abdominal, se percibe una masa de forma alargada ("en salchicha") en el cuadrante superior derecho.

Pregunta 1

De acuerdo con la tríada clásica descrita, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este lactante?

A) Divertículo de Meckel complicado.

B) Estenosis hipertrófica del píloro.

C) Invaginación intestinal (Intususcepción). *

D) Vólvulo de intestino medio.

Retroalimentación Pregunta 1:

La invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños entre 3 meses y 3 años de edad. Se caracteriza por la introducción de un segmento de intestino dentro de otro adyacente (usualmente íleon terminal dentro del ciego). La tríada clásica, aunque no siempre presente al mismo tiempo, incluye: dolor abdominal cólico intermitente, heces sanguinolentas con moco (jalea de grosella) y una masa abdominal palpable (en forma de morcilla o salchicha).

Pregunta 2

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y sin datos de perforación ni peritonitis, ¿cuál es el estudio inicial que sirve tanto para confirmar el diagnóstico como para realizar el tratamiento de primera línea?

A) Tomografía computarizada de abdomen contrastada.

B) Laparoscopia diagnóstica y terapéutica inmediata.

C) Radiografía simple de abdomen con contraste oral.

D) Ultrasonido abdominal seguido de reducción con enema neumático o hidrostático. *

Retroalimentación Pregunta 2:

El ultrasonido es el estudio de imagen de elección, mostrando las clásicas imágenes en "diana" o "pseudoriñón". Si se confirma el diagnóstico y no hay contraindicaciones (como choque o perforación), el tratamiento no quirúrgico inicial de elección es la reducción guiada por imagen (fluoroscopia o ecografía) utilizando un enema neumático (aire) o hidrostático (solución salina o bario), el cual tiene una alta tasa de éxito.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocarditis Infecciosa (Infectología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 32 años de edad, con antecedente de uso de drogas intravenosas desde hace 5 años. Acude a urgencias por presentar picos febriles de hasta 39.5°C, escalofríos intensos y disnea de 1 semana de evolución. A la exploración física, destaca la presencia de un soplo holosistólico en el foco tricuspídeo que aumenta con la inspiración (signo de Carvallo). Se observan máculas eritematosas no dolorosas en las palmas de las manos (lesiones de Janeway) y nódulos violáceos dolorosos en los pulpejos de los dedos (Nódulos de Osler).

Pregunta 1

En el contexto de un usuario de drogas intravenosas con sospecha de endocarditis, ¿cuál es la válvula cardiaca más frecuentemente afectada y el agente etiológico aislado con mayor probabilidad?

A) Válvula mitral; Streptococcus viridans.

B) Válvula aórtica; Enterococcus faecalis.

C) Válvula tricúspide; Staphylococcus aureus. *

D) Válvula pulmonar; Pseudomonas aeruginosa.

Retroalimentación Pregunta 1:

Los usuarios de drogas intravenosas tienen un riesgo elevadísimo de desarrollar endocarditis infecciosa en las cavidades derechas del corazón (especialmente la válvula tricúspide), ya que las bacterias ingresan directamente al torrente venoso. El patógeno más comúnmente implicado en esta población, por su virulencia y capacidad de colonizar la piel, es el *Staphylococcus aureus* (con una alta incidencia de cepas resistentes a meticilina, MRSA).

Pregunta 2

Para establecer el diagnóstico definitivo de esta patología, ¿cuáles son los dos Criterios Mayores de la clasificación de Duke modificada?

A) Hemocultivos positivos (para microorganismos típicos) y evidencia de afección endocárdica por ecocardiograma (vegetaciones o abscesos). *

B) Fiebre > 38°C y presencia de fenómenos inmunológicos (como los Nódulos de Osler).

C) Fenómenos vasculares (como las lesiones de Janeway) y antecedente de uso de drogas.

D) Elevación de reactantes de fase aguda (PCR y VSG) y nuevo soplo cardiaco.

Retroalimentación Pregunta 2:

Los Criterios de Duke modificados son el estándar para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Los dos criterios mayores son la demostración de la infección en la sangre (hemocultivos positivos tomados de forma seriada antes de iniciar antibióticos) y la demostración del daño o vegetación en las válvulas mediante imagen (idealmente un ecocardiograma transesofágico).

Especialidad: Cirugía

Tema: Fx de escafoides (Patología de Extremidad Superior)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 24 años acude a urgencias refiriendo dolor en la muñeca derecha tras sufrir una caída mientras patinaba, apoyando la mano en hiperextensión. A la exploración física, no se observan deformidades evidentes, pero presenta dolor exquisito a la palpación profunda en la "tabaquera anatómica" (delimitada por los tendones del extensor largo, extensor corto y abductor largo del pulgar). La radiografía

inicial en proyecciones anteroposterior y lateral no muestra trazos de fractura evidentes.

Pregunta 1

A pesar de la radiografía inicial aparentemente normal, ante el mecanismo de lesión y el dolor en la tabaquera anatómica, ¿cuál es el diagnóstico clínico presuntivo que debe tratarse obligatoriamente hasta demostrar lo contrario?

A) Fractura de Colles del radio distal.

B) Luxación perilunar del carpo.

C) Esguince del ligamento escafolunar.

D) Fractura del hueso escafoides. *

Retroalimentación Pregunta 1:

El escafoides es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. El mecanismo clásico es la caída sobre la mano hiperextendida. El dolor selectivo en la tabaquera anatómica es el signo clínico pivote. Dado que hasta un 15-20% de estas fracturas no son visibles en las radiografías iniciales tomadas el día del trauma, la regla de oro indica que toda sospecha clínica debe inmovilizarse y tratarse como fractura de escafoides y reevaluarse con nuevas imágenes en 10-14 días.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación más temida de las fracturas del tercio proximal del escafoides debido a la peculiaridad de su irrigación sanguínea?

A) Síndrome del túnel del carpo agudo.

B) Necrosis avascular del polo proximal (pseudoartrosis). *

C) Artrosis radiocarpiana temprana aislada.

D) Rotura espontánea del tendón del extensor largo del pulgar.

Retroalimentación Pregunta 2:

La irrigación del escafoides es retrógrada: las arterias entran por su polo distal y viajan hacia el polo proximal. Por lo tanto, una fractura en el tercio medio o proximal interrumpe el suministro de sangre al fragmento proximal, predisponiéndolo gravemente a la isquemia, el desarrollo de necrosis avascular y la falta de consolidación ósea (pseudoartrosis).

Especialidad: Cirugía

Tema: Trauma craneoencefálico (ATLS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 30 años es llevado a la sala de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico frontal a alta velocidad sin portar cinturón de seguridad. A su llegada, el paciente no abre los ojos espontáneamente, lo hace solo ante el estímulo doloroso. Emite sonidos incomprensibles y, al aplicar presión en el lecho ungueal, presenta una respuesta motora de flexión anormal (postura de decorticación). A la exploración pupilar, la pupila derecha se encuentra dilatada (anisocoria) y con respuesta a la luz perezosa.

Pregunta 1

De acuerdo con la evaluación neurológica inicial, ¿cuál es la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (ECG) y cómo se clasifica la severidad de este trauma craneoencefálico?

A) ECG 9; TCE Moderado.

B) ECG 8; TCE Severo.

C) ECG 7; TCE Severo. *

D) ECG 6; TCE Severo.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Escala de Coma de Glasgow se calcula así: Apertura ocular al dolor = 2 puntos. Respuesta verbal con sonidos incomprensibles = 2 puntos. Respuesta motora con

flexión anormal (decorticación) = 3 puntos. Total: 7 puntos. Todo paciente con un Glasgow menor o igual a 8 se clasifica como TCE severo y tiene indicación absoluta de intubación endotraqueal inmediata para protección de la vía aérea.

Pregunta 2

Si la Tomografía Axial Computarizada (TAC) simple de cráneo revela una colección hemática hiperdensa con forma de lente biconvexo en la región temporal derecha, ¿cuál es el vaso sanguíneo que con mayor frecuencia se encuentra lesionado en esta patología?

A) Arteria meníngea media. *

B) Venas puente subdurales.

C) Arteria cerebral media.

D) Seno sagital superior.

Retroalimentación Pregunta 2:

El hematoma epidural clásico tiene forma de lente biconvexo (no cruza las suturas craneales) y se origina en el 85% de los casos por la ruptura arterial, siendo la arteria meníngea media (a su paso por el pterion en el hueso temporal) la estructura más frecuentemente desgarrada. Es una urgencia neuroquirúrgica que requiere evacuación inmediata (craneotomía) ante los signos de herniación uncal (anisocoria).

Especialidad: Pediatría

Tema: Enfermedad diarreica aguda (Gastroenterología Pediátrica)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Lactante masculino de 14 meses de edad es traído a consulta por presentar desde hace 48 horas evacuaciones líquidas abundantes (más de 8 en el último día), sin moco ni sangre, acompañadas de vómitos de contenido gástrico y fiebre de 38.0°C. A la exploración física, el niño se observa irritable, con los ojos hundidos, llanto sin lágrimas y mucosas orales secas. Al pellizcar la piel del abdomen (signo del pliegue), esta regresa a su estado normal en aproximadamente 1.5 segundos.

Pregunta 1

De acuerdo con las características clínicas y epidemiológicas, ¿cuál es el agente etiológico viral más frecuentemente asociado a episodios graves de esta enfermedad en lactantes a nivel mundial?

A) Adenovirus entérico.

B) Astrovirus.

C) Norovirus.

D) Rotavirus. *

Retroalimentación Pregunta 1:

El Rotavirus es la causa viral número uno de gastroenteritis aguda grave y deshidratación en lactantes y niños pequeños en todo el mundo (especialmente en época invernal o en pacientes sin esquema de vacunación completo). Se caracteriza por diarrea acuosa, vómitos y fiebre, sin leucocitos ni sangre en heces (a diferencia de las bacterianas invasivas).

Pregunta 2

Según la evaluación clínica del estado de hidratación (niño irritable, mucosas secas, signo del pliegue positivo pero < 2 segundos), ¿qué plan de hidratación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está indicado para este paciente?

A) Plan A (hidratación en el hogar con líquidos a libre demanda).

B) Plan B (Vida Suero Oral 100 ml/kg administrados en 4 horas en la unidad de salud). *

C) Plan C (Solución Hartmann intravenosa rápida).

D) Ayuno absoluto y administración de loperamida.

Retroalimentación Pregunta 2:

El paciente presenta datos francos de deshidratación clínica moderada (irritabilidad, ojos hundidos, sin lágrimas, mucosas secas, signo del pliegue presente pero no >2 segundos). Esto es indicación directa para el Plan B de la OMS: Terapia de Rehidratación Oral (TRO) en la unidad médica, administrando Vida Suero Oral a una dosis de 100 ml/kg fraccionados en un periodo de 4 horas, con revaluación continua.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Tuberculosis (Infectología)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Hombre de 45 años con antecedente de infección por VIH diagnosticada hace 5 años, actualmente sin tratamiento antirretroviral. Acude por presentar tos crónica productiva de 6 semanas de evolución, la cual se ha vuelto hemoptoica en los últimos días. Refiere fiebre vespertina constante, sudoración nocturna profusa (diaforesis) y una pérdida de peso involuntaria de 8 kg. En la radiografía posteroanterior de tórax se observa una imagen cavitada en el segmento apical del lóbulo superior derecho.

Pregunta 1

Ante la alta sospecha de Tuberculosis Pulmonar activa, ¿cuál es el estudio diagnóstico inicial de escrutinio obligatorio que debe solicitarse según la Norma Oficial Mexicana (NOM-006)?

A) Cultivo en medio de Löwenstein-Jensen.

B) Prueba de la tuberculina (PPD).

C) Baciloscopia seriada en esputo (mínimo 3 muestras). *

D) Tomografía de tórax de alta resolución.

Retroalimentación Pregunta 1:

En todo paciente sintomático respiratorio (tos con expectoración por más de 14 días), el estudio inicial de elección para confirmar la presencia de Micobacterias es la baciloscopia en esputo (tinción de Ziehl-Neelsen), la cual es rápida y económica. El cultivo (Löwenstein-Jensen o MGIT) es el estándar de oro y se solicita paralelamente en pacientes con VIH, pero los resultados tardan semanas, por lo que la baciloscopia guía el inicio del tratamiento empírico.

Pregunta 2

Se inicia tratamiento con el esquema primario estrictamente supervisado (TAES) de primera línea (Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol). Durante su seguimiento al primer mes, el paciente reporta disminución progresiva de la agudeza visual y dificultad para distinguir los colores rojo y verde. ¿A qué fármaco antituberculoso se le atribuye este efecto adverso específico?

A) Isoniazida.

B) Etambutol. *

C) Rifampicina.

D) Pirazinamida.

Retroalimentación Pregunta 2:

La neuritis óptica (que se manifiesta clínicamente como disminución de la agudeza visual y discromatopsia, especialmente ceguera a los colores rojo-verde) es el efecto adverso clásico y más temido del Etambutol. La Isoniazida causa neuropatía periférica (prevenible con piridoxina B6), la Rifampicina tiñe las secreciones corporales de color naranja y la Pirazinamida es el fármaco más hepatotóxico e hiperuricemiante del esquema.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Infecciones TORCH (Control Prenatal)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 24 años, cursando embarazo de 20 semanas de gestación, acude a su primera consulta de control prenatal. Refiere ser alérgica a la penicilina (presentó un exantema generalizado a los 5 años de edad tras su administración). Como parte de su batería de estudios inicial, se le realiza una prueba no treponémica (VDRL), la cual reporta un resultado reactivo con un título de 1:32. La paciente no presenta lesiones ulcerosas, exantemas ni adenopatías en la exploración física actual (sífilis latente).

Pregunta 1

Dado que la prueba VDRL es de escrutinio (alta sensibilidad pero menor especificidad), ¿cuál es el paso diagnóstico indispensable para confirmar la infección por Treponema pallidum y descartar un falso positivo biológico del embarazo?

A) Repetir el VDRL en el tercer trimestre.

B) Solicitar una prueba treponémica confirmatoria (ej. FTA-ABS o TP-PA). *

C) Realizar una biopsia de cérvix.

D) Solicitar prueba de ELISA para VIH.

Retroalimentación Pregunta 1:

Las pruebas no treponémicas (VDRL o RPR) miden anticuerpos contra los lípidos liberados de las células dañadas, por lo que pueden arrojar falsos positivos en el embarazo, enfermedades autoinmunes o infecciones virales. Un VDRL reactivo

SIEMPRE debe confirmarse con una prueba treponémica específica (FTA-ABS, MHA-TP o TP-PA) que detecta directamente los anticuerpos contra la bacteria.

Pregunta 2

Una vez confirmada la infección mediante FTA-ABS, y considerando su antecedente de alergia severa a la penicilina reportado en la infancia, ¿cuál es el abordaje terapéutico indicado por la OMS y la GPC para prevenir la sífilis congénita en esta paciente embarazada?

A) Doxiciclina oral por 14 días (como alternativa por la alergia).

B) Eritromicina oral por 14 días.

C) Desensibilización hospitalaria a la penicilina y posterior tratamiento con Penicilina G Benzatínica. *

D) Ceftriaxona intramuscular dosis única.

Retroalimentación Pregunta 2:

La Penicilina G es el ÚNICO antibiótico con eficacia probada y documentada para cruzar la placenta en concentraciones adecuadas y prevenir o tratar la sífilis congénita de manera altamente efectiva (el Treponema pallidum no ha desarrollado resistencia). Por ello, en mujeres embarazadas con alergia documentada a la penicilina, las alternativas (como macrólidos) no son aceptables por su alta tasa de fracaso fetal; es imperativo realizar una desensibilización oral o intravenosa y administrar la penicilina.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: CORIOAMNIONITIS
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Paciente de 26 años con 33 semanas de gestación, cursando ruptura prematura de membranas desde hace 30 horas. Acude por fiebre, malestar general y dolor uterino. A la exploración presenta taquicardia materna, taquicardia fetal y líquido amniótico de mal olor.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Corioamnionitis *
B) Placenta previa.
C) Embarazo ectópico.
D) Preeclampsia sin datos de severidad.

Retroalimentación:
La fiebre materna, el dolor uterino, la taquicardia materna y fetal, junto con líquido amniótico fétido, orientan a infección intraamniótica o corioamnionitis, especialmente en el contexto de ruptura prolongada de membranas.

Pregunta 2
¿Cuál es el principal factor predisponente en este caso?
A) Ruptura prolongada de membranas *
B) Embarazo múltiple.
C) Primigesta.
D) Edad materna menor de 20 años.

Retroalimentación:
La ruptura de membranas durante tiempo prolongado favorece la ascensión bacteriana desde el tracto genital inferior hacia las membranas y la cavidad amniótica, aumentando el riesgo de corioamnionitis.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: INSUFICIENCIA CERVICAL
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 30 años con antecedente de dos pérdidas gestacionales del segundo trimestre, ambas precedidas por sensación de presión pélvica y expulsión fetal casi sin dolor. En el embarazo actual se encuentra asintomática a las 15 semanas.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Insuficiencia cervical *
B) Amenaza de aborto.
C) Embarazo molar.
D) Miomatosis uterina.

Retroalimentación:
La historia de pérdidas gestacionales recurrentes en el segundo trimestre, con

dilatación cervical indolora y expulsión fetal sin trabajo de parto franco, es sugestiva de insuficiencia cervical.

Pregunta 2
¿Cuál es una medida terapéutica que puede considerarse en pacientes seleccionadas?
A) Cerclaje cervical *
B) Histerectomía total.
C) Salpingoclasia.
D) Únicamente analgésicos.

Retroalimentación:
En pacientes con antecedente compatible y criterios adecuados, el cerclaje cervical puede ayudar a disminuir el riesgo de nuevas pérdidas gestacionales por incompetencia cervical.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Subtema: ENDOMETRITIS PUERPERAL
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 27 años, tres días posterior a cesárea, presenta fiebre, dolor hipogástrico y loquios fétidos. A la exploración tiene subinvolución uterina y sensibilidad a la palpación del útero.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Endometritis puerperal *
B) Mastitis puerperal.
C) Trombosis venosa profunda.
D) Colecistitis aguda.

Retroalimentación:
La fiebre posparto con dolor uterino, loquios fétidos y sensibilidad uterina, especialmente tras cesárea, es compatible con endometritis puerperal.

Pregunta 2
¿Cuál es un factor de riesgo importante para este padecimiento?
A) Cesárea *
B) Lactancia materna exclusiva.

C) Multiparidad aislada.
D) Suplementación con hierro.

Retroalimentación:
La cesárea aumenta el riesgo de infección puerperal por mayor manipulación uterina y exposición bacteriana, siendo uno de los factores de riesgo más importantes para endometritis.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: SARAMPIÓN
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niño de 4 años no vacunado presenta fiebre alta, tos, coriza y conjuntivitis. Dos días después desarrolla exantema maculopapular que inicia en cara y se extiende en sentido cefalocaudal. En la exploración oral se identifican pequeñas lesiones blanquecinas en mucosa yugal.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Sarampión *
B) Rubéola.
C) Varicela.
D) Escarlatina.

Retroalimentación:
La tríada de tos, coriza y conjuntivitis, seguida de exantema que inicia en la cara y lesiones de Koplik en mucosa oral, es altamente sugestiva de sarampión.

Pregunta 2
¿Cómo se llaman las lesiones blanquecinas observadas en la mucosa oral?
A) Manchas de Koplik *
B) Manchas de Bitot.
C) Pápulas de Gottron.
D) Nódulos de Heberden.

Retroalimentación:
Las manchas de Koplik son lesiones en mucosa oral consideradas casi patognomónicas de sarampión y suelen aparecer antes del exantema cutáneo.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: RUBÉOLA
Dificultad: Media

Caso Clínico
Niña de 6 años presenta fiebre baja, adenopatías retroauriculares y occipitales, además de exantema rosado fino que inicia en la cara y se disemina rápidamente al tronco. Se encuentra en buen estado general.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Rubéola *
B) Sarampión.
C) Meningococcemia.
D) Impétigo.

Retroalimentación:
La rubéola suele cursar con fiebre baja, adenopatías retroauriculares y exantema rosado de rápida progresión, generalmente con menor compromiso sistémico que el sarampión.

Pregunta 2
¿Cuál es una complicación de gran importancia en salud pública si ocurre infección materna durante el embarazo?
A) Síndrome de rubéola congénita *
B) Estenosis hipertrófica del píloro.
C) Enfermedad de Hirschsprung.
D) Atresia de vías biliares.

Retroalimentación:
La infección por rubéola durante el embarazo puede ocasionar síndrome de rubéola congénita, con malformaciones severas fetales, por lo que la prevención mediante vacunación es fundamental.

Tema: PEDIATRÍA
Subtema: INVASIÓN POR ASCARIS LUMBRICOIDES
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Escolar de 8 años con antecedente de condiciones higiénicas deficientes presenta

dolor abdominal difuso, anorexia y expulsión de un gusano por la boca después de un episodio de vómito.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Ascariasis *
B) Enterobiasis.
C) Amebiasis hepática.
D) Tenosinovitis infecciosa.

Retroalimentación:
La expulsión visible de helmintos grandes y el dolor abdominal en un contexto epidemiológico compatible orientan a infección por Ascaris lumbricoides.

Pregunta 2
¿Cuál es una complicación abdominal posible en infecciones intensas?
A) Obstrucción intestinal *
B) Aneurisma coronario.
C) Neumotórax.
D) Meningitis bacteriana.

Retroalimentación:
Las parasitosis intensas por Ascaris pueden formar masas de helmintos y causar obstrucción intestinal, especialmente en niños.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: HERIDA PENETRANTE DE TÓRAX CON NEUMOTÓRAX
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Masculino de 24 años sufre herida por arma blanca en hemitórax derecho. Presenta disnea, taquipnea y dolor torácico. A la exploración hay disminución de movimientos respiratorios y abolición del murmullo vesicular en el lado afectado.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Neumotórax traumático *
B) Derrame pericárdico crónico.
C) Crisis asmática.
D) Tromboembolia pulmonar.

Retroalimentación:
El trauma torácico penetrante con disnea y ausencia de murmullo vesicular unilateral orienta a neumotórax traumático, que puede comprometer gravemente la ventilación.

Pregunta 2
¿Cuál es un hallazgo esperado en la exploración física del lado afectado?
A) Disminución o abolición del murmullo vesicular *
B) Estertores bibasales simétricos.
C) Soplo mitral holosistólico.
D) Dolor en punto de McBurney.

Retroalimentación:
La entrada de aire al espacio pleural disminuye la expansión pulmonar del lado afectado y produce disminución del murmullo vesicular a la auscultación.

Tema: CIRUGÍA
Subtema: QUEMADURAS
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 34 años presenta lesión por escaldadura en antebrazo con ampollas, eritema intenso y dolor importante. La sensibilidad está conservada.

Pregunta 1
¿Qué profundidad de quemadura es la más probable?
A) Quemadura de espesor parcial superficial / segundo grado superficial *
B) Quemadura de primer grado exclusivamente.
C) Quemadura de tercer grado.
D) Quemadura de espesor total con necrosis completa.

Retroalimentación:
La presencia de ampollas, dolor y eritema con sensibilidad conservada orienta a una quemadura de segundo grado superficial o espesor parcial superficial.

Pregunta 2
¿Cuál es una característica típica de este tipo de quemadura?
A) Presencia de flictenas y dolor intenso *
B) Escara seca indolora.
C) Exposición de músculo.
D) Anestesia completa de la zona.

Retroalimentación:
Las quemaduras de espesor parcial suelen ser muy dolorosas debido a la conservación de terminaciones nerviosas, y con frecuencia presentan ampollas.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: SÍNDROME DE INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Dificultad: Baja

Caso Clínico
Mujer de 59 años con obesidad y antecedente de trabajo prolongado de pie presenta edema vespertino de ambas piernas, pesadez y cambios hiperpigmentados en región maleolar medial.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Insuficiencia venosa crónica *
B) Isquemia arterial aguda.
C) Celulitis bacteriana aguda.
D) Trombosis arterial femoral.

Retroalimentación:
El edema crónico de predominio vespertino, la pesadez y los cambios cutáneos por estasis son típicos de insuficiencia venosa crónica.

Pregunta 2
¿Cuál es un hallazgo cutáneo frecuente en esta enfermedad?
A) Hiperpigmentación por estasis *
B) Cianosis central.
C) Exantema malar.
D) Petequias generalizadas por púrpura trombocitopénica.

Retroalimentación:
La hipertensión venosa crónica produce cambios tróficos y depósito de hemosiderina, manifestados como hiperpigmentación en región distal de piernas.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: COLANGITIS AGUDA
Dificultad: Alta

Caso Clínico
Hombre de 62 años con antecedente de litiasis vesicular consulta por fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia. Refiere escalofríos y malestar general.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Colangitis aguda *
B) Hepatitis viral simple.
C) Gastritis aguda.
D) Colitis isquémica.

Retroalimentación:
La tríada de fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia corresponde a la tríada de Charcot, clásica de colangitis aguda.

Pregunta 2
¿Cómo se denomina la combinación clínica de fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho?
A) Tríada de Charcot *
B) Pentada de Beck.
C) Tríada de Virchow.
D) Triada de Cushing.

Retroalimentación:
La tríada de Charcot es altamente sugestiva de infección de la vía biliar, habitualmente por obstrucción asociada a litiasis.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: FIBRILACIÓN AURICULAR
Dificultad: Media

Caso Clínico
Paciente de 71 años refiere palpitaciones irregulares, fatiga y disnea leve de esfuerzo. A la exploración se documenta pulso irregularmente irregular y frecuencia cardiaca elevada.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Fibrilación auricular *
B) Flutter auricular con conducción fija.

C) Taquicardia sinusal.
D) Bloqueo AV completo.

Retroalimentación:
El hallazgo clínico de pulso irregularmente irregular es muy característico de fibrilación auricular, especialmente en pacientes de edad avanzada.

Pregunta 2
¿Cuál es una complicación importante asociada a esta arritmia?
A) Evento vascular cerebral embólico *
B) Apendicitis.
C) Pancreatitis biliar.
D) Catarata congénita.

Retroalimentación:
La fibrilación auricular favorece la formación de trombos, especialmente en la aurícula izquierda, y aumenta de forma importante el riesgo de embolia cerebral.

Tema: MEDICINA INTERNA
Subtema: INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINAS
Dificultad: Media

Caso Clínico
Mujer de 36 años es traída por somnolencia posterior a ingesta excesiva de tabletas ansiolíticas. Se encuentra estuporosa pero con signos vitales relativamente estables y sin miosis puntiforme marcada.

Pregunta 1
¿Cuál es el diagnóstico toxicológico más probable?
A) Intoxicación por benzodiacepinas *
B) Intoxicación por opioides.
C) Intoxicación por organofosforados.
D) Intoxicación por cocaína.

Retroalimentación:
La depresión del estado de conciencia con estabilidad hemodinámica relativa y antecedente de ansiolíticos sugiere intoxicación por benzodiacepinas.

Pregunta 2
¿Cuál es el antídoto específico que puede considerarse en escenarios seleccionados?

A) Flumazenil *
B) Naloxona.
C) Atropina.
D) Azul de metileno.

Retroalimentación:
El flumazenil antagoniza el efecto de las benzodiacepinas, aunque su uso debe individualizarse por riesgo de convulsiones en ciertos contextos.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Nefropatía diabética (Complicaciones Diabetes)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Hombre de 55 años con antecedente de Diabetes Mellitus tipo 2 de 12 años de evolución. Acude a su clínica para revisión de rutina. Se encuentra asintomático. A la exploración, su tensión arterial es de 145/90 mmHg. Los laboratorios generales muestran Glucosa de 160 mg/dL, Creatinina sérica de 1.1 mg/dL y un Examen General de Orina (EGO) sin alteraciones macroscópicas ni proteinuria en tira reactiva. Se le solicita una prueba de orina para determinar la relación albúmina/creatinina.

Pregunta 1

¿Cuál es el marcador clínico más temprano de daño renal (nefropatía diabética incipiente) que se busca intencionadamente con esta prueba en pacientes asintomáticos?

A) Presencia de cilindros hemáticos en el sedimento.

B) Microalbuminuria (Relación albúmina/creatinina entre 30 y 300 mg/g). *

C) Elevación de la creatinina sérica mayor a 1.5 mg/dL.

D) Disminución de la Tasa de Filtrado Glomerular por debajo de 60 ml/min.

Retroalimentación Pregunta 1:

La microalbuminuria (actualmente denominada simplemente albuminuria moderadamente incrementada, entre 30 y 300 mg/g) es el primer signo clínico y predictor de la nefropatía diabética. Ocurre mucho antes de que se eleve la creatinina sérica o de que las tiras reactivas convencionales de orina detecten proteínas (las cuales solo marcan positivo con macroalbuminuria >300 mg/g).

Pregunta 2

Si se confirma la presencia de microalbuminuria en 2 de 3 muestras recolectadas en un periodo de 3 a 6 meses, ¿cuál es el grupo farmacológico de primera elección indicado por su efecto nefroprotector (independiente del control glucémico)?

A) Betabloqueadores (Metoprolol).

B) Calcioantagonistas dihidropiridínicos (Amlodipino).

C) Inhibidores de la ECA (Enalapril) o ARA II (Losartán). *

D) Diuréticos tiazídicos (Hidroclorotiazida).

Retroalimentación Pregunta 2:

Los IECA y los ARA II son la piedra angular en el manejo de la nefropatía diabética. Su efecto nefroprotector se debe a que dilatan selectivamente la arteriola eferente del glomérulo, lo que reduce la presión hidrostática intraglomerular, disminuyendo así la hiperfiltración, la pérdida de albúmina y frenando la progresión hacia la insuficiencia renal crónica.

Especialidad: Pediatría

Tema: LLA (Oncología Pediátrica)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Preescolar masculino de 4 años de edad es llevado a urgencias por presentar fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, sin foco infeccioso aparente. La madre nota al niño pálido, muy cansado y refiere que en los últimos días se despierta llorando por intenso dolor en las piernas (dolor óseo). A la exploración física, presenta múltiples adenopatías cervicales e inguinales indoloras, hepatoesplenomegalia y lesiones petequiales en extremidades inferiores.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología y la presencia simultánea de un síndrome anémico, hemorrágico (petequias) e infiltrativo (adenopatías, hepatoesplenomegalia, dolor óseo), ¿cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?

A) Púrpura Trombocitopénica Inmunitaria (PTI).

B) Mononucleosis Infecciosa.

C) Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). *

D) Anemia Aplásica severa.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Leucemia Linfoblástica Aguda es la neoplasia maligna más frecuente en la edad pediátrica (con un pico de incidencia entre los 2 y 5 años). La proliferación descontrolada de linfoblastos infiltra la médula ósea, desplazando a las líneas celulares normales y provocando falla medular (anemia, trombocitopenia, neutropenia), además de infiltrar órganos reticuloendoteliales (hígado, bazo, ganglios) y el periostio (causando el dolor óseo severo).

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico definitivo, se debe realizar un aspirado de médula ósea (estándar de oro). ¿Qué hallazgo histopatológico confirmaría la presencia de esta leucemia aguda?

A) Presencia de 20% o más de blastos de estirpe linfoide en la médula ósea. *

B) Médula ósea hipocelular (vacía) con reemplazo por tejido graso.

C) Presencia de células gigantes multinucleadas de Reed-Sternberg.

D) Detección de cuerpos de Auer en el citoplasma de las células maduras.

Retroalimentación Pregunta 2:

El diagnóstico confirmatorio de una leucemia aguda se establece al documentar en el aspirado o biopsia de médula ósea una infiltración por blastos (células inmaduras) igual o mayor al 20% (algunas guías antiguas marcaban 25%). Los estudios de inmunofenotipo y citogenética se encargan posteriormente de clasificar exactamente el subtipo (B o T) y el pronóstico. (Los cuerpos de Auer son típicos de la Leucemia Mieloide, no de la linfoide).

Especialidad: Cirugía

Tema: Quemaduras eléctricas (Quemaduras)

Dificultad: Alta

Caso Clínico

Varón de 35 años de edad, de oficio electricista, ingresa a urgencias traído por paramédicos tras sufrir una descarga eléctrica accidental de alta tensión (10,000 voltios). Presenta una herida de entrada pequeña pero carbonizada en la mano derecha y una herida de salida en el pie izquierdo. El paciente está consciente, taquicárdico, y se queja de un dolor insoportable en el brazo derecho. A la exploración, el miembro superior derecho está sumamente tenso, edematizado, con pulsos radial y cubital ausentes, y cianosis en los dedos. La orina recolectada tras colocar una sonda Foley es de color "rojo vino" (oscura).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico que explica la tensión del brazo, el dolor desproporcionado y la pérdida de pulsos, el cual constituye una urgencia quirúrgica inmediata?

A) Trombosis venosa profunda secundaria al trauma.

B) Síndrome compartimental. *

C) Choque cardiogénico por arritmia.

D) Celulitis necrotizante aguda.

Retroalimentación Pregunta 1:

Las quemaduras por electricidad de alta tensión causan destrucción masiva de los tejidos profundos (músculos y vasos) a lo largo del trayecto de la corriente, aunque la piel superficial parezca indemne. El edema muscular severo dentro de una fascia inextensible genera un síndrome compartimental agudo, caracterizado por las "5 P" (Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis). El tratamiento es la fasciotomía de urgencia para descomprimir y salvar la extremidad.

Pregunta 2

La coloración oscura de la orina es altamente sugestiva de mioglobinuria secundaria a la rabdomiólisis masiva. Para prevenir la insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, ¿cuál es el objetivo terapéutico de diuresis horaria que debe mantenerse durante la reanimación hídrica agresiva en este paciente?

A) 0.5 ml/kg/hora.

B) 1 a 2 ml/kg/hora (aproximadamente 75-100 ml/hora en un adulto). *

C) 5 a 10 ml/kg/hora.

D) Mantener anuria para evitar sobrecarga de volumen.

Retroalimentación Pregunta 2:

A diferencia de las quemaduras térmicas clásicas (donde el objetivo es 0.5 ml/kg/hr en adultos), en las quemaduras eléctricas con sospecha o evidencia de mioglobinuria/rabdomiólisis, la reanimación hídrica debe ser mucho más agresiva. Se

busca mantener una diuresis elevada (1 a 2 ml/kg/hora o 75-100 ml/hora) para literalmente "lavar" la mioglobina de los túbulos renales, evitando que precipite y cause insuficiencia renal aguda, frecuentemente apoyándose en la alcalinización de la orina.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Amenorrea (Endocrinología Ginecológica)

Dificultad: Media

Caso Clínico

Mujer de 16 años de edad es llevada a consulta por su madre debido a la ausencia de la menarquia (primera menstruación). Refiere buen estado de salud general. A la exploración física destaca: talla baja (1.42 m), cuello ancho y alado (pterigium colli), implantación baja del cabello en la nuca, tórax en escudo (teletelia) y mamas de desarrollo incipiente (Tanner II). El ultrasonido pélvico reporta un útero de tamaño infantil y ovarios que no se logran visualizar con claridad (aspecto de "cintillas").

Pregunta 1

De acuerdo con las características fenotípicas clásicas de la paciente, ¿cuál es el diagnóstico genético y clínico más probable que justifica esta amenorrea primaria?

A) Síndrome de Rokitansky (Agenesia mülleriana).

B) Síndrome de Turner (Disgenesia gonadal). *

C) Síndrome de Morris (Insensibilidad a los andrógenos).

D) Hiperplasia suprarrenal congénita clásica.

Retroalimentación Pregunta 1:

El Síndrome de Turner (generalmente asociado a un cariotipo 45,X0) es la causa más común de amenorrea primaria por disgenesia gonadal. Las pacientes presentan un fenotipo característico: talla baja, alteraciones somáticas (cuello alado, tórax ancho) e infantilismo sexual debido a que sus ovarios involucionan antes del nacimiento o poco después, quedando como tejido fibroso inactivo (ovarios en cintilla).

Pregunta 2

Al solicitar un perfil hormonal basal en esta paciente, ¿cuál sería el patrón endocrinológico esperado que confirmaría el origen ovárico de la falla?

A) FSH y LH elevadas, Estradiol bajo (Hipogonadismo hipergonadotrófico). *

B) FSH y LH bajas, Estradiol bajo (Hipogonadismo hipogonadotrófico).

C) FSH y LH normales, Estradiol elevado.

D) Prolactina muy elevada, TSH disminuida.

Retroalimentación Pregunta 2:

Al existir disgenesia gonadal, los ovarios son incapaces de producir estrógenos (estradiol bajo). Esto elimina la retroalimentación negativa que normalmente ejercen los ovarios sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Como respuesta compensatoria, la hipófisis secreta cantidades masivas de gonadotropinas, resultando en niveles elevados de FSH y LH (hipogonadismo hipergonadotrófico).